

 FTE на візити

	Ендокринолог	1 візит	2 візит	3 візит	4 візит	5 візит	6 візит
ЩЗ	Тірбізог	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Селефікс	25%	25%	25%	25%	25%	25%
ЦД	Шугарг	30%	20%	30%	20%	30%	20%
	Глікоміцел	20%	30%	20%	30%	20%	30%
	Лібера Аргінін						

	Гастро	1 візит	2 візит	3 візит	4 візит	5 візит	6 візит
СПК	Бутрикол		50%		50%		50%
	Есбуларгі		50%		50%		50%
Гастро	Еупатилекс	20%		20%		20%	
	Пантофітол	30%		30%		30%	
	Мастикозин	40%		40%		40%	
	Тараксен						
	Тривітафер	10%		10%		10%	

	Невролог	1 візит	2 візит	3 візит	4 візит	5 візит	6 візит
ДЕП та стрес	Гіпоміцел	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Нейромінерій	30%	20%	30%	20%	30%	20%
	Тривітафер	20%	30%	20%	30%	20%	30%

АПТЕКА	1 візит	2 візит	3 візит	4 візит	5 візит	6 візит
Бутрикол	40%	40%	25%	20%	5%	5%
Тірбізог	10%	20%	30%	30%	20%	10%
Еупатилекс	20%	10%	10%	10%	30%	10%
Есбуларгі	15%	20%	10%	5%	10%	20%
Мастикозин	10%	5%	20%	10%	10%	40%
Пантофітол	5%	5%	5%	25%	25%	15%
Гіпоміцел						
Нейромінерій						
Тривітафер						
Селефікс						
Глікоміцел						
Тараксен						



ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ



БУТРИКОЛ



Дієтична добавка

Бутрикол® Butrykol

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Інгредієнт:	1 капсула	Максимальна добова кількість (2 капсули)
трибутирин	450 мг (mg), (що відповідає 394 мг (mg) масляної кислоти)	900 мг (mg), (що відповідає 788 мг (mg) масляної кислоти)

Склад: трибутирин (90 %); наповнювач: соняшникова олія; консервант: DL-альфа-токоферол (вітамін E); оболонка м'якої желатинової капсули: (желюючий агент: желатин, наповнювач: вода очищена, вологоутримуючий агент: гліцерин, вологоутримуючий агент: сорбітол, ароматизатор «Вишня», консервант: сорбат калію, харчовий барвник: азорубін).

Трибутирин – це тригліцерид, що складається з масляної кислоти та гліцерину. Масляна кислота належить до жирних кислот з коротким вуглецевим ланцюгом, яка утворюється в товстому кишківнику в процесі [мікроорганізмowego](#) травлення сахаролітичною мікрофлорою (бактероїдами, біфідобактеріями, фузобактеріями, пептострептококами, клостридіями).

Рекомендації щодо споживання: в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело масляної кислоти.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1-2 капсули на добу під час прийому їжі. Капсули слід ковтати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 3-4 тижні. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів дієтичної добавки, дитячий вік до 18 років, період вагітності та годування груддю.

Форма випуску: по 10 м'яких желатинових капсул у блістері, по 1 блістеру в упаковці. Маса нетто 1 капсули: 500 мг (mg) $\pm$ 7,5 %.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника (фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва):

ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

Контроль якості!

Ваші відгуки і пропозиції приймаємо на електронну пошту

quality@behealth.com.ua

1.Картка продукту

БУТРИКОЛ

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Бутрикол – єдиний в Україні постбіотик з трибутирином, що демонструє високу ефективність при захворюваннях кишківника
ЯКИЙ:

1. живить енергією клітини кишківника,
2. підтримує цілісність кишкового бар'єру,
3. знижує ризик запальних процесів та розвитку синдрому підвищеної проникності

ТОМУ ЩО МІСТИТЬ:

- ТРИБУТИРИН - високобіодоступний тригліцерид з трьома молекулами масляної кислоти, яка поступово всмоктується в тонкому і особливо товстому кишківнику, - там, де він найбільше необхідний! Без неприємного запаху!

КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Бутрикол – єдиний в Україні постбіотик з **трибутирином**, що демонструє високу ефективність при захворюваннях кишківника.

МЕХАНІЗМ ДІЇ БУТРИКОЛ



1. Живлення клітин кишечника

- **Масляна кислота є основним джерелом енергії** для епітеліальних клітин кишечника - поглинається клітинами кишкової слизової оболонки та окислюється у мітохондріях для отримання енергії АТФ.
- МК підтримує зростання, відновлення та нормальне функціонування епітеліальних клітин кишечника.
- **Забезпечується швидке загоєння** ушкоджених ділянок слизової оболонки кишечника.

2. Стимуляція келихоподібних клітин до продукції муцину

- **Муцин** – це основний компонент слизового шару, який вистилає кишечник. Він утворює фізичний бар'єр між мікробіотою та епітеліальними клітинами кишечника. Цей бар'єр захищає кишечник від проникнення патогенних мікроорганізмів та токсинів.

- МК стимулює колоноцити до продукції антимікробних пептидів (нейтралізують шкідливі бактерії) і імуноглобулінів IgA(сприяють місцевому імунітету).

3.Відновлення бар'єрної функції

- **Масляна кислота** стимулює вироблення білків, таких як клаудини та оклудини, які формують щільні міжклітинні з'єднання – таким чином зміцнює міжклітинні зв'язки, відновлюючи цілісність епітеліального бар'єру.
- Таким чином запобігає проникненню токсинів, алергенів та патогенів через слизову оболонку кишківника, знижуючи ризик синдрому підвищеної кишкової проникності.

4.Протизапальна дія

- **Масляна кислота** діє як протизапальний медіатор, впливаючи на регуляцію імунної відповіді:
 1. знижує рівень прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α).
 2. стимулює вироблення протизапальних речовин, таких як IL-10.
- Це сприяє зменшенню запалення при синдромі подразненого кишківника (СПК), виразковому коліті та хворобі Крона.
- МК діє як сигнальна молекула, взаємодіючи з рецепторами епітеліальних та імунних клітин (наприклад, GPR43, GPR109A) – стимулює імунну відповідь.

5.Підтримка здорової мікробіоти

- Масляна кислота створює сприятливе середовище для росту корисних бактерій (лакто- і біфідобактерій).
- Масляна кислота також пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів.

- Відновлення мікробіоти сприяє нормалізації травлення та загального здоров'я кишківника.

1.Конкуренти

КЛЮЧОВІ КОНКУРЕНТИ

ЗАФАКОЛ



Склад:

1. Масляна кислота - 250 мг,
2. Інулін - 100 мг,
3. *Lactobacillus helveticus* $3,0 \times 10^9$ КУО (CFU),
4. *Bifidobacterium Longum* $3,18 \times 10^8$ КУО (CFU),
5. вітамін D3 - 600 МО

Спосіб застосування:

Дітям з 12 років та дорослим:

- *Загострення ЗЗК* по 1 таблетці 3 рази на добу після їжі
- *Профілактика рецидиву ЗЗК, відновлення кишкового бар'єру, функціональні порушення, дисбіотичний синдром, Long COVID* по 1 таблетці 1-2 рази на добу після їжі

Масляна кислота (Butyric acid) - Це коротколанцюгова жирна кислота (КЖК), яка природно утворюється в кишківнику внаслідок ферментації клітковини мікробіотою.

Має важливе значення для:

- живлення ентероцитів (клітин слизової оболонки кишківника),

- підтримки бар'єрної функції,
- регуляції імунних процесів.

Мінус: у вільній формі дуже швидко всмоктується у верхніх відділах ШКТ (шлунок, тонкий кишечник), через що не доходить у достатній кількості до товстого кишечника. Також має різкий неприємний запах

ХПВ

1. Бутрикол **містить більшу концентрацію активної форми масляної кислоти**, що забезпечить, ефективніше відновлення слизової оболонки та зниження запалення, на відміну від комбінованого препарату (Зафакол), який містить всього 250 мг масляної кислоти.

2. Зафакол містить Інулін та біфідобактерії, рекомендована добова доза:

- Інулін: 5–10 г/добу (EFSA, WHO) в Зафакол 0,1-0,2г
- *Bifidobacterium longum*: ефективні дози 1×10^9 – 1×10^{10} /день (в Зафакола $3,18 \times 10^8$ КУО (CFU))

Дані складники не відповідають нормам навіть за умов прийняття 2 таблеток на добу, що не буде мати, якогось терапевтичного ефекту для пацієнтів

3. Бутрикол випускається в капсулах, що **забезпечує захист вмісту**

– Капсула захищає активний інгредієнт від вологи, повітря і світла

– Вища стабільність діючої речовини

Маскування смаку та запаху (вишня яка маскує додатково)

– Ідеально для чутливих пацієнтів (особливо у людей з нюховою/смаковою чутливістю)

Краще проходження через ШКТ

– Оболонка капсули може забезпечити захист у шлунку та вивільнення в кишечнику.

На відміну від таблетованої форми, яка може бути неприємна на смак та запах, оскільки бутират має дуже різкий запах та смак

БУТРИКОЛ



ЗАФАКОЛ



Бутрикол містить: трибутирин 450 мг (mg) (що відповідає 394 мг (mg) масляної кислоти)



Бутрикол має лікарську форму у вигляді капсул, що містить ароматизатор Вишні



Трибутирин — це стабільна форма масляної кислоти, яка не руйнується в шлунку і ефективно досягає товстої кишки, де діє безпосередньо



Зафакол містить: масляна кислота 250 мг



Має форму таблеток, тому частина поживних елементів може просто не дійти до кишківника; таблетки можуть мати неприємний смак за рахунок масляної кислоти;



починає швидше розщеплюватись в шлунку, яке менш контрольоване, менше МК досягає ТК

КОЛОНЗАК



Склад:

1. Масляна кислота - 250 мг
2. Фруктоолігосахариди (інулін) - 100 мг

3. Bifidobacterium bifidum Bb-06 SD6576 18 мг (mg) $1,8 \times 10^9$ КУО (CFU)
4. Bifidobacterium lactis BI-04 ATCC SD5219 1,8 мг (mg) $0,9 \times 10^9$ КУО (CFU)

Показання до використання

Дієтична добавка до раціону харчування - додаткове джерело масляної кислоти, інуліну та біфідобактерій, сприяє підтримці нормальної функції товстого кишечника в тому числі у осіб, що мають синдром подразненого кишечника. Завдяки комплексній дії Колонзак™ сприяє усуненню дискомфорту в області кишечника (здуття, відчуття важкості), регуляції стулу та покращенню якості життя (психо-емоціональний стан) людини.

Бутират кальцію (Calcium butyrate) Це сіль масляної кислоти з кальцієм.

- Також стабільніша форма, менш летюча, ніж вільна кислота.
- Має схожі властивості з натрієвою сіллю, але дає ще додатковий внесок кальцію.

Недолік той самий – швидке вивільнення в проксимальних відділах ШКТ.

ХПВ

1. **Бутрикол містить більшу концентрацію активної форми масляної кислоти**, що забезпечить, ефективніше відновлення слизової оболонки та зниження запалення, на відміну від комбінованого препарату (Колонзак), який містить всього 250 мг масляної кислоти.
2. Більш ефективна форма масляної кислоти - Трибутирин — єдина форма, що: захищена від розпаду в шлунку, повністю досягає товстого кишечника, залишається довше й діє глибше. Пацієнт отримує тільки необхідне та ефективне лікування. На відміну від препарату з бутиратом кальцію, який швидко вивільняється в проксимальних відділах ШКТ
3. При використанні Бутриколу - менша ймовірність побічних ефектів, викликаних пребіотиками або пробіотиками, які є у

складі іншого препарату з масляною кислотою, що вбереже
ваших пацієнтів від газоутворення, здуття та підвищить
прихильність до лікування

Пацієнти, яким бутират кальцію небажаний:

1. Пацієнти з нефролітіазом (камінці нирок)

зайвий кальцій — фактор ризику каменеутворення

2. Пацієнти з гіперкальціємією або ризиком її розвитку

особливо на фоні гіперпаратиреозу

**3. Пацієнти з остеопорозом, які вже отримують високі дози
кальцію**

додаткові солі кальцію небажані

4. Пацієнти з порушеннями обміну кальцію

хронічна ниркова недостатність

гіпертонія з обмеженням кальцію

БУТРИКОЛ



Бутрикол містить: трибутирин 450 мг (mg) (що відповідає 394 мг (mg) масляної кислоти)



Трибутирин — це стабільна форма масляної кислоти, яка не руйнується в шлунку і **ефективно досягає товстої кишки**, де діє безпосередньо



Бутрикол має лікарську форму у вигляді капсул, що містить ароматизатор Вишні



КОЛОНЗАК



Колонзак містить: **250 мг бутирата кальцію/капсула** ($\approx$ 219 мг масляної кислоти)



бутират кальцію частково нейтралізується в кислому середовищі



Стандартна капсула (гіпромелоза), нейтральна — може мати неприємний запах/смак за рахунок масляної кислоти

ДЕБУТІР ФОРТЕ



Склад

- Одна капсула Дебутір містить 600 мг гранульованого бутирату натрію з повністю гідрогенізованою рослинною олією, що відповідає 300 мг бутирату натрію.

Склад: натрію бутират, повністю гідрогенізована рослинна олія, оболонка капсули: гідроксипропілметилцелюлоза, загущувач альгінат натрію, барвник капсули (барвник карбонат кальцію; оксид цинку, крохмаль, мальтодекстрин, стабілізатор гуміарабік) емульгатор - моно- та дигліцериди жирних кислот, гелеутворювачі: каррагінан, хлорид калію.

У чому інновація ДЕБУТІР ФОРТЕ?

- Масляна кислота (бутират) є основним енергетичним матеріалом для кишкового епітелію.
- Застосування сучасної технології гранулювання бутирату натрію, на відміну від стандартних форм масляної кислоти,

захищає її від повної утилізації у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту і дає можливість доставляти діючу речовину в тонкий і товстий кишечник. Гранули розроблені таким чином, щоб процес виділення бутирату натрію відбувався по всій довжині тонкої та товстої кишки.

Бутират натрію (Sodium butyrate) - Це сіль масляної кислоти з натрієм.

-Стабільніший, ніж чиста кислота, має менший запах.

-Використовується у дієтичних добавках та ветеринарії.

Недолік: як і масляна кислота, може швидко вивільнятися та всмоктуватися, не завжди досягаючи товстого кишечника. Для подолання цього роблять КИШКОВОРОЗЧИННІ капсули або мікрокапсульовані форми.

ХПВ

1. Дебутір має в складі натрієву сіль — натрій у пацієнтів може мати ризики (наприклад, при серцево-судинних, артеріальній гіпертензії тощо). Бутрикол — трибутирин без надлишку натрію, що дозволить Вашим пацієнтам отримати ефективне лікування без ризику побічних реакцій зі сторони серцево-судинної системи.
2. Натрієвий бутират часто:
 - має виражений запах,
 - дає відрижку «масляним» присмаком,
 - викликає ризик газоутворення.

Трибутирин **позбавлений цих негативів**, що значить **кращий комплаєнс і дотримання курсу**.

3. Дебутір у багатьох ситуаціях призначається короткими курсами. Бутрикол можна застосовувати **1–3 місяці і більше** без ризику дисбалансу електролітів і натрієвого навантаження.

БУТРИКОЛ



Бутрикол містить: трибутирин 450 мг (mg) (що відповідає 394 мг (mg) масляної кислоти)



Трибутирин — це стабільна форма масляної кислоти, яка не руйнується в шлунку і ефективно досягає товстої кишки, де діє безпосередньо



Бутрикол має лікарську форму у вигляді капсул, що містить ароматизатор Вишні



ДЕБУТІР



містить 600 мг гранульованого бутирату натрію з повністю гідрогенізованою рослинною олією, що відповідає 300 мг бутирату натрію



Містить бутират натрію, менш стабільна форма МК



Без ароматизатора, може мати неприємний запах/смак

ІНЕСТІН



СКЛАД:

Активний інгредієнт:

- кальцію бутират (масляна кислота) – 500 мг (mg).

Допоміжні речовини: (кукурудзяний мальтодекстрин, загущувач гідроксипропілметилцелюлоза, антиспікаючий агент магнієві солі жирних кислот; оболонка: глазуруючий агент шелак, загущувач гідроксипропілметилцелюлоза, антиспікаючий агент тальк.

Бутират кальцію (Calcium butyrate) Це сіль масляної кислоти з кальцієм.

-Також стабільніша форма, менш летюча, ніж вільна кислота.

- Має схожі властивості з натрієвою сіллю, але дає ще додатковий внесок кальцію.

Недолік той самий – швидке вивільнення в проксимальних відділах ШКТ.

ХПВ

1. Бутрикол безпечний для використання у пацієнтів з цукровим діабетом, оскільки не містить мальтодекстрина, на відміну від іншого препарату (Інестин)
2. Більш ефективна форма масляної кислоти Трибутирин — єдина форма, що: захищена від розпаду в шлунку, повністю досягає товстого кишечника, залишається довше й діє глибше. Пацієнт отримує тільки необхідне та ефективне лікування. На відміну від кальцію бутират, який не такий стійкий до соляної кислоти.
3. Бутрикол випускається в капсулах, що **забезпечує захист вмісту**
 - Капсула захищає активний інгредієнт від вологи, повітря і світла
 - Вища стабільність діючої речовини

Маскування смаку та запаху (вишня яка маскує додатково)

 - Ідеально для чутливих пацієнтів (особливо у людей з нюховою/смаковою чутливістю)

Краще проходження через ШКТ

– Оболонка капсули може забезпечити захист у шлунку та вивільнення в кишечнику.

На відміну від таблетованої форми, яка може бути неприємна на смак та запах, оскільки бутират має дуже різкий запах та смак

4. Пацієнт отримує якісне лікування за доступною ціною, за рахунок трибутирину, який починає діяти в кишківнику, там де він необхідний, На відміну від іншого препарату, який містить бутират кальцію, який швидко вивільняється в проксимальних відділах ШКТ

Пацієнти, яким бутират кальцію небажаний:

1. Пацієнти з нефролітіазом (камінці нирок)

зайвий кальцій — фактор ризику каменеутворення

2. Пацієнти з гіперкальціємією або ризиком її розвитку

особливо на фоні гіперпаратиреозу

3. Пацієнти з остеопорозом, які вже отримують високі дози кальцію

додаткові солі кальцію небажані

4. Пацієнти з порушеннями обміну кальцію

хронічна ниркова недостатність

гіпертонія з обмеженням кальцію

АЛЪТІКА



СКЛАД:

1. Бутират кальцію 250 mg (мг)
2. Інулін (з цикорію) 100 mg (мг)
3. L-триптофан 50 mg (мг)
4. *Lactobacillus acidophilus* HA-122 не менше 1×10^9 КУО/г (CFU/g)
5. *Lactobacillus plantarum* HA-119 не менше 1×10^9 КУО/г (CFU/g)

Бутират кальцію (Calcium butyrate) Це сіль масляної кислоти з кальцієм.

-Також стабільніша форма, менш летюча, ніж вільна кислота.

- Має схожі властивості з натрієвою сіллю, але дає ще додатковий внесок кальцію.

Недолік той самий – швидке вивільнення в проксимальних відділах ШКТ.

Пацієнти, яким бутират кальцію небажаний:

1. Пацієнти з нефролітіазом (камінці нирок)

зайвий кальцій — фактор ризику каменеутворення

2. Пацієнти з гіперкальціємією або ризиком її розвитку

особливо на фоні гіперпаратиреозу

3. Пацієнти з остеопорозом, які вже отримують високі дози кальцію

додаткові солі кальцію небажані

4. Пацієнти з порушеннями обміну кальцію

хронічна ниркова недостатність

гіпертонія з обмеженням кальцію

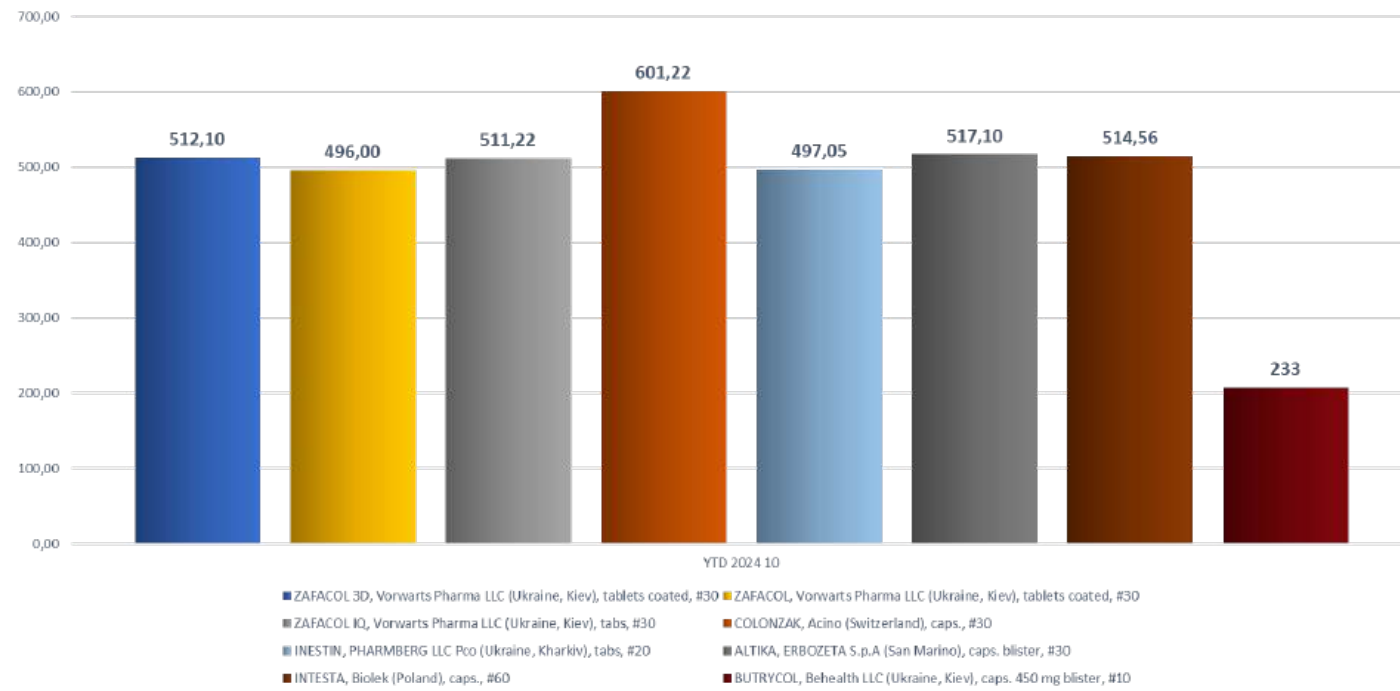
ХПВ

1. Бутрикол містить більшу концентрацію активної форми масляної кислоти, що забезпечить, ефективніше відновлення слизової оболонки та зниження запалення, на відміну від комбінованого препарату, який містить всього 250 мг масляної кислоти.
2. Альтіка містить в своєму складі: L-триптофан - терапевтичні дози часто починаються з 250–1000 мг/доба (кількість яка є в Альтіці недостатня) Інулін (з цикорію) 100 mg (мг) - 100 мг — незначна доза, що не покриває потребу для вираженого пребіотичного ефекту (Добова норма (EFSA/EC): від 3 до 10 г) - що не несе терапевтичного ефекту для пацієнта, на відміну від Бутрикола, який містить унікальну формулу трибутирин, який є донатором 3х молекул масляної кислоти, який доходить до кишківника в максимальній концентрації, що дозволить Вашому пацієнту отримувати ефективне лікування без непотрібних додаткових складників.

ПЕРЕВАГИ БУТРИКОЛУ ПЕРЕД
КОНКУРЕНТАМИ

СКЮ	Трибутирин	Масляна к-та	Бутират кальцію	Гранульований бутират натрію
БУТРИКОЛ капс. №10	450 (394)			
Альтіка капсули №30			250 (219)	
Зафакол IQ таб №30		250		
Інестін табл. 500 мг №20			500 (438)	
Колонзак капс. №30			250 (219)	
Дебутір Форте капсули по 300 мг, 60 шт				600 (300)

* в дужках позначено еквівалент масляної кислоти



1.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: БУТРИКОЛ

Гастроентеролог:

- СПК (з болем/діареєю/змішаним типом)
- Постінфекційний та інфекційний СПК
- Синдром підвищеної проникності кишківника
- Мікроскопічний коліт
- Підтримка при ЗЗК (хвороба Крона та Виразковий коліт)
- Неспецифічні хвороби товстої кишки – Радіаційний коліт, Токсичний коліт (НПЗП – коліт), Алергічний коліт, Ішемічний коліт
- Дивертикулярна хвороба та Дивертикуліт
- Функціональний запор
- Дисбіотичний синдром – спазм або біль, здуття, порушення випорожнень, неприємні відчуття в кишечнику

Колопроктолог:

- ЗЗК (хвороба Крона, Виразковий коліт)
- Дивертикулярна хвороба+Дивертикуліт
- Після діагностичних та оперативних втручань на кишечнику (колоноскопії, поліпектомії кишечника, операції з приводу тріщин анального проходу та геморою)
- Мікроскопічний коліт
- Хронічний проктит

Сімейний лікар/ терапевт:

- Хронічні кишкові дисфункції
- «чутливий кишечник»
- наслідки антибіотикотерапії
- Дисбіотичний синдром – спазми або біль, здуття, порушення випорожнень, неприємні відчуття в кишечнику
- Пацієнти, які постійно скаржаться на больові відчуття в животі, диспепсичні симптоми (здуття, метеоризм), порушення стільця.
- Long COVID

Ендокринолог:

- Метаболічний синдром + дисбіоз,
- НАЖХП із кишковим компонентом
- ЦД 1 та 2 тип

Дієтолог:

- Підтримка слизової та мікробіому під час зміни харчування
- FODMAP-пацієнти

СКРИПТИ: БУТРИКОЛ

1.СПК (З БОЛЕМ / ДІАРЕЄЮ / ЗМІШАНИМ ТИПОМ)

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у ваших пацієнтів зі СПК, окрім болю та здуття, є чітка реакція на їжу, нестабільний стул та «чутлива» слизова?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів є знижений рівень масляної кислоти — головного енергетичного субстрату для ентероцитів та колоноцитів. Через це слизова виснажена, бар'єр не працює стабільно».

I — Наслідки

«Без відновлення бар'єра й трофіки кишківника, симптоми не минають повністю — навіть при дотриманні дієти та терапії. Це формує хронічний перебіг та часті повторні візити».

N — Рішення (Бутрикол)

«Бутрикол, який містить трибутирин – донатор 3 молекул масляної кислоти, розпадається під дією ліпази в 12п кишці, тому доходить в максимальній концентрації в товстий кишківник. Він:

- живить ентероцити,
- знижує запалення,
- стабілізує моторну відповідь,
- відновлює бар'єр.

Тому симптоми СПК зменшуються швидше та стабільніше.

Порекомендуєте 3–5 пацієнтам, в яких, на Вашу думку, є недостатність масляної кислоти?»

2. ПОСТІНФЕКЦІЙНИЙ СПК

S — Ситуація

«Чи спостерігаєте зараз пацієнтів, у яких після перенесеної інфекції діарея пройшла, але залишилися здуття, нестабільний стул і непереносимість продуктів?»

P — Проблема

«Після інфекції рівень масляної кислоти різко падає — бар'єр руйнується, слизова запалена, і пацієнти довго не повертаються до нормального стану».

I — Наслідки

«Поки не відновити масляну кислоту та бар'єр, симптоми триватимуть місяцями. Це затягує лікування і знижує якість життя».

N — Рішення (Бутрикол)

«Бутрикол – який містить трибутирин дає можливість адресно відновити слизову:

- нормалізує бар'єр,
- знижує запалення після токсинів і діареї,
- пришвидшує повернення до нормального стулу.

Бутрикол добре працює після будь-яких гострих інфекцій.

Можемо додати його в схему постінфекційного СПК для оцінки ефекту 3-5 пацієнтам?»

3. Синдром підвищеної проникності кишківника (“leaky gut”)

S — Ситуація

«Чи бачите зараз пацієнтів, у яких немає явної органічної патології, але є постійне здуття, реакція на продукти та «зриви» травлення?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів - підвищена проникність кишківника, що є наслідком дефіциту масляної кислоти».

I — Наслідки

«Поки бар'єр «дірявий», пацієнт буде ходити по колу: дієта → коротке полегшення → рецидив. Це виснажує і лікаря, і пацієнта».

N — Рішення (Бутрикол)

«Масляна кислота — ключ для нормальної бар'єрної функції.

Бутрикол:

- відновлює кишковий бар'єр,
- зменшує проникність,
- знижує запалення,
- стабілізує реакцію на їжу.

Пацієнт відчуває реальне покращення за 2–3 тижні.

Чи порекомендуєте Ви Бутрикол 3-5 пацієнтам з підозрою на “leaky gut”?»

4. Мікроскопічний коліт

S — Ситуація

«У ваших пацієнтів із мікроскопічним колітом часто зберігається водяниста діарея навіть після терапії?»

P — Проблема

«У таких пацієнтів завжди є глибоке ушкодження слизової та дефіцит масляної кислоти. Стандартне лікування не відновлює бар'єр».

I — Наслідки

«Через незакритий бар'єр рецидиви стають частими, діарея зберігається, а якість життя різко падає».

N — Рішення

«Бутрикол — єдина стабільна форма трибутирину- донатора 3 молекул масляної кислоти:

- відновлює епітелій,
- зменшує запалення,
- допомагає утримувати ремісію,
- знижує інтенсивність діареї.

Це ефективна підтримка після базової терапії.

Можемо додати в лікування пацієнтів з мікроскопічним колітом Бутрикол на 2–3 місяці?»

5. Підтримка при ЗЗК (хвороба Крона / ВК) у ремісії

S — Ситуація

«Бачите пацієнтів із Крона або ВК, у яких, попри ремісію, зберігається здуття, чутливість слизової та нестабільний стул?»

P — Проблема

«У період ремісії дуже часто зберігається виражений дефіцит масляної кислоти. Слизова не відновлена до кінця — це головний фактор рецидивів».

I — Наслідки

«Без корекції трофіки слизової пацієнт швидше “вилітає” з ремісії, потребує корекції терапії та частіше звертається за допомогою».

N — Рішення (Бутрикол)

«Масляна кислота — ключовий нутрієнт для загоєння слизової.

Бутрикол:

- знижує субклінічне запалення,
- продовжує ремісію,
- покращує переносимість їжі,
- зменшує здуття та нестабільний стул.

Це оптимальна підтримка між загостреннями.

Готові порекомендувати 3-5 пацієнтам у ремісії?»

ЗАГАЛЬНИЙ СКРИПТ ВІЗИТУ

Вступна частина:

Доброго дня! Як завжди, радий/а бачити Вас.

Хотів/ла б обговорити сучасний підхід до терапії СПК і представити препарат, який може бути корисним у Вашій практиці.

Опис ситуації:

Як Ви оцінюєте поширеність таких захворювань, як синдром подразненого кишківника серед Ваших пацієнтів?

Я впевнений/а, що кожного дня до Вас звертаються пацієнти, які скаржаться на здуття, хронічний дискомфорт у кишківнику або запори?

Проблематика:

Як правило, пацієнти з такими симптомами потребують комплексного підходу, включаючи корекцію мікробіоти, зменшення запалення та відновлення кишкового бар'єру. Які препарати ви обираєте найчастіше?

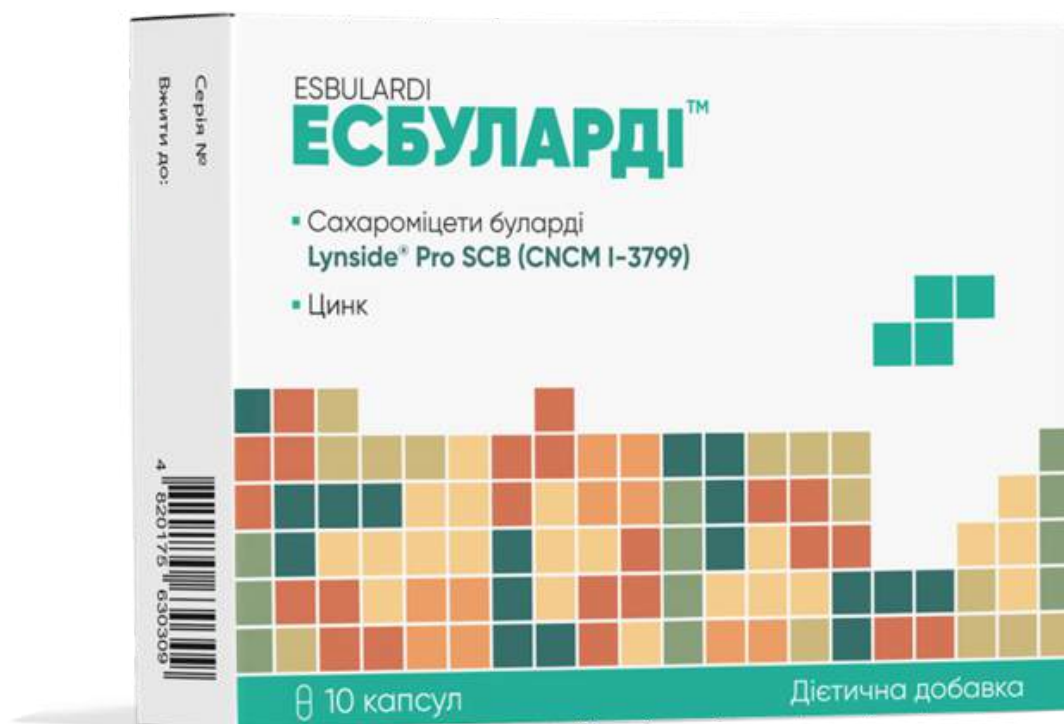
Актуалізація:

Як Ви вважаєте, якщо не вирішити цю проблему, чи може це призвести до хронізації запальних процесів, ускладнень або навіть зниження якості життя пацієнта. Чи згодні Ви, що препарати, які працюють саме в товстому кишківнику, здатні вирішити ці питання більш ефективно?

Направлення:

Що для Вас є ключовим при виборі препарату для пацієнтів із СПК? Я впевнений/а, що ви хочете обрати найбільш ефективний (безпечний, зручний) засіб.

ЕСБУЛАРДІ



Дієтична добавка

Есбуларді® Esbulardi

Листок-вкладиш (Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Інгредієнти:	1 капсула	Максимальна добова кількість (2 капсули)
сахароміцети буларді (Lynside® Pro SCB) (Saccharomyces boulardii CNCM I-3799)	250 мг	500 мг
цинк (у формі глюконату цинку)	10 мг,	20 мг, що відповідає 200 %*

	що відповідає 100 %*	
--	----------------------------	--

**- відсоток від добової потреби у мінеральних речовинах для дорослих (осіб від 18 років).*

Склад: сахароміцети буларді (Lynside® Pro SCB) (*Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799) (55,6 %), наповнювач: мальтодекстрин; цинк (у формі глюконату цинку) (2,2 %); оболонка капсули: желатин, барвник: оксид цинку.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело пробіотичних дріжджів та цинку.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1-2 капсули на добу. Не слід змішувати з дуже гарячими (понад 50 °C) або холодними напоями, їжею, рідинами, що містять алкоголь.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 10–14 діб. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодоці та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: вагітність та період лактації, дитячий вік, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 450 мг $\pm$ 7,5 % №10 у блістері, упакованому у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, проспект Правди, 80-В.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС»,

Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

Контроль якості!

Ваші відгуки і пропозиції приймаємо на електронну пошту

quality@behealth.com.ua

2.Картка продукту

ЕСБУЛАРДІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Есбуларді — пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком при СПК та ААД.

ЯКИЙ:

- стійкий до дії шлункового соку та антибіотиків
- нормалізує мікрофлору кишківника та посилює імунітет
- швидко зупиняє діарею
- ефективно усуває симптоми СПК
- має склад та дозування згідно рекомендацій ВООЗ

ТОМУ ЩО:

- Сахароміцети нейтралізують патогени та токсини, гальмують секрецію води та електролітів у просвіт кишківника
- Цинк відновлює цілісність слизового бар'єру кишківника та стимулює вироблення антитіл проти кишкових патогенів
- Завдяки природній резистентності можливий одночасний прийом з антибіотиками

ЕСБУЛАРДІ КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Есбуларді — пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком при СПК та ААД.

ЕСБУЛАРДІ МЕХАНІЗМ ДІЇ

1. Нейтралізація бактеріальних токсинів

Saccharomyces boulardii вивільняють протеолітичні ферменти, які руйнують токсини патогенних бактерій:

Toxin A і B *Clostridium difficile* → фермент буларді розщеплює їх, запобігаючи пошкодженню епітелію кишечника.

Ентеротоксини *E. coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae* → блокуються або частково інактивуються.

2. Блокування адгезії патогенів

Saccharomyces boulardii зв'язують бактерії та їх токсини на своїй поверхні, не даючи їм прикріпитися до слизової кишечника.

Це діє як “біологічний фільтр”: патогени просто проходять транзитом і виводяться з організму.

Ефективно проти: *E. coli*, *Salmonella typhimurium*, *Clostridium difficile*, *Helicobacter pylori*.

3. Модулювання імунної відповіді

Підвищує секрецію IgA — антитіл, які нейтралізують токсини у просвіті кишечника.

Знижує надмірну запальну відповідь (TNF-α, IL-8), яка пошкоджує слизову.

4. Конкуренція за поживні речовини

Saccharomyces boulardii “відбирають” у патогенів джерела вуглецю й азоту, гальмуючи їх ріст і колонізацію кишечника.

5. Відновлення мікрофлори після антибіотиків

- Не руйнується антибіотиками (дріжджовий організм, а не бактерія).
- Підтримує ріст корисних бактерій (*Bifidobacterium*, *Lactobacillus*).
- Зменшує ризик антибіотикоасоційованої діареї на 40–50%

Коротко суть дії сахароміцет:

Механізм	Результат
Руйнує токсини (A, B, LT, ST)	Менше пошкодження слизової
Блокує прикріплення патогенів	Перешкоджає колонізації
Стимулює IgA	Зміцнює місцевий імунітет
Знижує запалення	Менше симптомів діареї, болю

Відновлює мікрофлору

Швидше одужання після
антибіотиків

механізм дії цинку

1. На рівні ШКТ цинк відновлює цілісність слизового бар'єру та активність ферментів ентероцитів
2. Цинк сприяє підвищенню імунітету, стійкості шкіри та слизових оболонок до інфекцій
3. Він також є важливим антиоксидантом і зберігає цілісність клітинних мембран
4. Сприяє виробленню антитіл та циркулюючих лімфоцитів проти кишкових патогенів
5. Цинк впливає на активність понад 300 ферментів

Основні біохімічні та клітинні процеси

Метаболічні та системні ефекти



ЕСБУЛАРДІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. ЖИВІ штами *S.boulardii* (Active dried yeast *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* CNCM I-3799)
2. **Оптимальне дозування** сахароміцет буларді (250 мг) в одній капсулі
3. **Цинку разом з сахароміцетами буларді** зменшують тривалість та важкість діареї, підсилює імунну відповідь та рекомендовано ВООЗ та ВГО, що відповідає складу Есбуларді
4. **Есбуларді®** можливо застосовувати одночасно з курсом антимікробної терапії

S. boulardii швидко усувають симптоми діареї різної етіології, виводять токсини, які виробляються патогенними бактеріями, мають генетично детерміновану антибіотикорезистентність, сприяють зростанню в організмі корисної мікрофлори. Цинк зменшує тривалість та тяжкість діареї, знижує запалення в кишечнику, сприяє регенерації його слизової оболонки, поліпшує засвоєння рідини та електролітів.

Сумісність з антибіотиками:

- Дріжджовий пробіотик *Saccharomyces boulardii* не чутливий до більшості антибіотиків — може призначатись одночасно, що зменшує ризик порушення мікрофлори під час лікування.

ДНК-ідентифікований штам CNCM I-3799

- Конкретність походження штаму — гарантія стабільності активності, якості та відтворюваності ефекту.

Підтримка мікрофлори та комфорту травлення

- Допомагає запобігати або зменшувати симптоми, пов'язані з дисбіозом або порушеннями після антибіотикотерапії (наприклад, діарея, тяжкість, здуття).

Профілактична користь

- Може застосовуватись не лише в гострих ситуаціях, а й профілактично — особливо у періоди підвищеного ризику (при змінах погоди, сезоні інфекцій), що допомагає знизити частоту звернень і неприємних симптомів.

Безпека і переносимість

- Хороший профіль переносимості, низький ризик побічних ефектів, придатний для використання у широкому спектрі пацієнтів (дорослі, діти), за умови відсутності серйозних протипоказань.

Есбуларді — пробіотик з ДНК-ідентифікованим штамом *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799 у поєднанні з цинком для подвійного захисту травної системи та підтримки імунітету.

Унікальний штам CNCM I-3799 (Lynside®) — підтверджена генетична ідентичність, клінічна доказовість, стабільність дії та висока виживаність у ШКТ.

- Жоден інший пробіотик на ринку України не містить саме цей штам.

Поєднання з цинком (10 мг) —

- підтримує бар'єрну функцію слизових оболонок;
- сприяє нормальній роботі імунної системи;
- підсилює відновлення після антибіотикотерапії.

Подвійна дія:

- протягом антибіотикотерапії — зменшує ризик порушення мікрофлори;
- після лікування — сприяє природному відновленню кишкової екосистеми.

2.Конкуренти

КЛЮЧОВІ КОНКУРЕНТИ



**Склад: сахароміцети буларді
CNCM I-745 250 мг**



1 капсула містить:

- Сахароміцети буларді CNCM I-745 (ліофілізовані клітини) – не менше 2×10^9 (2 мільярдів) КУО,
 - вітаміну С (у вигляді аскорбінової кислоти) – 60 мг,
- вітаміну D₃ (у вигляді холекальциферолу) – 10 мкг (400 МО),
 - цинку (у вигляді глюконату цинку безводного) – 10 мг

Назва штаму	Стан	Переваги	Недоліки
S. Boulardii CNCM I-3799 Есбуларді	Живі	Живі штами можуть активно розмножуватися після введення в організм. Вони мають більш потужний ефект на мікробіоту та здоров'я кишечника.	Мають термін придатності 24 міс
S. Boulardii CNCM I-745	Ліофілізовані	Мають довший термін придатності (5 років)	Менша ефективність порівняно з живими штамми, оскільки вони не можуть розмножуватися після введення.

ХПВ ЕНТЕРОЛ

1. **Есбуларді містить цинк** у формі глюконату цинку, на відміну від іншого монопрепарата з сахароміцетами. Цинк дозволить вашим пацієнтам відновити слизовий бар'єр ентероцитів та підвищить ферментну активність в них.
2. **Есбуларді в своєму складі не має лактози та фруктози**, що дозволяє Вам рекомендувати безпечно Есбуларді всім пацієнтам без уточнення переносимості лактози та фруктози.
3. **Есбуларді містить живі штами сахароміцет**, тому термін придатності менший ніж у ліофілізованих штаммах. Есбуларді думає про ефективність, а не економічну вигоду для компанії!

4. **Есбуларді немає фази активації, як у ліофілізованих форм** (яким потрібен час і середовище для «пробудження») та має швидший старт пробіотичної дії — важливо в гострих ситуаціях (наприклад, при діареї, антибіотик-асоційованих станах), на відміну від ліофілізованих клітин. Есбуларді дозволить отримати полегшення Вашим пацієнтам швидше.
5. **Курс лікування Есбуларді, економічно вигідніший для пацієнта** на відміну від іншого препарата з ліофілізованими штамами. Це підвищить комплаєнс прийому препарата пацієнтом, та збільшить вірогідність проходження повного курсу лікування.

ХПВ ЕНТЕРОЛ

Вища переносимість під час антибіотикотерапії

У пацієнтів на АБТ часті проблеми:

- нудота
- гастрит
- підвищена кислотність
- діарея

Ентерол Імуно має вітамін С, який може подразнювати слизову та провокувати кислотність → погіршує переносимість.

Есбуларді не містить кислотних компонентів, тому легше переноситься:

- ✓ без подразнення
- ✓ без кислотності
- ✓ без ризику болю в шлунку

ЛАЦИДОЕНТЕР



Склад:

Saccharomyces boulardii 0,25 г - 6,25 млрд

Lactobacillus plantarum LP 115 0,017 г - 5 млрд.

Цинк (zinc oxide) 10 мг

Спосіб застосування

дітям від 3-х років та дорослим:

- *Профілактика діареї* (при прийомі антибіотиків, мандрівка, тощо) 1 капсула на добу за 2-3 дні до мандрівки та на її протязі та на протязі всієї антибіотикотерапії
- *Лікування діареї* (різної) 2-4 капсули на добу 3-5 днів
- *З антимікробною метою* (СІБР) 2-3 капсули на добу до 30 днів
- *Для відновлення мікрофлори кишечника* (після антибіотикотерапії) 1 капсула на добу до 30 днів

Есбуларді	Лацидоентер
ЖИВІ штами S.boulardii. Есбуларді - пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму Saccharomyces	Не знаємо які штами сахароміцет буларді

boulardii CNCM I-3799, який підсилений цинком	
S. boulardii (mono) можна застосовувати одночасно з курсом антибактеріальної терапії.	Не рекомендується приймати лакто- бактерії разом з антибіотиками
Можна приймати при несприятливості молока	Лактобактерії протипоказані при чутливості до будь-якого з компонентів (зокрема несприйнятливості молока та сої)

ХПВ

1. Есбуларді містить живі європейські штами сахароміцет, які можна використовувати як з антибіотиком так і без нього, на відміну від комбінованого пробіотика, який містить лакто, сахароміцети і цинк, який не рекомендований для вживання разом з антибіотиком. Есбуларді діє за будь яких обставин, Ваш універсальний пробіотик для Ваших пацієнтів.
2. Есбуларді за комфорт пацієнта, тому його можна приймати в будь-який зручний час, на відміну від комбінованого пробіотика, який можна вживати з прив'язкою до прийому їжі.
3. Есбуларді немає фази активації, як у ліофілізованих форм (яким потрібен час і середовище для «пробудження») та має швидший старт пробіотичної дії — важливо в гострих ситуаціях (наприклад, при діареї, антибіотик-асоційованих станах), на відміну від ліофілізованих клітин. Есбуларді дозволить отримати полегшення Вашим пацієнтам швидше.

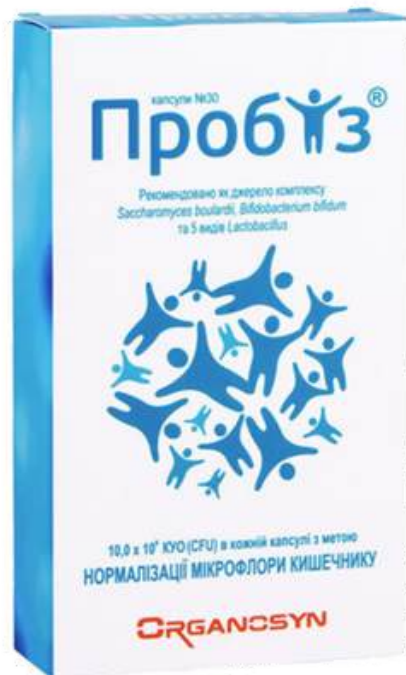
4. Курс лікування Есбуларді, економічно вигідніший для пацієнта на відміну від іншого препарата з ліофілізованими штамами. Це підвищить комплаєнс прийому препарата пацієнтом, та збільшить вірогідність проходження повного курсу лікування.

КОМБІНОВАНІ САХАРОМІЦЕТИ



Склад:

Bifidobacterium longum,
Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus rhamnosus,
Saccharomyces boulardii – 125 мг;



Склад:

Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus plantarum
 Lactobacillus reuteri
 Lactobacillus casei
 Bifidobacterium bifidum
 Saccharomyces boulardii



Склад: Saccharomyces boulardii Lactobacillus acidophilus Lactobacillus
 rhamnosus
 Інулін

ЕСБУЛАРДІ®	КОМБІНАЦІЇ: САХАРОМІЦЕТИ БУЛАРДІ + ЛАКТО- ТА/АБО БІФІДОБАКТЕРІЇ
ЖИВИ штами <i>S.boulardii</i> (Active dried yeast <i>Saccharomyces cerevisiae</i> var. <i>boulardii</i> CNCM I-3799)	Ліофілізовані штами сахароміцет буларді
пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму <i>Saccharomyces boulardii</i> CNCM I-3799, який підсилений цинком	Невідомий штам сахароміцет, без ідентифікації
<i>S. boulardii</i> можна застосовувати одночасно з курсом антибактеріальної терапії	Не рекомендується приймати лакто- та/або біфідобактерії разом з антибіотиками
Оптимальне дозування (250 мг) в одній капсулі	У комбінації зазвичай менша доза сахароміцет буларді (125 або 100 мг)
Додавання цинку до сахароміцетів буларді зменшує тривалість та важкість діареї, підсилює імунну відповідь та рекомендовано ВООЗ та ВГО	Більшість не містять цинк
Можна приймати при непереносимості лактози	Лактобактерії протипоказані при чутливості до будь-якого з компонентів (зокрема несприйнятливості молока та сої)



ХПВ

1. Есбуларді можна приймати разом з антибіотиком, оскільки сахароміцети резистентні до їх дії, на відміну від лакто- та/або біфідобактерії, які не рекомендують приймати разом з антибіотиками, оскільки вони просто руйнуються і не мають ніякої дії. Лактобактерії протипоказані при чутливості до будь-якого з компонентів (зокрема несприйнятливості молока та сої), на відміну від Есбуларді, який не містить лакто компонентів.
2. Есбуларді немає фази активації, як у ліофілізованих форм (яким потрібен час і середовище для «пробудження») та має швидший старт пробіотичної дії — важливо в гострих ситуаціях (наприклад, при діареї, антибіотик-асоційованих станах), на відміну від ліофілізованих клітин. Есбуларді дозволить отримати полегшення Вашим пацієнтам швидше
3. Курс лікування Есбуларді, економічно вигідніший для пацієнта на відміну від іншого комбінованого препарата з ліофілізованими штамами, лакто і біфідо бактеріями. Це підвищить комплаєнс прийому препарата пацієнтом, та збільшить вірогідність проходження повного курсу лікування.

4. **Дешевші за Есбуларді.** Так як Есбуларді використовує Живі французькі сахароміцети, ви можете бути впевнені в якості Есбуларді, більш доступні варіанти невідомо які сахароміцети використовує, тому доступніше в даному випадку, не означає якісно
5. Есбуларді містить тільки необхідні сахароміцети, для лікування і профілактики ААД, на відміну від комбінованих препаратів, які не рекомендують використовувати разом з антибіотиком. Ваші пацієнти отримають тільки те, що їм дійсно потрібно.

МОНО САХАРОМІЦЕТИ



В усіх препаратах даної конкурентної Групи, в складі не вказаний штам сахароміцет буларді. Есбуларді містить сахароміцети буларді *Lynside Pro SCB (Saccharomyces boulardii CNCM I-3799)*, Ви будете впевнені в ефективності лікування, оскільки є чітко прописаний штам сахароміцет. Пробиотікс має малу дозу, Есбуларді містить 250 мг, що є рекомендованою дозою сахароміцет.

- Нормагут
- Пробіотікс
- Булардез
- Ентеро Булардія
- Пробілав

ЕСБУЛАРДІ

Сахароміцети буларді CNCM I-3799 - 250 мг (mg)
Цинк (у формі глюконату цинку) - 10,0 мг (mg)

Есбуларді немає фази активації, та має швидший старт пробіотичної дії — важливо в гострих ситуаціях

ДОРОГО

Есбуларді використовує Живі європейські сахароміцети, ви можете бути впевнені в якості та ефективності Есбуларді

САХАРОМІЦЕТИ БУЛАРДІ

В усіх препаратах даної конкурентної групи, в складі не вказаний штам сахароміцет буларді

У ліофілізованих формах потрібен час і середовище для «пробудження», дія настає пізніше

ДОСТУПНО

Курс лікування Есбуларді, економічно вигідніший для пацієнта на відміну від іншого препарату з ліофілізованими штамми

- Ентеро Булардія
- Пробілав



ХЕЛІКОТЕР В ЕРАДИКАЦІЙНІЙ ТЕРАПІЇ



Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside® Pro SCB) - ЕСБУЛАРДІ

S. boulardii CNCM I-3799 = живий пробіотичний штам

- Стійкий до дії антибіотиків
- Відновлює мікробіоту
- Пригнічує патогени
- Нейтралізує токсини Clostridioides difficile
- Зменшує ризик діареї, та її тривалість

✓ Використання:

- Під час будь-якої антибіотикотерапії, включно з ерадикацією *H. pylori*
- профілактика ААД
- профілактика *C. difficile*
- розлади після прийому антибіотиків
- СПК – з діареєю після антибіотиків

Pylopass™ (L. reuteri DSM 17648) - ХЕЛІКОТЕР

Pylopass = (інактивований штам бактерій Lactobacillus reuteri DSM 17648)

- Клітини Неживі
- Не відновлюють мікробіоту
- Не впливають на побічні реакції антибіотиків
- Працюють тільки в шлунку

Єдина дія — **аглоїтинація та зниження навантаження *H. pylori***

✓ Використання:

Супровід ерадикаційної терапії - зменшення симптомів, пов'язаних з *H. pylori*, НІЯК не впливає на діарею, дисбіоз чи ААД.





Порівняння: Pylopass™ vs S. boulardii для АБ-терапії

Критерій / Потреба	Pylopass™ (L. reuteri DSM 17648)	S. boulardii (живий пробіотик / Есбуларді)
Ефект на H. pylori	+ підсилює ерадикацію, знижує навантаження	+/- без прямої анти-H. pylori дії
Дія на мікробіоту кишечника	✗ Ні	✓ Так, живі клітини, відновлюють флору
Захист від антибіотик-асоційованої діареї (ААД)	✗ Ні	✓ Так
Профілактика C. difficile	✗ Ні	✓ Так (завдяки S. boulardii)
Зменшення побічних ефектів АБ-терапії	✓ Так (менше диспепсії, абдомінального дискомфорту)	✓ Так
Відновлення кишкового бар'єра / мікробіоти після АБ	✗ Ні	✓ Так
Основна ніша	Шлунок, H. pylori	Кишківник, мікробіота, ААД, C. difficile



2.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ЕСБУЛАРДІ

Гастроентеролог:

- Антибіотик-асоційована діарея (AAD)
- Профілактика та лікування діареї, пов'язаної з *Clostridioides difficile* (у складі комплексної терапії)
- Гострі інфекційні діареї (вірусні, бактеріальні)
- Хронічні порушення кишкового мікробіому
- Синдром подразненого кишечника (СПК) з діарейним або змішаним типом
- Дисбіози після АБ
- Підтримка кишківника при *H. pylori* ерадикації

Колопроктолог:

- Післяопераційні стани кишечника
- Пронеси/нестабільний стул після хірургічних втручань
- Парапроктит, проктит, геморой — при діареї як тригер
- Антибіотикотерапія – після оперативних втручань, при лікуванні запальних захворювань

Сімейний лікар/ терапевт:

- Хронічні кишкові дисфункції з переважанням діарейного синдрому
- «чутливий кишечник»
- Пацієнти, які постійно скаржаться на больові відчуття в животі, диспепсичні симптоми (здуття, метеоризм), порушення стільця.
- При призначенні АБ (лікування основного захворювання) для профілактики ААД
- Гостра інфекційна (бактеріальна і вірусна) діарея
- ААД
- Синдром надлишкового бактеріального росту
- Діарея мандрівників
- СПК з діареєю та Постінфекційний СПК з діареєю

- Функціональна діарея
- Дисбіоз
- Пост-COVID або Long-COVID
- ГРВІ з ризиком діареї (порушення після вірусів)
- Пацієнти на курсах антибіотиків (респіраторні патології)
- Харчові інфекції (літо–осінь)

Дерматолог:

Через gut–skin axis:

Патології:

- **Акне** (антибіотики → дисбіоз → діарея/запалення)
- **Атопічний дерматит** (порушений мікробіом)
- **Розацеа**

Інфекціоніст:

- Гострі кишкові інфекції
- Антибіотикотерапія
- Підтримка після важких ентероколітів
- Профілактика рецидивів *C. difficile*

СКРИПТИ: ЕСБУЛАРДІ

1. Антибіотик-асоційована діарея

S - Situation (ситуаційне запитання)

- Лікарю, чи часто серед ваших пацієнтів на антибіотиках виникає діарея на 3–5 день лікування?

P - Problem (проблема)

- Чи створює це складнощі: переривання курсу, повторні візити, заміна антибіотика?

I - Implication (наслідки)

- Розумію. Такі ситуації збільшують тривалість лікування та навантаження на вас, правда?

N - Need-payoff (цінність рішення)

- Есбуларді (S. boulardii + цинк) має доведений ефект зменшення ААД та покращує переносимість антибіотикотерапії.
- Його зручно додати з 1-го дня антибіотиків — 1 капсула на добу.
- Це знижує ризик діареї та зменшує потребу коригувати антибіотики.

2. Діарея, пов'язана з Clostridioides difficile (в комплексній терапії)

S - Situation (ситуаційне запитання)

- Чи часто ви стикаєтесь із пацієнтами після антибіотиків, у яких є ризик C. difficile?

P - Problem (проблема)

- Знаю, що рецидиви та тривалі діареї - серйозна проблема. Це досить обтяжлива категорія пацієнтів?

I- Implication (наслідки)

- І кожен рецидив потребує повторних антибіотиків і збільшує ризики для пацієнта?

N- Need-payoff (цінність рішення)

- S. boulardii має здатність нейтралізувати токсини А і В C. difficile та знижувати ризик рецидивів.
- Есбуларді можна включати як частину підтримуючої терапії - особливо в пацієнтів групи ризику.
- Це може зменшити тяжкість перебігу та стабілізувати стул.

3. Гострі інфекційні діареї (вірусні та бактеріальні)

S - Situation (ситуаційне запитання)

- Зараз сезон гострих кишкових інфекцій... Чи багато звернень з гострою діареєю?

P - Problem (проблема)

- Пацієнти часто зневоднені, з болем, на Вашу думку, цього можна уникнути без підтримки?

I- Implication (наслідки)

- Підкажіть, з Вашого досвіду - без правильної корекції мікробіому відновлення затягується?

N- Need-payoff (цінність рішення)

- *Saccharomyces boulardii* зменшує тривалість інфекційної діареї завдяки антитоксичній та протимікробній активності.
- Додавання цинку підсилює бар'єрну функцію кишечника.
- Есбуларді — зручний варіант 1 раз на добу для стабілізації стулу.

4.Хронічні порушення кишкового мікробіому

S - Situation (ситуаційне запитання)

- Чи часто у ваших пацієнтів є нестабільний стул, здуття, після інфекцій чи антибіотиків?

P - Problem (проблема)

- Такі пацієнти зазвичай довго відновлюються, і класичні пробіотики не завжди дають ефект?

I - Implication (наслідки)

- Хронічний дисбаланс мікробіому впливає і на запалення, і на самопочуття, і на якість життя?

N- Need-payoff (цінність рішення)

- *S. boulardii* - дріжджовий пробіотик, не руйнується антибіотиками і не конкурує з бактеріями.
- Есбуларді — зручний варіант для тривалого відновлення мікробіому (10–14 днів)
- Додавання цинку підсилює бар'єрну функцію кишечника

5.СПК (діарейний або змішаний тип)

S- Situation (ситуаційне запитання)

- Чи є у вас пацієнти з СПК, у яких основні симптоми - діарея, гази, нестабільний стул, особливо в яких проявляються симптоми після стресу?

P- Problem (проблема)

- Складність у тому, що такі пацієнти часто реагують на стрес, харчування, після антибіотиків, Ви згодні?

I - Implication (наслідки)

- І традиційні пробіотики не завжди дають швидкий ефект, бо СПК - це порушення ферментації і бар'єра, як Ви вважаєте?

N- Need-payoff (цінність рішення)

- S. boulardii впливає саме на механізми СПК:

- зменшує секрецію води,
- стабілізує моторну реактивність,
- знижує запальну відповідь.

- Есбуларді - безпечний варіант при СПК, можна призначати короткими курсами з контролем симптомів.

6. Підтримка при ерадикації H. pylori

S- Situation (ситуаційне запитання)

- Ерадикаційні схеми зараз доволі "важкі" для кишечника, чи часто пацієнти скаржаться на діарею?

P- Problem (проблема)

- На Вашу думку, побічні реакції можуть знижувати прихильність та ефективність терапії?

I- Implication (наслідки)

- Чи доводиться зменшувати дозу антибіотиків або змінювати схему, внаслідок побічних дій ерадикаційної терапії?

N- Need-payoff (цінність рішення)

- S. boulardii у дослідженнях показав зниження частоти діареї при ерадикації та покращення переносимості.

- Есбуларді - простий інструмент для підвищення прихильності до терапії.

- Можна додавати на весь курс антибіотиків + 10 днів після.

7. Універсальний СПН-скрипт для Есбуларді

S - Situation (ситуація)

- Лікарю, підкажіть, будь ласка, чи часто у ваших пацієнтів під час або після лікування виникають порушення стулу чи симптоми дисбіозу?

P - Problem (проблема)

- Це, зазвичай, ускладнює лікування: діарея, здуття, дискомфорт, і пацієнти нерідко переривають терапію, правда?

I - Implication (наслідки)

- У таких випадках знижується прихильність, терапія стає менш ефективною, і зростає кількість повторних візитів?

N - Need-Payoff (рішення)

- Есбуларді - пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком, який:

- не руйнується антибіотиками,
- нейтралізує бактеріальні токсини,
- стабілізує бар'єр та нормалізує стул,
- зменшує ризик діареї під час і після лікування.

- Формат 1 капсула на добу - це просто й зручно для пацієнта та значно покращує переносимість терапії.

8. Універсальний скрипт для Есбуларді - респіраторна патологія

- Лікарю, в період збільшення ГРВІ збільшується і кількість призначень вами АБ, особливо при ускладненнях COVID-19. А при застосуванні АБ важливо захистити кишечник правильним пробіотиком, який буде з одного боку безпечним, а з іншого ефективним. Тому рекомендуємо призначати Есбуларді - пробіотик на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком, який:
 - не руйнується антибіотиками,
 - нейтралізує бактеріальні токсини,
 - стабілізує бар'єр та нормалізує стул,
 - зменшує ризик діареї під час і після лікування, для пацієнтів,

що отримують антибіотикотерапію, особливо з приводу COVID19

- Лікарю, жоден антибіотик не позбавлений ризику розвитку побічних реакцій із боку ШКТ. Дисбіотичні порушення, діарея та навіть антибіотик-асоційовані коліти можуть з'являтися не лише під час терапії.

За даними літератури, до 30% випадків ААД виникають через 7–10 днів після закінчення прийому антибіотика або навіть протягом 8 тижнів після терапії.

Саме тому доцільно розпочинати підтримку кишківника з першого дня антибіотикотерапії, використовуючи безпечний пробіотик Есбуларді на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком

- Лікарю, навіть при парентеральному введенні антибіотиків зберігається ризик антибіотик-асоційованих розладів ШКТ. Антибіотики надходять у кишечник не лише перорально — вони виділяються із слиною, жовчю, секретами тонкої та товстої кишки. Тому порушення мікробіому виникають незалежно від шляху введення АБ, а ризики залишаються високими.

З огляду на це рекомендовано призначати Есбуларді на основі ДНК-ідентифікованого штаму *Saccharomyces boulardii* CNCM I-3799, який підсилений цинком з першого дня антибіотикотерапії, щоб підтримати мікробіоту та знизити ймовірність діареї та інших ускладнень.

МАСТИКОЗИН



Дієтична добавка

Мастикозин® Masticosin

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Інгредієнт:	1 капсула	Максимальна добова кількість (3 капсули)
Порошок смоли мастикового дерева (Pistacia lentiscus)	350 мг	1050 мг

Склад: порошок смоли мастикового дерева (*Pistacia lentiscus*) (87,5 %); наповнювач: мальтодекстрин, антизлежувач: діоксид кремнію; оболонка капсули: желатин.

Смола мастикового дерева (*Pistacia lentiscus*) – це натуральний продукт з грецького острова Хіос, розташованого в північній частині Егейського моря.

Країна походження основного інгредієнта відрізняється від країни походження продукту.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати по 1 капсулі 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 10-14 днів. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодоці та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: вагітність та період лактації, дитячий вік до 18 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 400 мг $\pm$ 7,5 % №10 у блістері, упакованому у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, просп. Правди, 80-В.

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону
оператора ринку харчових продуктів, відповідального за
інформацію про харчовий продукт:**

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф.
41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

Контроль якості!

Ваші відгуки і пропозиції приймаємо на
електронну пошту

quality@behealth.com.ua

3.Картка продукту

МАСТИКОЗИН ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Мастикозин® - інноваційний засіб для підсилення ефективної ерадикації *H.pylori*, без розвитку резистентності

ЯКИЙ:

Підвищує ефективність ерадикації *Helicobacter pylori*

Забезпечує захист слизової оболонки шлунка завдяки утворенню захисного шару

Знижує ризик рецидиву виразкової хвороби шлунку

ТОМУ ЩО містить:

Натуральну мастику Хіос, яка має подвійну дію:

1. Антибактеріальний ефект
2. Бар'єрний ефект

МАСТИКОЗИН КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Мастикозин® - інноваційний засіб для підсилення ефективної ерадикації *H.pylori*, без розвитку резистентності

МАСТИКОЗИН ЦІННІСТЬ ПРОДУКТУ

Мастика Хіос (*Chios mastic*) містить тритерпенові кислоти (ізомастикову, олеанолову, мороненову), які мають бактеріостатичну дію проти *Helicobacter pylori* — у т.ч. штамів із антибіотикорезистентністю.

1. природне антибактеріальне підсилення ерадикаційної терапії або профілактика рецидиву після неї.

2. природний бар'єрний ефект

3. Можна застосовувати повторно та довгостроково

- Не змінює кислотність шлунка

- Добре переноситься навіть при тривалому прийомі

- Не викликає резистентності

4. Не руйнується під дією АБ, можливе одночасне використання

ЯК САМЕ ПРАЦЮЄ МАСТИКОЗИН?

1. Потужна протизапальна дія

Компоненти мастики Хіос пригнічують активність ключових прозапальних шляхів:

- знижують експресію iNOS та COX-2 — ферментів, що спричиняють запалення
- зменшують продукцію прозапальних молекул (цитокінів, таких як TNF- α , IL-6, IL-8)
Це зменшує запалення слизової оболонки шлунка та кишечника, що є основою багатьох гастроентерологічних **симптомів**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8838553/>

2. Антиоксидантний захист клітин

Мастика містить багато біоактивних антиоксидантних сполук (терпени, феноли), які:

- підвищують внутрішньоклітинний рівень глутатіону — ключового антиоксиданту
- знижують окиснювальний стрес в епітеліальних клітинах
Це допомагає захистити клітини шлунка та кишечника від ушкоджень

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8838553/>

3. Захист та відновлення слизового бар'єра

Оглядові дані свідчать, що мастика демонструє протектуючий ефект на епітеліальні клітини кишечника:

- зменшує вираженість ушкоджень
- сприяє частковому відновленню різноманіття мікробіоти

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8838553/>

Покроковий механізм дії мастики на *H. pylori*

1. Контакт і пряма антибактеріальна дія (бактерицидність)

Біоактивні компоненти мастики (особливо тритерпенові кислоти та інші ліпофільні фракції) безпосередньо інгібують ріст *H. pylori* і можуть викликати загибель бактерій при достатніх концентраціях (виявлено *in vitro*)

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199812243392618>

2. Пошкодження клітинної структури бактерії

Досліди показали, що під дією суб-МБК (мінімальна бактерицидна концентрація) і МБК фракцій мастики *H. pylori* зазнає морфологічних змін (пошкодження клітинних мембран, порушення цілісності), що призводить до втрати життєздатності.

https://www.researchgate.net/publication/11551857_Bactericidal_Activity_of_Pistacia_lentiscus_Mastic_Gum_Against_Helicobacter_pylori

3. Інгібування уреазы та ферментативних механізмів виживання

Компоненти мастики знижують активність уреазы — ключового ферменту, який *H. pylori* використовує для нейтралізації кислого середовища шлунка; це робить колонію вразливішою до кислоти й до захисних механізмів

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1797732/>

4. Порушення адгезії до епітелію

Мастика впливає на здатність *H. pylori* прикріплюватися до слизового епітелію шлунка (адгезію), що знижує колонізацію і полегшує елімінацію бактерій

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1797732/>

5. Опосередковане посилення клітинних захисних механізмів (гастропротекція)

Паралельно мастика чинить протизапальну та антиоксидантну дію на епітелій шлунка: знижує експресію прозапальних маркерів (TNF- α , ЦОГ-2, iNOS(Індуцибельна синтетаза оксиду азоту)), зменшує окислювальний стрес і стимулює відновлення слизового бар'єра. Це створює менш сприятливе середовище для тривалої колонізації *H. pylori* та сприяє загоєнню слизової

<https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/590>

3.Конкуренти

КОНКУРЕНТНЕ ОТОЧЕННЯ



Активний інгредієнт: PYLOPASS™ (*Lactobacillus reuteri* DSM 17648) - 200 мг.

Властивості

Pylopass™ допомагає знизити бактеріальне навантаження *H. pylori* в шлунку в цілеспрямованій формі. Він працює, утворюючи коагрегати з *H. pylori* через свою молекулярну форму, трохи схожу на липучку. Молекули на поверхні Pylopass™, збігаються за розмірами зі структурами на поверхні *H. pylori*. Коагрегація залежить тільки від механічного скріплення цих структур. Після коагрегації він виводиться з організму через травний тракт, тим самим знижуючи рівень *H. pylori*. Pylopass™ може протистояти низькому рН шлунка, тому що він використовує механізм, який не залежить від виживання в шлунковому середовищі.

	Хелікотер	МАСТИКОЗИН
Антибактеріальний ефект	± Зменшує кількість бактерій <i>H. pylori</i>	+
Бар'єрний ефект	-	+

Протизапальний ефект	-	+
Викликає резистентність	Бактерії можуть уникати зв'язування через мутації	-
Натуральний склад	+	+

МАСТИКОЗИН



ХЕЛІКОТЕР



Має подвійну дію на *H. pylori*:
антибактеріальний та бар'єрний ефект



Антибактеріальний та бар'єрний ефект

- Зниження запалення
- Захист слизової оболонки



Мастикозин можна використовувати як для лікування, так і для профілактики



використовується для зниження бактеріального навантаження *H. pylori*



Немає прямих протизапальних чи регенеративних ефектів



Працює тільки на склеювання *H. Pylori*, не профілактує рецидиви

ХПВ

1. Мастикозин має спрямовану антибактеріальну дію проти *Helicobacter pylori*, доведена ефективність проти 4 штамів, що дозволить вам підвищити ефективність ерадикації, на відміну від іншого препарату, який тільки механічно склеює *Helicobacter pylori*
2. Мастикозин має антибактеріальний та бар'єрний ефект, на відміну від іншого препарату, який немає прямих протизапальних чи регенеративних ефектів

3. Мاستикозин поєднує **пряму антибактеріальну активність проти *H. pylori* із вираженим протизапальним і регенеративним (бар'єрним) ефектом** на слизову шлунка. Хелікостер має механізм адгезивної дії проти *H. pylori*, але **не демонструє прямих протизапальних чи епітеліопротекторних властивостей**, властивих мастиці Хіос.
4. Мастикозин — це не тільки дія проти *H. pylori*, а й відновлення та захист слизової: антибактеріальна дія + зниження запалення + стимуляція репарації. Хелікостер діє переважно шляхом зв'язування бактерії і не забезпечує прямої гастропротекції або регенерації епітелію.

3.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: МАСТИКОЗИН

Гастроентеролог:

- *H. pylori* асоційований гастрит
- Виразкова хвороба шлунка та ДПК викликана *H. pylori*
- Симптоми загострення після ерадикаційної терапії
- Хронічний гастрит викликаний *H. pylori*
- Порухення кишкового бар'єра у верхніх відділах ШКТ, внаслідок ерадикаційної терапії
- Альтернативна схема лікування при відмові від стандартної терапії

Сімейні лікарі:

- Підтримка при ерадикації *H. pylori*
- Профілактика сезонних захворювань після ерадикації
- Альтернативна схема лікування при відмові від стандартної терапії
- Родичам пацієнтів , які проходять ерадикаційну терапію

СКРИПТИ

1. *H. pylori* асоційований гастрит

S - Situation (ситуація)

- Лікарю, чи часто у ваших пацієнтів з *H. pylori* гастритом наявні такі симптоми, як біль, печія, дискомфорт до початку ерадикації?

P - Problem (проблема)

- Слизова вже запалена, і пацієнти скаржаться на значні симптоми, пацієнт хоче отримати одразу ефект від лікування?

I - Implication (наслідки)

- Такі пацієнти менш терплячі, часто переривають терапію та не дотримуються комплаєнсу прийому, що ставить під загрозу успіх ерадикації?

N - Need-Payoff (рішення)

- Мاستикозин - на основі мастики Хіос, який володіє антибактеріальною дією на 4 штами *H. Pylori* та має бар'єрний ефект, що :
 - зменшує запалення слизової,
 - знижує симптоми до та під час ерадикації,
 - створює бар'єр і покращує переносимість лікування.
- Це підвищує прихильність і комфорт пацієнта під час ерадикаційної терапії.

2. Виразкова хвороба шлунка та ДПК, викликана *H. pylori*

S - Situation (ситуація)

- У пацієнтів з виразками ви часто стикаєтесь з болем та болем який турбує пацієнта вночі?

P - Problem (проблема)

- Чи помічали Ви, що на тлі ІПП під час ерадикаційної терапії не завжди швидко уходять симптоми?

I - Implication (наслідки)

- Це знижує якість життя, а виразки потребують надійного захисту слизової?

N- Need-Payoff (рішення)

- Мاستикозин сприяє відновленню слизової, зменшує запалення та знищує *H. Pylori* тим самим, знижує колонізацію *H. pylori*, підсилюючи ефективність схеми.
- Він м'яко підтримує слизову без зміни кислотності, що важливо для фізіологічного загоєння.

3. Симптоми загострення після ерадикаційної терапії

S - Situation (ситуація)

- Чи часто після завершення ерадикації пацієнти повертаються зі скаргами: біль, здуття, відчуття «подразненого» шлунка?

P - Problem (проблема)

- На Вашу думку, це пов'язано з тим, що сама ерадикація травмує слизову та мікробіом?

I - Implication (наслідки)

- І відновлення може затягуватись, що створює повторні візити та невдоволення терапією?

N - Need-Payoff (рішення)

- Мاستикозин допомагає відновити слизову після агресивної схеми, знижує залишкове запалення і прискорює комфорт пацієнта.

- Курс 10-14 днів після ерадикації суттєво покращує відновлення бар'єра.

4. Альтернативна схема лікування при відмові від стандартної терапії

S - Situation (ситуація)

- У практиці трапляються пацієнти, які відмовляються від стандартної ерадикаційної терапії, бо бояться побічних ефектів?

P - Problem (проблема)

- Такі пацієнти залишаються з симптомами, хронічним запаленням і постійними загостреннями?

I - Implication (наслідки)

- Без лікування процес прогресує і значно погіршує якість життя?

N - Need-Payoff (рішення)

- Мاستикозин може бути опцією підтримки таких пацієнтів:

- знижує симптоми,
- зменшує запалення,
- має природну антимікробну активність проти *H. pylori*, але водночас без агресивного втручання.

- Це хороший місток до того, щоб пацієнт у майбутньому прийняв рішення повернутись до повноцінної терапії.

5. Загальний скрип візита

Вступна частина:

Доброго дня! Як завжди, радий/а бачити Вас. (Small talk) Хотів/ла б обговорити сучасний підхід до терапії гастриту, асоційованого з

H.pylori і представити препарат, який може бути корисним у Вашій практиці.

Опис ситуації:

На нещодавній конференції з гастронтерології знов піднімали питання інфекції *Helicobacter pylori*. Я впевнений/а, що до Вас часто звертаються пацієнти, які скаржаться на біль у шлунку, печію, важкість після їжі або дискомфорт, пов'язаний із запаленням слизової оболонки шлунка?

Проблематика:

Як правило, пацієнти з такими симптомами потребують комплексного підходу: зниження бактеріального навантаження *Helicobacter pylori*, усунення запалення, захисту та відновлення слизової оболонки шлунку. Яку схему терапії Ви використовуєте найчастіше?

Актуалізація:

Чи згодні Ви, що важливо індивідуально підбирати схему лікування для кожного пацієнта? Але, на жаль, підібрати схему лікування стає все важче через низку причин (зростаюча антибіотикорезистентність, низька прихильність пацієнта до лікування, колонізація декількома штамми *Helicobacter pylori*, тощо)

Направлення:

Я впевнений/а, що Ви хочете обрати найбільш ефективну і безпечну схему ерадикації *H. pylori* та запобігти рецидивам. Тому хочу вам запропонувати продукт, який може покращити результати терапії пацієнтів з гастритом і збільшити період ремісії.

ПАНТОФІТОЛ



Дієтична добавка

Пантофітол® Pantophytol

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Екстракти порошкоподібні:	1 капсула	Добова кількість (3 капсули)
бульби рясту (Corydalis yanhusuo)	25 мг	75 мг

насіння іпомеї ніл (Pharbitis nil choisy)	5 мг	15 мг
---	-------------	--------------

Склад: наповнювач: мальтодекстрин; екстракт бульби рясту (Corydalis yanhusuo), порошкоподібний (6,3 %), екстракт насіння іпомеї ніл (Pharbitis nil choisy), порошкоподібний (1,3 %); оболонка капсули: желатин.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу за 20-30 хвилин до прийому їжі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 4 тижні. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодоці та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: вагітність та період лактації, дитячий вік до 18 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 400 мг $\pm$ 7,5 % №20 у блістерах, упакованих у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, просп. Правди, 80-В.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС»,

Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

Контроль якості!

Ваші відгуки і пропозиції приймаємо на
електронну пошту

quality@behealth.com.ua

4. Картка продукту

ПАНТОФІТОЛ® ПОЗИЦІОНУВАННЯ

ПАНТОФІТОЛ® – РОСЛИННИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СИМПТОМІВ ФД

Який:

- Не маскує наявності *H.pylori*, може застосовуватись як стартова терапія ФД
- Має комплексну дію:
 - прокінетична,
 - розслаблення дна шлунку,
 - зменшення вісцеральної чутливості
- Безпечний і не має протипоказань до застосування

Тому що:

- впливає на рецептори, які беруть участь у регуляції моторики ШКТ
- розслабляє дно шлунка
- зменшує вісцеральну гіперчутливість

ПАНТОФІТОЛ® КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПАНТОФІТОЛ® – РОСЛИННИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СИМПТОМІВ ФД

ПАНТОФІТОЛ® МЕХАНІЗМ ДІЇ

1. Вплив на дно шлунку

Прийом Пантофітола дозволяє розслабити проксимальний відділ шлунка, щоб забезпечити простір для прийому їжі без підвищення шлункового тиску

2. Вплив на вісцеральну гіперчутливість

адренергічні α_2 - агоністи, такі як клонідин, зменшують сприйняття болю під час розтягнення шлунка та товстої кишки та знімають біль у людей.

3. Вплив на моторику

Пантофітол значно відновлював гіпомоторику антрального відділу шлунку в періоди до та після прийому їжі.

Крім того, при кишковій дисфункції було відновлено затримку роботи ШКТ та збільшено виділення калу.

ПАНТОФІТОЛ® ЦІННІСТЬ ПРОДУКТУ

Пантофітол - це єдиний препарат, який **діє на всі симптоми ФД**, такі як, затримка евакуації харчової грудки, спазм дна шлунку та найголовніше знімає вісцеральну чутливість шлунка, чим не можуть похвалитись інші препарати від симптомів функціональної диспепсії.

4.Конкуренти

КОНКУРЕНТНЕ ОТОЧЕННЯ ГАСТРИТОЛ



Активні інгредієнти в рекомендованій добовій кількості (1 пастилка):

- Екстракт листя меліси лікарської - 15,2 мг (mg),
- Екстракт кореня солодки (порошок) -15,2 мг (mg),
- CO2-екстракт квітів ромашки (ціле число) - 7,2 мг (mg),
- CO2-екстракт кореня імбиру - 1 мг (mg)

Екстракт квітів ромашки. Ромашка застосовується при різних шлунково-кишкових розладах, таких, як метеоризм, запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, діарея, коліки, закачування, нудота та блювання. Заспокоює шлунок і розслабляє м'язи, які переміщують їжу у кишківнику.

Екстракт кореня солодки. Основною із сполук є гліциризин, який може підвищувати концентрацію простагландинів у травному тракті, сприяючи секреції шлункового слизу. Збільшує секрецію серотоніну і простагландинів в шлунку, що сприяє зменшенню його запалення.

Екстракт листя меліси лікарської. Біологічно активні речовини стимулюють секрецію шлункового соку, покращують апетит, виявляють спазмолітичну і заспокійливу дію.

Екстракт кореня імбиру. Імбир має велику кількість біологічних функцій, зокрема антиоксидантну, протизапальну, протимікробну та інші. Одна з основних властивостей рослини - це стимуляція апетиту і моторної функції травного тракту. Також сприяє усуненню відчуття тяжкості в шлунку і при нудоті.

ЦІНА:

від 267.24

до 448.00 грн

ХПВ

1. Пантофітол спрямований на допомогу при ФД, а саме: на вісцеральну гіперчутливість, на покращення кінетики шлунка та на антральний відділ шлунка, що допомагає ефективно зняти головні симптоми ФД на відміну від «загально-заспокійливих» засобів. В іншому рослинному препараті в складі велика кількість трав, що потенційно збільшує ризик алергічних реакцій, на відміну від складу Пантофітола.
2. Пантофітол має форму випуску - капсулу, що полегшує прийом препарату для пацієнта, на відміну від іншого препарату в пастилках, який треба розсмоктувати впродовж певного часу, що може бути незручним для пацієнта
3. Повноцінний курс лікування Пантофітолом доступніший для пацієнта, на відміну від іншого препарату в пастилках. Пацієнт отримує ефективне лікування за доступною ціною, а ви впевнені у прихильності пацієнта до повного курсу лікування.

ПАНТОФІТОЛ



VS

ГАСТРИТОЛ



Пантофітол за рахунок комплексної дії, допомагає ефективно зняти головні симптоми ФД, без ризику побічних реакцій



В складі велика кількість трав, що потенційно збільшує ризик алергічних реакцій



Ціна за курс лікування 4 тиж 1200 грн



Пантофітол має лікарську форму у вигляді **капсул**, що не має смаку



Ціна за курс лікування 3 міс 1660 грн



У вигляді пастилок, що не завжди є зручним, та приємним на смак

ДОМПЕРИДОН (Домрид, Моторикс, Мотиліум)



Склад Домрид (основний конкурент з групи домперидона):

діюча речовина: домперидону малеат (domperidone maleate);

1 таблетка містить домперидону малеат еквівалентно домперидону 10 мг;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, Opadry II 31 G 58920 білий*.

*Opadry II 31 G 58920 білий: гіпромелоза, лактози моногідрат, **титану діоксид (E 171)**, поліетиленгліколь, тальк

Показання

Для полегшення симптомів нудоти та блювання.

Протипоказання

Домрид® протипоказаний:

- хворим зі встановленою підвищеною чутливістю до діючої або до допоміжних речовин лікарського засобу;
- хворим із пролактин-секреторною пухлиною гіпофіза (пролактиномою);
- хворим із тяжкими або помірними порушеннями функції печінки (див. розділи «Особливості застосування» та «Фармакологічні властивості»);
- хворим із відомим подовженням інтервалів серцевої провідності, зокрема QTc, хворим зі значними порушеннями балансу електролітів або із фоновими хворобами серця, такими як застійна серцева недостатність (див. розділ «Особливості застосування»);
- якщо стимуляція рухової функції шлунка може бути небезпечною, наприклад при шлунково-кишковій кровотечі, механічній непрохідності або перфорації;
- у разі одночасного застосування кетоконазолу, еритроміцину або інших сильнодіючих інгібіторів CYP3A4 (незалежно від їх

здатності подовжувати інтервал QT) (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»);

- у разі одночасного застосування лікарських засобів, які подовжують інтервал QT (за винятком апоморфіну), таких як флуконазол, еритроміцин, ітраконазол, пероральний кетоназол, посаконазол, ритонавір, саквінавір, талапревір, вориконазол, **кларитроміцин**, аміодарон, телітроміцин (див. розділи «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій» та «Особливості застосування»)

ХПВ

1. Пантофітол, на відміну від домперидону, впливає не тільки на антродуоденальну моторику та прискорення спорожнення шлунка, а й на вісцеральну чутливість, яка також притаманна для ФД, за рахунок адренергічних α_2 - агоністи, такі як клонідин, зменшують сприйняття болю під час розтягнення шлунка та товстої кишки та знімають біль у людей з ФД
2. На відміну від домперидону, Пантофітол можна використовувати разом з Кларитроміцином (основний АБ при ерадикації *H.pylori*). ФД може бути проявом *H.pylori*, Пантофітол допоможе зняти всі надокучливі симптоми ФД до, під час та після ерадикаційної терапії, без загрози побічних реакцій (аритмія, мерехтіння передсердь)
3. Пантофітол має форму випуску - капсулу, яка швидше діє – оболонка швидко розчиняється, вивільняючи діючу речовину, та краще переноситься – не подразнює слизову, особливо в гастроентерологічних препаратах.
4. Після застосування домперидону спостерігалися запаморочення і сонливість. Тому пацієнтам слід рекомендувати утриматися від керування автотранспортом, роботи з іншими механізмами або іншої діяльності, яка потребує концентрації уваги і координації, на відміну від Пантофітола, який не впливає на швидкість реакції, тому є безпечним для пацієнтів які керують автотранспортними засобами.

5. **Пантофітол має чистий фітотерапевтичний склад без потенційно небажаних допоміжних речовин, зокрема без діоксиду титану (E171).**

Домрид, у свою чергу, містить діоксид титану (E171) — барвник, який:

- з 2022 року **заборонений до використання в харчових продуктах у ЄС** через потенційні генотоксичні ризики
- викликає додаткові запитання щодо **тривалого застосування**, особливо у пацієнтів із захворюваннями ШКТ
- є небажаним компонентом для пацієнтів, орієнтованих на “*clean-label*” та натуральні рішення

6. **Пацієнти можуть не переживати за рівень пролактину в організмі, оскільки Пантофітол не впливає на гіпофіз, на відміну від домперидону.**

Наслідки підвищення пролактину:

- **У жінок:**
Порушення менструального циклу, безпліддя, проблеми з зачаттям, зниження лібідо, незвичайні молочні виділення.
 - **У чоловіків:**
Зниження лібідо, еректильна дисфункція, безпліддя.
 - **Загальні:**
Зміна настрою, депресія, головний біль, остеопороз.
7. Домперидон треба приймати по потребі 1 табл на добу максимум 7 днів, Пантофітол знімає симптоми ФД ефективно та без ризику побічних реакцій. Ваші пацієнти будуть Вам вдячні за турботу про їх здоров'я

ПАНТОФІТОЛ



VS

ДОМРИД



Пантофітол за рахунок комплексної дії, допомагає ефективно зняти головні симптоми ФД, включно з вісцеральною чутливістю



Пантофітол можна використовувати разом з Кларитроміцином (основний АБ при еридикації *H. pylori*)



Пантофітол не впливає на гіпофіз, на відміну від домперидону



впливає тільки на антродуоденальну моторику та прискорення спорожнення шлунка



Разом з Кларитроміцином є загроза побічних реакцій (аритмія, мерехтіння передсердь)



домперидон стимулює виділення пролактину з гіпофіза

ІТОПРИД (Ітомед, Ганатон, Ітоприд Ксантіс)



Склад:

діюча речовина: ітоприду гідрохлорид;

1 таблетка містить 50 мг ітоприду гідрохлориду;

допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль

```

прежелатинізований; натрію кроскармелоза; кремнію діоксид
колоїдний безводний; магнію стеарат; Opadry II White 85F 18422
(титану діоксид (E 171), спирт полівініловий, тальк,
поліетиленгліколь).
```

Показання

Купірування шлунково-кишкових симптомів функціональної невиразкової диспепсії (хронічного гастриту), а саме:

- здуття живота;
- відчуття переповненості шлунку;

- біль та дискомфорт у верхній частині живота;
- анорексія;
- печія;
- нудота;
- блювання.

ХПВ

1. **Пантофітол** має *чистий фітотерапевтичний склад без потенційно небажаних допоміжних речовин*, зокрема без діоксиду титану (E171).

Ітомед, у свою чергу, містить **діоксид титану (E171)** — барвник, який:

- з 2022 року **заборонений до використання в харчових продуктах у ЄС** через потенційні генотоксичні ризики
 - викликає додаткові запитання щодо **тривалого застосування**, особливо у пацієнтів із захворюваннями ШКТ
 - є небажаним компонентом для пацієнтів, орієнтованих на *“clean-label”* та натуральні рішення
2. "Ітоприду гідрохлорид активує пропульсивну моторику ШКТ завдяки антагонізму з допаміновими D2-рецепторами, також чинить протиблювотну дію завдяки взаємодії з D2-рецепторами." Пантофітол , активує моторику шлунка в антральному відділі, розслаблює в проксимальному, та знімає вісцеральну чутливість, на відміну від ітоприду гідрохлорид, Пантофітол впливає на всі симптоми ФД в шлунку.
 3. Пантофітол має форму випуску - капсулу, яка швидше діє – оболонка швидко розчиняється, вивільняючи діючу речовину,

та краще переноситься – не подразнює слизову, особливо в гастроентерологічних препаратах.

4. Курс лікування Пантофітолом коротший за ітоприд і складає 4 тижні, на відміну від ітоприд яке складає 8 тижнів, що дозволить Вашим пацієнтам скоріше позбавитись надокучливих симптомів ФД

ПАНТОФІТОЛ



- ✓ Пантофітол за рахунок комплексної дії, допомагає ефективно зняти головні симптоми ФД, включно з вісцеральною чутливістю
- ✓ Ціна за курс лікування 4 тиж **1200 грн**
- ✓ Пантофітол має лікарську форму у вигляді **капсул**

ІТОМЕД



- ✗ активує пропульсивну моторику ШКТ завдяки антагонізму з допаміновими D2-рецепторами, також чинить протиблювотну дію завдяки взаємодії з D2-рецепторами
- ✗ Ціна за курс лікування 8 тиж **2000 грн**
- ✗ У вигляді таблеток

РОБОТА З ІНГІБІТОРАМИ ПРОТОННОЇ ПОМПИ

ІПП	✗	ПАНТОФІТОЛ
-----	---	------------

Вплив ІПП на організм проходить в кілька етапів:
всмоктування в тонкій кишці, накопичення у секреторних каналцях обкладових клітин шлунка, активація під дією

соляної кислоти, утворення необоротної зв'язку з цистеїновими залишками протонних помп. ІПП пригнічують базальну та стимульовану секрецію соляної кислоти - ЯК НАСЛІДОК ЗНИЖЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ШЛУНКОВОГО СОКУ.

ПАНТОФІТОЛ:

Механізм дії:	Вплив на дно шлунку	Прийом Пантофітола дозволяє розслабити проксимальний відділ шлунка, щоб забезпечити простір для прийому їжі без підвищення шлункового тиску
	Вплив на вісцеральну гіперчутливість	адренергічні α_2 - агоністи, такі як клонідин, зменшують сприйняття болю під час розтягнення шлунка та товстої кишки та знімають біль у людей.
	Вплив на моторику	Пантофітол значно відновлював гіпомоторику антрального відділу шлунку в періоди до та після прийому їжі. Крім того, при кишковій дисфункції було відновлено затримку роботи ШКТ та збільшено виділення калу.



ПРИЄДНУЄМОСЬ ДО ІПП

“Ви вже контролюєте кислотність завдяки ІПП, додайте Пантофітол — він усуне гіперчутливість та покращить моторику, не втручаючись у роботу ІПП. Це ідеальний баланс для пацієнтів з функціональною диспепсією, без ризику виникнення гіпохлоргідрії.”

Лікування ФД, згідно з Римськими критеріями IV, повинно включати інгібітори протонної помпи. Раціонально їх призначення з прокінетиком та пробіотиком (*Saccharomyces boulardii*).

4.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ПАНТОФІТОЛ

Гастроентеролог та сімейний лікар:

- ФД:
 - СЕБ – синдром епігастрального болю
 - ПДС – постпрандіальний дистрес-синдром
 - Змішана форма
- Оверлап синдром ФД+СПК

СКРИПТИ:

1. Функціональна диспепсія (СЕБ — синдром епігастрального болю)

S — Situation (ситуація)

«Лікарю, у вас багато пацієнтів зі скаргами на епігастральний біль без органічного ураження ШКТ?»

P — Problem (проблема)

«Стандартно вони отримують ІПП, але при СЕБ біль часто зберігається, бо проблема не в кислоті, а в сенситивності та моторній дисфункції.»

I — Implication (ускладнення)

«Такі пацієнти роками живуть на “симптомних” схемах — біль повертається, з'являється тривожність, погіршується якість життя. ІПП не закривають патофізіологію СЕБ»

N — Need-payoff (вирішення)

«Пантофітол знижує гіперчутливість слизової, нормалізує моторну функцію шлунка і впливає саме на той компонент, де ІПП безсилі. Це дозволяє зменшити частоту рецидивів і потребу в тривалому прийомі кислотознижуючих»

2. Функціональна диспепсія ПДС (постпрандіальний дистрес синдром)

S - Situation (ситуація)

«Часто бачите пацієнтів з тяжкістю після їжі, швидким насиченням, здуттям?»

P - Problem (проблема)

«Більшість із них отримують або ІПП, або прокінетики, але ефект неповний: моторика шлунка не відновлюється, відтік жовчі порушений — звідси персистуючі симптоми»

I - Implication (ускладнення)

«Такі пацієнти «постійні повертаються»: ефект є, але нетривалий. Це знижує довіру пацієнта до терапії та до лікаря.»

N - Need-payoff (вирішення)

«Пантофітол Має комплексну дію: прокінетичну, розслаблення дна шлунку, зменшення вісцеральної чутливості. Це дозволяє досягати прогнозованого результату, за рахунок впливу на всю ланку патогенезу ФД.»

3. Оверлап синдром ФД + СПК

S - Situation (ситуація)

«Є пацієнти, у яких диспепсія поєднується зі спастичним або діарейним СПК?»

P- Problem (проблема)

«Ці пацієнти найбільш складні: верхні й нижні відділи реагують одночасно, є запалення низького ступеня (low-grade inflammation), порушення моторики та підвищена чутливість.»

I- Implication (ускладнення)

«Стандартна терапія рідко покриває всі механізми одразу. Пацієнт «мігрує» між сімейним лікарем та гастроентерологом, симптоми нестабільні, сильно страждає якість життя»

N- Need-payoff (вирішення)

«Пантофітол працює на рівні моторики та сенситивності шлунка, знижує функціональні навантаження на ШКТ і дає «заспокійливий» ефект на верхню частину травного тракту. Це дозволяє стабілізувати пацієнта з оверлап-синдромом і зменшити кількість рецидивів.»

ЕУПАТІЛЕКС



Дієтична добавка

Еупатілекс® Eupatilex

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Екстракт:	1 капсул а	Добова кількість (3 капсули)
------------------	---------------------------	---

листя полину д'Арґі (<i>Artemisia argyi</i>) (що містить 0,8-2,4 % еупатіліну, 0,25-0,75 % джейсеозидину)	60 мг	180 мг
---	--------------	---------------

Склад: наповнювач: мікрокристалічна целюлоза; густий екстракт листя полину д'Арґі (*Artemisia argyi*) (20 %); антизлежувачі: стеарат кальцію, діоксид кремнію; оболонка капсули: желатин.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 2-4 тижні. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: тромбоз (тромбоз судин головного мозку, інфаркт міокарда, тромбофлебіт тощо), коагулопатія, важкі порушення функцій печінки, нирок, серця, легень і захворювання крові, вагітність та період лактації, дитячий вік до 18 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 300 мг $\pm$ 7,5 % №30 у блістерах, упакованих у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, просп. Правди, 80-В.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110,

м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

Контроль якості!

Ваші відгуки і пропозиції приймаємо на електронну пошту

quality@behealth.com.ua

5.Картка продукту

ЕУПАТІЛЕКС® ПОЗИЦІОНУВАННЯ

ЕУПАТІЛЕКС - РОСЛИННИЙ ЦИТОПРОТЕКТОР, ЩО ЗАПУСКАЄ ПРИРОДНІ МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ТА ЗАХИЩАЄ ШЛУНОК БЕЗ ПОРУШЕННЯ КИСЛОТНОСТІ

ЯКИЙ:

- **Захищає від агресивних факторів (НПЗП, H.pylori, тощо)**
- Профілактує гастрит, виразки та продовжує ремісію
- Знімає запалення та прискорює загоєння ушкоджених ділянок
- Створює захисний шар слизу

ТОМУ ЩО:

- Не впливає на шлункову кислотність
- Пригнічує медіатори та фактори запалення
- Підвищує синтез білка та покращує місцеве кровопостачання
- Стимулює секрецію муцину

ЕУПАТІЛЕКС® КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЕУПАТІЛЕКС - РОСЛИННИЙ ЦИТОПРОТЕКТОР, ЩО ЗАПУСКАЄ ПРИРОДНІ МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ТА ЗАХИЩАЄ ШЛУНОК БЕЗ ПОРУШЕННЯ КИСЛОТНОСТІ

ЕУПАТІЛЕКС® МЕХАНІЗМ ДІЇ

- Стимулює секрецію мукоцитами одного з головних факторів захисту шлунку - МУЦИНУ, при цьому не впливаючи на шлункову кислотність
- Захист СОШ та дванадцятипалої кишки від впливу НПЗП шляхом підвищеного вивільнення ендогенного ПГ E2 і зниження вироблення ПГ F1α
- Зменшення негативного впливу H.pylori на СОШ завдяки вираженим антиоксидантним властивостям (запобігає перекисному окисненню ліпідів)

- Шляхом **регуляції рівнів супероксиддисмутази**, малонового диальдегіда та запальних факторів, відбувається захист від пошкоджувальної дії алкоголю

Еупатілекс не просто полегшує симптоми (біль, печія, дискомфорт), а працює на рівні захисту слизової, зменшення запалення та стимуляції регенерації.

1. Завдяки натуральним фітоекстрактам, мінімум побічних ефектів, можливість довготривалого застосування без ризику звикання чи системного навантаження.
2. Може бути використаний як ад'ювантна підтримка при НПЗП-гастропатіях або після ерадикаційної терапії, коли шлунок і слизова ще уразливі
3. Натуральний компонент, збагачений склад, який виділяє його серед інших БАДів або препаратів для гастропротекції.

5.Конкуренти

КОНКУРЕНТНЕ ОТОЧЕННЯ



Склад:

60 мг екстракту листя полину *Artemisiae Argyi*, м'який (20:1), що містить 0,48–1,44 мг еупатіліну та 0,15–0,45 мг джейсеозидину, екстрагент етанол 95 %

Показання

Лікування уражень слизової оболонки шлунка (ерозії, геморагії, гіперемія, набряк) при гострих і хронічних гастритах, у тому числі викликаних інфекцією *Helicobacter pylori*.

Профілактика гастритів, викликаних прийомом НПЗЗ.

ЕУПАТІЛЕКС®



СТИЛЕН®



1

точність дозування екстракту без допоміжних наповнювачів

2

легше ковтати, немає присмаку

3

Швидший початок дії, там де необхідно

1

допоміжні наповнювачі, можуть впливати на абсорбцію.

2

Має присмак

3

таблетка з твердим покриттям, починає діяти пізніше за капсулу

ЕУПАТІЛЕКС®



СТИЛЕН®



VS



Еупатілекс містить густий екстракт *Artemisia argyi*, з високим вмістом еупатіліну та джейсеозидину



Еупатілекс можна використовувати з 12 років, що ще раз підтверджує безпеку застосування Еупатілексу



Ціна за курс лікування 4 тиж **900грн**



Еупатілекс має лікарську форму у вигляді **капсул**, що не має смаку



Вміст еупатіліну та джейсеозидину нижчий



Ціна за курс лікування 4 тиж **1518грн**



Можна використовувати з 18 років



Має форму **таблеток**, тому частина поживних елементів може просто не дійти до шлунка; таблетки **мають неприємний смак** або післясмак за рахунок покриття на ній;

ХПВ

1. Еупатілекс містить густий екстракт *Artemisia argyi*, з високим вмістом еупатіліну та джейсеозидину та не містить в своєму складі еталон 95%, на відміну від іншого рослинного препарату (Стилен) . Ваш пацієнт отримає захист шлунка без потенційно

шкідливих інгредієнтів, та мінімальними ризиками побічних ефектів.

2. Повноцінний курс лікування Еупатілексом доступніший для пацієна, на відміну від конкурентів. Пацієнт отримує ефективне лікування за доступною ціною, а ви впевнені у прихильності пацієнта до повного курсу лікування.
3. Еупатілекс має лікарську форму у вигляді капсул, що не має смаку. Покриття іншого рослинного препарату у таблетках, має покриття, яке може викликати неприємні відчуття, як у роті так і в шлунку.
4. Еупатілекс має зручну форму випуску, а саме блістери по 10 капсул, що дає змогу пацієнту купити необхідну для його лікування кількість таблеток, на відміну від іншого рослинного препарату з формою випуску по 30 таблеток в тубі



Склад:

ребаміпід 100 мг;

Показання

У складі комплексного лікування хронічного гастриту з підвищеною кислотоутворювальною функцією шлунка у стадії загострення, ерозивного гастриту, функціональної диспепсії.

Запобігання виникненню ушкоджень слизової оболонки на тлі прийому нестероїдних протизапальних засобів.

СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ (ВИКОРИСТОВУЄМО ХПВ)

ЕУПАТІЛЕКС®	МУКОГЕН®
 БЕЗ РЕЦЕПТУ	 ЗА РЕЦЕПТОМ
✓ Еупатілекс містить натуральні компоненти з протизапальними та регенеративними властивостями	✗ містить ребаміпід — синтетичний склад
✓ Еупатілекс можна використовувати з 12 років, що ще раз підтверджує безпеку застосування Еупатілексу	✗ Можна використовувати з 18 років
✓ Ціна за курс лікування 4 тиж 900грн	✗ Ціна за курс лікування 4 тиж 1359 грн
✓ Еупатілекс не впливає на швидкість реакції	✗ можуть виникати запаморочення, не можна сідати за кермо

1. Еупатілекс містить густий екстракт *Artemisia argyi*, з високим вмістом еупатіліну та джейсеозидину, який на відміну від синтетичних препаратів містить натуральні компоненти з протизапальними та регенеративними властивостями. Ваш пацієнт отримує захист шлунка без синтетичних інгредієнтів, та з мінімальними ризиками побічних ефектів.
2. **АПТЕКА:** Коли до Вас звертаються за рецептурним препаратом, такими як Мукоген, а рецепту в людини немає, ви можете порекомендувати Еупатілекс, який ефективно і надійно позбавить клієнта надокучливих симптомів ГЕРХ
3. Еупатілекс можна використовувати для пацієнтів з різним рівнем кислотності шлунка, без ризику порушення кислотного балансу, на відміну від іншого синтетичного препарату, який можна використовувати тільки при підвищеній кислотності шлунка .
4. Еупатілекс можна використовувати в лікуванні пацієнтам, які керують автотранспортними засобами, на відміну від іншого

синтетичного препарату, який може викликати сонливість та запаморочення, що може мати ризик ДТП на дорозі.

5. Повноцінний курс лікування Еупатілексом доступніший для пацієнта, на відміну від синтетичного препарату. Пацієнт отримує ефективне лікування за доступною ціною, а ви впевнені у прихильності пацієнта до повного курсу лікування.

СТРАТЕГІЯ ПРИЄДНАННЯ (ХПВ НЕ ВИКОРИСТОВУЄМО)



При приєднанні до Мукогена використовуємо таку схему:

- Профілактика загострення - ЕУПАТІЛЕКС
- Гострий стан - МУКОГЕН
- Підтримка після основного лікування - ЕУПАТІЛЕКС

ПОЗИЦІОНУЄМО ЦЮ СХЕМУ: Еупатілекс- коли треба зберегти результат

ПЕРЕВАГИ ЕУПАТІЛЕКС ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

	Еупатілекс	Стилен	Мукоген
Містить етанол	-	+	-
Натуральний склад	+	+	-
Блістерна форма	+	-	+
Ціна	300 грн	506 грн	455 грн
З якого віку дозволений	12	18	18
Містить барвники	-	+ Містить барвник тартразин (Е 102), який може спричинити алергічні реакції.	-



5.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ЕУПАТІЛЕС

Гастроентеролог:

- НПЗП-асоційовані гастропатії
- Функціональна диспепсія
- Хронічний гастрит (неасоційований з *H. pylori*)
- Жовчний рефлюкс-гастрит
- Стан після ерадикаційної терапії, коли залишаються симптоми
Пацієнти, що не переносять ІПП або відмовляються від них
- Гострий та хронічний гастрит, в тому числі викликаний
бактерією *Helicobacter pylori*
- Захист слизової оболонки шлунку при застосуванні препаратів
для ерадикації *Helicobacter pylori*
- Загострення гастриту на фоні стресу

Сімейні лікарі:

- Реактивні гастрити
- Пацієнти з нерегулярним харчуванням, стресовими
навантаженнями
- Після прийому НПЗП або антибіотиків

Ендоскопіст:

- Виявлені ерозії/реактивні гастрити
- Рефлюкс жовчі
- Дистрофія слизової шлунка

СКРИПТИ

1. НПЗП-асоційовані гастропатії

S (situation):

- Серед ваших пацієнтів, які регулярно приймають НПЗП - відмічають дискомфорт у шлунку?

P (problem):

- Чи згодні, що ІПП не завжди достатньо, а у частини - непереносимість або небажання тривалого прийому?

I (implication):

- Незахищена слизова - ризик ерозій, болю, диспепсії навіть на фоні профілактики.

N (need/payoff):

- Еупатілекс - рослинний цитопротектор, який:
- зменшує запалення слизової
- стабілізує бар'єр, за рахунок вироблення муцину
- не знижує кислотність.

Його можна додавати до НПЗП як м'яку фізіологічну гастропротекцію.

2. Хронічний гастрит

S - Situation (ситуація)

- Лікарю, як часто у вашій практиці зустрічаються пацієнти з хронічним гастритом, у яких Н. рулогі вже виключено, але симптоми все одно зберігаються?

P - Problem (загострення проблеми)

- Як правило, ці пацієнти випадають з активного лікування, бо стандартні підходи - насамперед ІПП - не перекривають основного механізму: хронічного запалення слизової, яке не пов'язане з кислотністю. *У результаті:*

- пацієнт роками живе з періодичним болем і дискомфортом,
- симптоми повертаються при найменшому тригері (стрес, харчові похибки),
- формується підірвана якість життя й відчуття "гастрита, що ніколи не минає".

I - Implication (наслідки та ризики)

Якщо запалення слизової ніяк не контролюється:

- слизова стає хронічно вразливою,
- ризик переходу в атрофічні зміни зростає,
- симптоми поступово стають частішими й менш контрольованими,
- пацієнти починають самостійно пити ІПП “курсами”, що лише маскує проблему, але не вирішує її.

Такі пацієнти зазвичай довго “мігрують” між спеціалістами, бо не отримують корекції запального компоненту, який і є ключовим.

N - Need / Payoff (виявлення потенціалу)

Саме для цієї групи пацієнтів може бути цінним Еупатілекс, оскільки він:

- діє на первинний механізм - запалення слизової,
- не впливає на кислотність та не викликає гіпохлоргідрії,
- може застосовуватися довше та безпечно,
- допомагає стабілізувати слизову, зменшити рецидиви та повернути якість життя.

3. Жовчний рефлюкс-гастрит

Situation (ситуація):

- Чи є у вас пацієнти з печією, болем і гіркотою, у яких виявлено дуоденогастральний рефлюкс?

P- Problem (загострення проблеми):

- Чи згодні, що ІПП тут мало ефективні, адже причина — жовчні кислоти, а не кислота шлунка?

I- Implication (наслідки та ризики):

- Тривала жовчна агресія ушкоджує слизову, викликає хронічне запалення, що призводить до хронічного гастриту, та дуже впливає на якість життя пацієнта.

N- Need / Payoff (виявлення потенціалу):

Еупатілекс — один із небагатьох засобів, який безпечно зменшує запалення, викликане жовчними кислотами, та покращує її відтік, за рахунок зняття набряку сфінктера Одді.

Це дає пацієнтам значне полегшення, та покращують якість життя.

4. Захист слизової при ерадикації H. pylori

S - Situation (ситуація)

Лікарю, чи помічали ви, що під час ерадикації *H. pylori* у частини пацієнтів уже на 3–5 день з'являються скарги на дискомфорт у шлунку, гіркоту, нудоту або посилення печії?

P - Problem (проблема)

Ерадикаційна схема — це подвійне навантаження: два антибіотики, високі дози ІПП, інколи вісмут.

Усе це різко збільшує подразнення слизової та зменшує продукування захисного слизу.

В результаті частина пацієнтів:

- переносить терапію гірше,
- пропускає прийоми,
- або навіть перериває курс, що напряду впливає на ерадикацію.

I - Implication (наслідки)

Коли слизова не захищена: підвищується частота побічних реакцій від антибіотиків, пацієнт відмовляється від лікування або приймає нерегулярно, знижується ефективність ерадикації, зростає ризик резистентності *H. pylori*, ви отримуєте пацієнта з повторним гастритом та потребою у новій схемі.

Тобто проблема переносимості напряду впливає на ваш кінцевий результат лікування.

N — Need / Payoff (потреба)

Еупатілекс допомагає захистити слизову саме під час ерадикації:

- природна гастропротекція без впливу на кислотність,
- зменшення запалення й оксидативного стресу (еупатілін + джейсезидин),
- зниження ризику дискомфорту та болю,
- покращення прихильності пацієнта до повного курсу,
- підтримка слизового бар'єра навіть при високому навантаженні антибіотиками.

5. Загальний скрипт візиту

Вступна частина:

Доброго дня! Як завжди, радий/а бачити Вас. Сподіваюся, Ваш день не дуже напружений, і Ви знайдете кілька хвилин для обговорення нових можливостей у лікуванні гастроентерологічних захворювань. Я хотів/ла б поділитися з вами інформацією про препарат, який може бути корисним у Вашій практиці, зокрема для пацієнтів, які страждають від гастритів і гастропатій.

Опис ситуації:

Не так давно на конференції з гастроентерології обговорювали, що багато пацієнтів, які приймають НПЗП для лікування хронічних болей або запальних захворювань, стикаються з проблемами боку шлунково-кишкового тракту. А Ви часто стикаєтеся з такими пацієнтами у Вашій практиці?

Проблематика:

Як правило, для таких пацієнтів важливим є призначення засобів для захисту слизової оболонки шлунку від шкідливого впливу НПЗП. Яку схему терапії ви застосовуєте для таких пацієнтів?

Актуалізація:

Як Ви вважаєте, якщо не вжити заходів для відновлення слизової оболонки шлунка, може це призвести до серйозніших ускладнень та рецидивів? Чи згодні Ви, що препарати, які одночасно сприяють загоєнню слизової і захищають її від подальших ушкоджень, можуть бути більш ефективними для таких пацієнтів?

Направлення:

Я впевнений/а, що Ви хочете обрати найбільш ефективну і безпечну терапію для пацієнтів, які приймають НПЗП протягом тривалого часу.

ТРИВИТАФЕР



Дієтична добавка

Тривітафер

"Залізо хелат" ("IRON CHELATE")

1 таблетка містить:	Рекомендована добова кількість (1 таблетка)
Бісгліцинат заліза	90 мг (mg), у перерахунку на залізо 18 мг (mg), що відповідає 128,6 %*

** - відсоток від референсної величини споживання мінеральних речовин для дорослих (осіб старше 18 років).*

Склад: наповнювач: мікрокристалічна целюлоза; бісгліцинат заліза (30 %); антизлежувачі: стеарат кальцію, діоксид кремнію.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело заліза.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати по 1 таблетці 1 раз на добу під час їжі. Запивати достатньою кількістю води. Не розжовувати.

Перед споживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Термін споживання: 30 днів. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Споживання у період вагітності та лактації тільки за призначенням лікаря.

Протипоказання: підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, дитячий вік до 18 років.

Форма випуску: таблетки масою 300 мг $\pm$ 10 % №30 у блістерах, упакованих у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці у сухих, чистих, захищених від світла, вентильованих приміщеннях за температури не вище 25 °C і відносній вологості повітря не більше 75 %, у недоступному для дітей місці.

Виробник, оператор ринку, відповідальний за інформацію для споживача:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, просп. Європейського Союзу (Правди), 80-В.

Замовник і власник торговельної марки для товарів і послуг:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 (044) 592 68 62; www.behealth.com.ua.

Детальну інформацію дивитись у Листку-вкладиші.

ТУ У 10.8-39499966-006:2020

6.Картка продукту

ТРИВІТАФЕР ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Тривітафер (бісгліцинат заліза) – хелатна форма заліза з високою біодоступністю та чистим складом, лише 100% заліза

Який:

- доставляє залізо в кишківник вже у зв'язаному (амінокислотному) вигляді
- всмоктується легко: через PEPT1 — так само, як амінокислоти та пептиди
- не подразнює слизову шлунка і кишківника
- забезпечує стабільне підвищення феритину без шлунково-кишкових побічних реакцій

Тому що містить:

- бісгліцинат заліза — хелат, захищений двома молекулами гліцину, який не залежить від кислотності шлунка та не конкурує за DMT1
- засвоюється швидше та ефективніше, навіть у пацієнтів на ІПП, з гастритом чи запаленням кишківника
- забезпечує повноцінне відновлення запасів заліза при низьких дозах

ТРИВІТАФЕР КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Тривітафер - забезпечує високе засвоєння заліза без нудоти, запору та болю, тому що не залишає вільного іонного заліза в кишківнику

ТРИВІТАФЕР МЕХАНІЗМ ДІЇ

Бісгліцинат заліза — це хелатна форма заліза, де одна молекула Fe^{2+} зв'язана з двома молекулами гліцину.

Такий комплекс захищає залізо від взаємодії зі шлунковою кислотою та робить його засвоєння максимально фізіологічним і щадним для ШКТ.

ШЛЯХ ХЕЛАТОВАНОГО ЗАЛІЗА (БІСГЛІЦИНАТ)

(Залізо + дві молекули гліцину → "хелат")

Як всмоктується:

1. Комплекс (Fe^{2+} —гліцин) НЕ розпадається у шлунку, не взаємодіє з кислотою
2. Потрапляє в тонкий кишечник у незмінному вигляді
3. Всмоктується не через DMT-1, а через PEPT1 — транспортер пептидів/амінокислот
4. Оминає етап відновлення $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$, тому засвоєння стабільніше
5. Мінімум вільного заліза в просвіті кишечника → менше побічних ефектів

Висновок: бісгліцинат заліза не має залежність від DMT1 в порівнянні із звичайним сульфатом заліза. Це означає, що хелатована форма має альтернативний шлях всмоктування, що може пояснювати її кращу біодоступність і меншу чутливість до умов шлунково-кишкового тракту (наприклад, при низькому рН або при супутньому прийомі антацидів)
PEPT1 → швидше та фізіологічніше, без подразнення слизової

6.Конкуренти

КОНКУРЕНТНЕ ОТОЧЕННЯ СОРБІФЕР ДУРУЛЕС



СКЛАД:

320 мг заліза сульфату безводного (що відповідає 100 мг заліза двовалентного), 60 мг кислоти аскорбінової

Показання

Профілактика і лікування залізодефіцитної анемії.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу;
стеноз стравоходу та/або інші обструктивні захворювання шлунково-кишкового тракту; пептична виразка, виразковий коліт у фазі загострення; дивертикул кишечника; кишкова непрохідність; стани, що супроводжуються підвищеним накопиченням заліза (гемохроматоз, гемосидероз); повторна гемотрансфузія; інші види анемій, не зумовлені дефіцитом заліза (наприклад апластична та гемолітична анемія, хронічний гемоліз, анемія, спричинена недостатністю вітаміну В12); порушення механізмів включення заліза у гемоглобін (анемія, що спричинена отруєнням свинцем) сидероахрестична анемія; тромбоз, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, тяжкі захворювання нирок; одночасне застосування парентеральних форм заліза; розлад механізмів виведення заліза (таласемія); **цукровий діабет;** сечокам'яна хвороба (при застосуванні аскорбінової кислоти понад 1 г на добу); непереносимість фруктози.

ВСМОКТУВАННЯ ЗАЛІЗА Fe^{2+} / Fe^{3+} : сульфат, фумарат, глюконат

Як відбувається всмоктування:

1. Fe^{3+} у шлунку має відновитися до Fe^{2+} (потрібне кисле рН + вітамін С)
2. У тонкому кишечнику Fe^{2+} всмоктується через переносник DMT-1 (divalent metal transporter 1)
3. DMT-1 має низьку пропускну здатність, тому частина заліза не засвоюється
4. Незасвоєне залізо подразнює слизову → нудота, запор, діарея, біль

Головні обмеження:

-залежність від кислотності (ІПП, антациди - знижують всмоктування)

-конкуренція з Ca^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+} - високі дози = більше побічних ефектів

ВІДМІННІСТЬ ЗАЛІЗА

Параметр	Неорганічне залізо (сульфат/фумарат)	Бісгліцинат заліза
Транспортер	DMT-1 (метал-іонний)	PEPT-1 (пептидний)
Залежність від pH	Так	Ні
Конкуренція з Ca^{2+} , Zn^{2+}	Так	Практично відсутня
Подразнення слизової	Високе	Низьке
Біодоступність	10–20%	91%

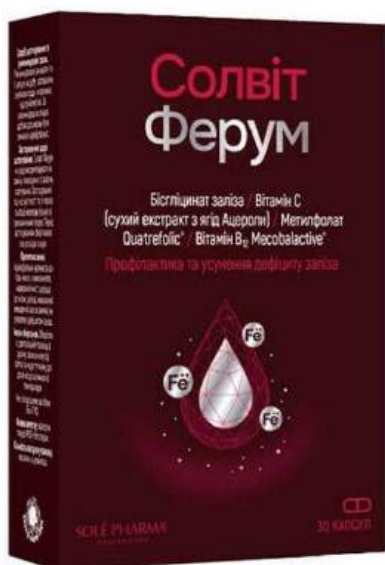
ХПВ

1. Тривітафер містить бісгліцинат заліза — органічну форму, що утворює стабільний хелат з гліцином. Завдяки цьому залізо всмоктується не через іонні транспортери (DMT-1) як інший препарат з сульфатом заліза та аскорбіновою кислотою, а через пептидні канали PEPT-1, забезпечуючи вищу біодоступність навіть при низькій кислотності шлунка, що важливо для пацієнтів гастроентерологічного профілю
2. Біодоступність бісгліцинату заліза вища на 40–60% порівняно з сульфатом заліза. Це дозволяє ефективно підвищувати рівень феритину навіть при менших дозах елементарного заліза.
3. Завдяки стабільному хелату залізо не вивільняється в просвіті кишечника, на відміну від сульфату заліза, тому не подразнює слизову. Тривітафер добре переноситься пацієнтами, навіть тими, хто має непереносимість сульфатів або фумаратів.
4. Тривітафер не потребує кислого середовища для відновлення $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$, тому ефективний у пацієнтів із гіпоацидним гастритом, атрофією слизової або при тривалому прийомі

антисекреторних препаратів, на відміну від сульфата заліза, якому необхідне кисеє середовище для засвоєння.

5. Бісгліцинат заліза не вступає у конкурентне зв'язування з кальцієм чи цинком, тому може призначатися пацієнтам із полімінеральними або полівітамінними комплексами, на відміну від сульфата заліза, який конкурує з кальцієм та цинком за транспортер DMT-1
6. Залізо у формі хелату не генерує вільних радикалів у кишківнику, що знижує ризик запалення слизової та дисбіозу, на відміну від сульфата заліза, яким має як побічні реакції зі сторони ШКТ так і певні протипокази, якщо людина має захворювання ШКТ.
7. На відміну від сульфату заліза, Тривітафер можна застосовувати у пацієнтів із гастритом, колітом, ЗЗК чи синдромом подразненого кишечника.
8. Завдяки відсутності металевого присмаку та шлункових реакцій, на відміну від сульфату заліза, пацієнти частіше завершують курс лікування.
9. Забезпечує фізіологічне покриття добової потреби у залізі без перевантаження — ідеально для тривалих курсів або профілактики в групах ризику (жінки, донори, пацієнти з хронічними захворюваннями), на відміну від сульфату заліза, який має низку побічних реакцій

СОЛВІТ ФЕРУМ



СКЛАД:

- 1 капсула містить: активні інгредієнти: амінокислотний хелат заліза (біогліцинат заліза) – 150 мг (mg) (у перерахунку на елементарне залізо 30 мг (mg)), сухий екстракт з ягід Ацероли – 25 мг (mg) (містить вітаміну С – 20 мг (mg)), метилфолат Quatrefolic® ((6S)-5-метилтетрагідрофолат) – 200 µg (мкг), вітамін В12 Mecobalactive® (метилкобаламін) – 9 µg (мкг);
- *допоміжні речовини*: інулін, магнію стеарат (антиспікаючий агент); оболонка капсули: желатин.

Рекомендації щодо застосування

Солвіт Ферум рекомендований для використання в раціонах дієтичного харчування як джерело вітамінів, біологічно активних речовин з метою загального зміцнення організму і створення оптимальних дієтологічних умов функціонування нервової, кровотворної системи для підсилення гемопоезу та попередження виникнення дефіциту заліза і вітамінів. Попередження латентного дефіциту заліза та клінічно вираженого дефіциту заліза, дефіциту заліза і фолієвої кислоти у період до вагітності, під час вагітності та у період годування груддю.

ХПВ

1. **Чистий моносклад Тривітаферу (без вітамінів, фолатів і кислот) дозволяє лікарю індивідуально контролювати корекцію дефіциту заліза, на відміну від комбінованих препаратів, де фіксовані дози вітамінів можуть бути зайвими або небажаними для окремих пацієнтів**
2. **Тривітафер дозволяє лікарю гнучко комбінувати залізо з іншими препаратами за потреби, тому краще підходить для поетапної або персоналізованої терапії, на відміну від іншого препарату, де склад фіксований і не підлягає корекції**
3. **Тривітафер містить нижчу, фізіологічну дозу елементарного заліза (18 мг), що краще переноситься пацієнтами з чутливим ШКТ або супутніми гастроентерологічними захворюваннями, на відміну від Солвіт Ферум, де доза 30 мг може підвищувати ризик нудоти та дискомфорту у частини пацієнтів**
4. **Простий склад Тривітаферу підвищує прихильність пацієнтів до лікування, оскільки менше компонентів — менше причин припинити терапію, на відміну від комбінованих препаратів, де побічні реакції можуть бути пов'язані не із залізом, а з додатковими інгредієнтами.**

МАЛЬТОФЕР



Склад

діюча речовина: 1 таблетка містить 357 мг заліза (III) гідроксиду полімальтозату, що еквівалентно 100 мг заліза;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, какао порошок, натрію цикламат, поліетиленгліколь 6000, тальк, ванілін, декстрати, ароматизатор шоколадний.

Показання

- Лікування дефіциту заліза без анемії та залізодефіцитної анемії.
- Дефіцит заліза та його ступінь має підтверджуватися відповідними лабораторними дослідженнями.

Протипоказання

- Наявна підвищена чутливість або непереносимість діючої речовини, або будь-якого компонента препарату;
- надмірний вміст заліза в організмі (наприклад, гемохроматоз, гемосидероз);
- розлад механізмів виведення заліза (свинцева анемія, сидероахрестична анемія, таласемія);

- анемії, не зумовлені дефіцитом заліза (наприклад, гемолітична анемія, мегалобластна анемія, спричинена недостатністю вітаміну B12).

Критерій	Тривалентне залізо (III) гідроксиду з полімальтозою(Fe ³⁺)	Бісгліцинат заліза (хелатна форма) (Fe ²⁺)
Біодоступність	Низька	Висока (1 з найвищих)
Переносимість ШКТ	Може спричиняти нудоту, діарею	Найкраща переносимість (мінімальні побічні реакції)
Взаємодія з їжею	Так	Мінімальна — можна приймати з їжею
Необхідність високих доз	Високі	Низькі (краща абсорбція → менша доза)
Ризик потемніння емалі, металевий присмак	Може бути	Практично відсутній
Взаємодія з антацидами/ІПП	Висока (вимагає кислого середовища)	Незначна
Підходить при гастритах / ГЕРХ / чутливому ШКТ	Обмежено	Так
Підходить вагітним / пацієнтам з довготривалим прийомом	Обмежено	Оптимально, не протипоказано
Вартість терапії	Середня	Середня–вища, але виправдана
Форма	Неорганічна	Хелатована (амінохелат)

ХПВ

1. Тривітафер містить двовалентне залізо у хелатній формі (бісгліцинат Fe²⁺), яке засвоюється через PEPT1, тоді як Мальтофер містить тривалентне залізо (Fe³⁺), що потребує

додаткових етапів перетворення в організмі та має нижчу швидкість засвоєння.

2. **Бісгліцинат заліза у Тривітафері не залежить від кислотності шлунка**, тому може ефективно застосовуватися у пацієнтів з гастритом, на ІПП або антацидах, **на відміну від Мальтоферу**, всмоктування якого може бути менш прогнозованим при порушеній кислотності.
3. **Тривітафер забезпечує стабільне підвищення феритину при низькій дозі елементарного заліза (18 мг)**, що знижує ризик побічних реакцій, **на відміну від Мальтоферу**, який часто потребує вищих доз і тривалішого курсу для досягнення аналогічного ефекту.
4. **Хелатна форма заліза у Тривітафері мінімально взаємодіє з їжею та іншими мінералами**, що спрощує режим прийому та підвищує прихильність пацієнта, **на відміну від Мальтоферу**, де ефективність може залежати від часу прийому та раціону
5. **Тривітафер має простий та “чистий” склад без цукрів і полімерних комплексів**, що робить його кращим вибором для пацієнтів з метаболічними порушеннями або чутливим ШКТ, **на відміну від Мальтоферу**, який містить комплекс заліза з полімальтозою

6.Скрипти

Спеціальність	Основні патології	Ключовий аргумент для візиту
Гастроентеролог	гастрит, целиакія, ЗЗК, мальабсорбція	засвоєння через PEPT1 навіть при низькій кислотності
Ендокринолог	діабет, гіпотиреоз, метаболічний синдром	корекція латентного дефіциту без впливу на метаболізм
Сімейний лікар	латентний дефіцит, постінфекційна астения, донори	м'яке відновлення без побічних ефектів
Колопроктолог	геморой, тріщини, НВК, крововтрата	не подразнює слизову, безпечний при проктопатіях

СКРИПТИ

1. Гастрит / целиакія / ЗЗК / мальабсорбція

S – Situation

Лікарю, як часто до Вас звертаються пацієнти з гастритом, ЗЗК або целиакією (синдром мальабсорбції), у яких знижений феритин навіть без симптомів анемії?

P – Problem

У таких пацієнтів класичні солі заліза (фумарат, сульфат, глюконат) часто або не засвоюються, або провокують біль, нудоту, діарею, загострення з боку слизової.

I – Implication

У результаті:

- пацієнти припиняють терапію,
- феритин не відновлюється,
- формується хронічна втома і прогресування дефіциту.

Особливо складно це коригувати при запаленні або порушенні абсорбції.

N – Need–payoff

Тривітафер містить **бісгліцинат заліза** — хелат, який:

- всмоктується **через PEPT1, як амінокислота**,
- **не потребує інтактної слизової**,
- **не подразнює ШКТ**.

Це дає можливість безпечно коригувати дефіцит заліза навіть у пацієнтів з мальабсорбцією

2.Діабет / гіпотиреоз / метаболічний синдром

S

У пацієнтів з ендокринною патологією ви часто бачите латентний дефіцит заліза?

P

При цьому більшість препаратів заліза:

- потребують високих доз,
- взаємодіють з мінералами,
- погано підходять для тривалого застосування.

I

Дефіцит заліза погіршує:

- чутливість до інсуліну,
- функцію щитоподібної залози,

- рівень енергії та комплаєнс пацієнта.

N

Тривітафер — **чистий бісгліцинат без цукрів та зайвих компонентів:**

- працює у низькій дозі,
- не конкурує з іншими мікронутрієнтами,
- підходить для тривалого прийому.

Оптимальний варіант для пацієнтів з діабетом і МС, які мають дефіцит заліза.

3. Латентний дефіцит / постінфекційна астенія / донори

S

Чи часто ви бачите пацієнтів зі слабкістю, але з нормальним гемоглобіном?

P

Латентний дефіцит заліза часто недооцінюють, особливо після інфекцій або регулярного донорства.

I

Без корекції:

- знижується працездатність,
- сповільнюється відновлення,
- формується справжня анемія.

N

Тривітафер дозволяє:

- **фізіологічно підвищувати феритин,**
- без перевантаження залізом,
- без шлунково-кишкових побічних реакцій.

Тривітафер - Ідеальне рішення для раннього втручання та профілактики залізодефіцитної анемії.

4. Геморой / анальні тріщини / НВК / хронічні крововтрати

S

Пацієнти з хронічними крововтратами — складна група для призначення заліза, так?

P

Солі заліза часто:

- викликають запор,
- посилюють біль,
- погіршують перебіг проктологічних проблем.

I

У результаті пацієнт:

- не дотримується лікування,
- залишається у стані хронічного дефіциту заліза.

N

Бісгліцинат у складі Тривітаферу:

- не подразнює кишківник,
- не впливає на перистальтику,
- дозволяє відновлювати запаси заліза без погіршення симптомів.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ТІРБІЗОД



TIRBIZOD® TIRBIZOD з цукром

Дієтична добавка

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 таблетці:

селен (у формі селенометіоніну)	100 мкг (µg)	181,8 %*
йод (у формі йодиду калію)	150 мкг (µg)	100,0 %*

** - відсоток від референсної величини споживання мінеральних речовин для дорослих (осіб старше 18 років).*

Склад: наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; селен (у формі селенометіоніну (30,3 %)); наповнювачі: лактози моногідрат, крохмаль картопляний; антиспікаючі агенти: стеарат кальцію,

аеросил; йод (у формі йодиду калію (0,1 %)); оболонка таблетки біла (у складі: наповнювач: цукор; розчинник: вода підготовлена; наповнювач: карбонат магнію, наповнювач: аеросил; стабілізатор: полівінілпіролідон; барвник: оксид титану; глазуруючий агент: віск бджолиний).

Рекомендації щодо споживання: в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело йоду та селену. Може використовуватись для збагачення раціону жителів регіонів з обмеженим постачанням йоду з навколишнього середовища.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 3 місяці. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. У разі одночасного споживання засобів для підтримки функції щитоподібної залози, перед початком споживання рекомендується попередня консультація з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів дієтичної добавки, дитячий вік до 18 років, період вагітності та годування груддю, функціональні порушення з боку органів дихання та кровоносної системи, висипання на шкірі, що пов'язані із непереносимістю глютену.

Форма випуску: таблетки, вкриті цукровою оболонкою, по 25 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці або по 60 таблеток у контейнері полімерному, упакованому у картонну коробку.

8.Картка продукту

Ключове повідомлення

Тірбізод - оптимальний баланс йоду та селену з найкращою біодоступністю для щоденної підтримки функції щитоподібної залози та захисту від окислювального стресу.

Позиціонування

Тірбізод – збалансований антиоксидантний комплекс для підтримки щитоподібної залози,

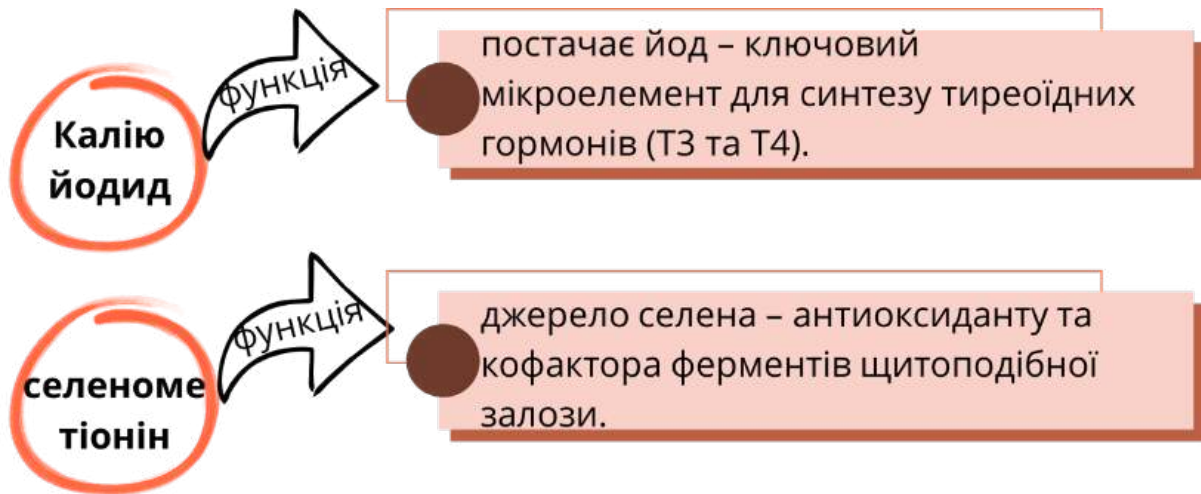
Який :

- підтримує баланс гормонів ЩЗ,
- сприяє зміцненню імунної системи,
- захищає організм від негативного впливу оксидативного стресу,

Тому що містить:

- йод – необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози,
- селенометіонін – високобіодоступну форму селену, який є синергістом йоду, а також підтримує антиоксидантний захист.

Механізм дії



1. Калію йодид

Механізм дії:

- Доставка йоду до щитоподібної залози:**
 - Йод активно поглинається фолікулярними клітинами щитоподібної залози через натрій-йодний симпортер (NIS).
- Синтез тиреоїдних гормонів:**
 - Йод використовується для йодування тиреоглобуліну → утворюються тироксин (T4) та трийодтиронін (T3).
- Регуляція функції щитоподібної залози:**
 - Достатній рівень йоду сприяє нормальному рівню гормонів, зменшує стимуляцію тиреотропним гормоном (TSH), що запобігає розвитку зоба.

2. Селенометіонін

Механізм дії:

1. Антиоксидантний захист:

- Селен є частиною глутатіонпероксидаз (GPx) та дегідрогенази $T4 \rightarrow T3$ (деїодинази).
- Зменшує окислювальний стрес у щитоподібній залозі та периферичних тканинах.

2. Перетворення $T4$ у $T3$:

- Селен-залежні деїодинази каталізують перетворення тироксину ($T4$) у активний трийодтиронін ($T3$), що покращує ефективність гормональної регуляції.

3. Імуномодулюючий ефект:

- Селен допомагає зменшити аутоімунне запалення при аутоімунних процесах щитоподібної залози, захищаючи клітини від ушкодження.

8. Конкуренти

Ключові конкуренти

Йосен



Склад

1 таблетка містить:

основні речовини: калію йодат - 0,253 мг (що еквівалентно 150 мкг йоду), натрію селеніт - 0,167 мг (що еквівалентно 75 мкг селену);
допоміжні речовини: наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; розпушувач: натрію кроскармелоза; протизлежувальні агенти: кремнію діоксид, тальк, стеарат магнію; (у складі: гідроксипропілметилцелюлоза, титану двоокис, полідекстроза, тальк, мальтодекстрин, три гліцериди середнього ланцюга)

Показання

Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело йоду та селену з метою нормалізації функції щитоподібної залози, профілактики станів, пов'язаних з дефіцитом йоду та селену, а також збагачення раціону населення, що проживає в регіонах з недостатньою кількістю йоду в навколишньому середовищі.

Спосіб застосування та дози

Вживати дітям старше 12 років і дорослим по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи питною водою.

Курс споживання визначає лікар індивідуально. Профілактичний курс споживання зазвичай складає 6-12 місяців, далі термін споживання узгоджувати з лікарем індивідуально. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

ХПВ

1. **Тірбізод містить біодоступний йод у формі калію йодиду та органічний селен - селенометіонін**, на відміну від Йосен, який містить калію йодат на селеніт. Тірбізод краще засвоюється організмом, що забезпечує ефективну та безпечну підтримку функції щитоподібної залози.
2. **В Тірбізоді антиоксидантна дія сильніша, за рахунок селенометоніну**. При прийомі Тірбізоду пацієнти отримують більш м'який, фізіологічний і довготривалий вплив, Калію йодат при довготривалому прийомі може бути більш подразливим для слизової ШКТ.
3. **Завдяки м'якій антиоксидантній та імуномодулюючій дії, Тірбізод краще підходить для профілактики тиреоїдиту Хашимото або інших хронічних захворювань щитоподібної залози.**



Містить органічний селен — селенометіонін, який всмоктується в ШКТ більше, ніж на 90%



Менше окисного стресу завдяки L-селенометіоніну



Містить біодоступний йод у формі калію йодиду



Натрію селеніт — неорганічна форма, всмоктується в ШКТ всього на 40%



Недостатньо терапевтична доза - 75мкг селеніту



Калію йодат — потребує додаткового метаболізму та при довготривалому прийомі більш подразливий для слизової ШКТ

Селен Про Макс



Склад

1 таблетка містить: *діючі речовини*: L-селенометіонін – 250,0 мкг (µg), що відповідає селену - 100 мкг (µg), калію йодид – 200 мкг (µg), що відповідає йоду – 150 мкг (µg).

Агент твердіння дикальцій фосфат безводний (DC), ізопропіловий спирт, метиленхлорид, текстуратор целюлоза мікрокристалічна (DC), оболонка: жовтий розчин для миттєвого покриття (стабілізатор гідроксипропілметилцелюлоза, білий пігмент титану діоксид, розчинник пропіленгліколь, антикомкувач тальк, пігмент заліза оксид жовтий), стабілізатори натрію кроскармелоза та кросповідон (XL 10), антизлежувачі: кремнію діоксид колоїдний, тальк та магнію стеарат; селен (у формі L-селенметіоніну), йод (у формі калію йодиду).

Показання:

Дієтична добавка Селен Про Макс сприяє виробленню гормонів щитоподібної залози, нормалізації обмінних процесів та

підвищенню імунітету. Селен Про Макс сприяє збагаченню раціону населення, що проживає в регіонах з недостатньою кількістю йоду в довкіллі.

Спосіб застосування та дози

Селен Про Макс, таблетки вживати дорослим з 18 років по 1 таблетці на добу, бажано під час прийому їжі. Курс прийому визначає лікар індивідуально.

Оптимальна тривалість прийому - 3 місяці (при необхідності курс можна повторити). Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем.

ХПВ

1. **Тірбізод має оптимальне дозування компонентів без надлишку**, на відміну від конкурента, пацієнт може бути впевнений в ефективності за рахунок точного дозування .
2. **Тірбізод має перевагу в допоміжному складі, бо не містить потенційно токсичних або сумнівних речовин, як спирт**. Це робить його безпечнішим і фізіологічнішим для тривалого прийому, особливо для вразливих категорій населення.
3. **Тірбізод вигідний на місяць та на курс по ціні**, на відміну від Селен про Макс. Пацієнти зможуть придбати на повний курс лікування за вигідною ціною.



- ✓ Має оптимальне дозування компонентів без надлишку
- ✓ Не містить потенційно токсичних або сумнівних речовин
- ✓ Вигідна ціна на місяць **200грн.** та курс **1200грн.**

- ✗ Потребує обережності при тривалому вживанні за рахунок підвищених доз
- ✗ Містить Ізопропіловий спирт -токсична доп.речовина. Наявність у препараті може свідчити про низьку якість або недосконалу технологію виробництва
- ✗ Ціна за місяць **300грн.** та **1800** на 6 міс

Цефоселен Йод



Склад

1 капсула містить:

- селена - 100 мкг;
- калію йодит - 0,256 мг (що відповідає 150 мкг йоду).

Допоміжні речовини: Орісіл, кальцію стеарат, целюлоза мікрокристалічна, лактоза - 169,744 мг.

Показання

- Пацієнтам з діагнозом аутоімунний тиреоїдит з порушенням функції щитоподібної залози;
- при дефіцит селену в їжі або організмі.

Спосіб застосування та дози

Приймати по одній капсулі до або під час їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Оптимальна тривалість курсу прийому - 3 місяці (при необхідності курс можна повторити).

ХПВ

1. **Тірбізод має легкозасвоюєму форму селену(селенометіонін)-всмоктується в ШКТ більше ніж на 90% та калію йодид.** В складі Цефоселен йод-неактивні дріжджі та калію йодат. Тірбізод має оптимальний збалансований склад для підтримки ЩЗ.
2. **У Тірбізода висока біодоступність** — швидке включення в обмін тиреоїдних гормонів, у Цефоселена можливі індивідуальні коливання у засвоєнні через дріжджову форму. Тірбізод забезпечує точний і стабільний результат.
3. **Ризик при довготривалому прийомі: накопичення селену з дріжджів в комбінації з йодом може бути менш передбачуваним**, особливо при харчових джерелах селену в раціоні → можливий селеноз (отруєння селеном). Калію йодат при довготривалому прийомі може бути більш подразливим для слизової ШКТ.



- ✓ Містить оптимальний склад йоду та селену, що свідчить про його ефективність
- ✓ Курс 6-12 міс., що свідчить про його безпечність при тривалому використанні
- ✓ Вигідна ціна на місяць **200грн.** та курс **1200грн.**

- ✗ Можливі індивідуальні коливання у засвоєнні через дріжджову форму та калію йодат
- ✗ Курс 1-2 міс. через дріжджі та калію йодат в складі
- ✗ Ціна за місяць **300грн.** та **600грн.** на 2 міс

8.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ТІРБІЗОД

Ендокринолог

- Гіпотиреоз
- АІТ(Аутиімунний тиреоїдит)
- ДНТЗ(Дифузний нетоксичний зоб)
- Нестача мікроелементів
- Вузловий зоб

Сімейні лікарі

- субклінічний гіпотиреоз
- Нестача мікроелементів

Скрипти по SPIN: Тірбізод

Гіпотиреоз:

S — Ситуація

«Лікарю, чи є у вас пацієнти з гіпотиреозом, які відчувають втому, слабкість, сухість шкіри, випадіння волосся та труднощі з контролем ваги?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів щитоподібна залоза працює повільніше через нестачу йоду та селена, що знижує синтез гормонів. Через це обмін речовин уповільнюється, симптоми не зникають повністю, навіть при замісній терапії.»

I — Наслідки

«Якщо не підтримувати щитоподібну залозу мікроелементами, пацієнти відчувають хронічну втому, зниження енергії, а контроль ваги залишиться складним. Це формує постійний дискомфорт і часті візити до лікаря.»

N — Рішення

«Тірбізод містить калію йодид і селенометіонін, які:
-підтримують нормальний синтез гормонів щитоподібної залози,
-зменшують окислювальний стрес і підтримують клітини залози.

Тому симптоми гіпотиреозу зменшуються швидше і стабільніше. Можете порекомендувати 3–5 пацієнтам, у яких, на ваш погляд, є потреба в підтримці щитоподібної залози?»

AIT

S — Ситуація

«Лікарю, яка у вас ситуація з пацієнтами з AIT та супутнім дефіцитом йоду та селену?»

P — Проблема

«Чи стикаєтесь Ви з тим, що у таких пацієнтів навіть на фоні замісної терапії зберігаються скарги на втому, апатію, випадіння волосся? Це пов'язано з тим, що аутоімунне запалення продовжується через дефіцит мікронутрієнтів»

I — Наслідок

«Якщо не коригувати дефіцит мікроелементів, це може впливати на перебіг AIT та є ризик прогресування гіпотиреозу.»

N —Рішення

«Наскільки для Вас було б зручно мати готовий засіб, який містить йод, у формі калію йодиду та органічний селен, що може використовуватись у пацієнтів з AIT для захисту від окислювального стресу та зменшення запалення? Чи можете порекомендувати 3–5 пацієнтам з AIT, яким потрібна додаткова підтримка щитоподібної залози?»

ДНЗ

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у вас пацієнти з дифузним нетоксичним зобом, які мають набряклість шиї, відчуття тяжкості в горлі, швидку стомлюваність або коливання ваги?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів щитоподібна залоза збільшена через нестачу йоду та селена, що порушує нормальний ріст і роботу клітин залози. Це може підтримувати запальні процеси та уповільнювати гормональний баланс.»

I — Наслідки

«Якщо не підтримувати щитоподібну залозу мікроелементами, зоб може зростати, з'являється дискомфорт у шиї, стомлюваність і порушення обміну речовин, а пацієнти відчувають хронічний дискомфорт і часті звернення до лікаря.»

N — Рішення

«До вашої уваги Тірбізод, що містить калію йодид і органічний селенометіонін, які забезпечують необхідний йод для нормального росту і роботи щитоподібної залози та підтримують клітини залози і знижують окислювальний стрес,

Тому пацієнти відчувають покращення енергії, зменшення тяжкості в шиї і стабільніший стан щитоподібної залози. Можете порекомендувати 3–5 пацієнтам з ДНТЗ, яким потрібна підтримка щитоподібної залози?»

Вузловий Зоб

S — Ситуація

«Лікарю, як часто зустрічаються на прийомі пацієнти із вузловим зобом, в яких періодичний дискомфорт у шиї, відчуття стороннього тіла при ковтанні, коливання енергії та нестабільний настрій?»

P — Проблема

«При вузловому зобі тканина щитоподібної залози росте нерівномірно, і часто це пов'язано з тривалим дефіцитом йоду та селена. Через нестачу цих мікроелементів клітини залози працюють гірше, з'являється окислювальний стрес і формується нерівномірна структура.»

I — Наслідки

«Без корекції дефіцитів вузли можуть збільшуватись, з'являється більш виражений дискомфорт у шиї, ризик функціональних зрушень, а пацієнти відчують втому і погіршення якості життя. »

N — Рішення

«Хочу вам розказати про Тірбізод, якій містить калію йодид та органічний селенометіонін, які забезпечують щитоподібну залозу необхідними мікроелементами, зменшують окислювальний стрес у тканинах та допомагають стабілізувати загальний стан і зменшити дискомфорт у зоні вузлів.»

Можете домовитись про призначення 3–5 пацієнтам із вузловим зобом, яким потрібна додаткова підтримка?»

ШУГАРД



Дієтична добавка

Шугард™ • Suguard

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 таблетці:

Інгредієнти:	1 таблетка
екстракт листя джимнеми (Gymnema sylvestre)	300 мг
екстракт плодів гіркої дині (Momordica charantia)	300 мг
екстракт листя банаби (Lagerstroemia speciosa)	200 мг

екстракт кореня куркуми (<i>Curcuma longa</i>), (що містить 95 % куркуміну)	25 мг
хром (у формі піколінату хрому)	50 мкг (що відповідає 125 %*)
вітамін D3 (холекальциферол)	15 мкг (600 МО (IU), що відповідає 300 %*)

** - відсоток від добової потреби у вітамінах та мінеральних речовинах для дорослих (осіб старше 18 років).*

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин, вітаміну D3 та хрому.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 таблетці 1 раз на добу до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 1 місяць. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не рекомендується використовувати без попередньої консультації з лікарем людям з цукровим діабетом, адже компоненти можуть посилювати дію цукрознижувальних лікарських засобів. У разі

одночасного прийому зі цукрознижувальними лікарськими засобами потрібен контроль рівня глюкози (цукру) в крові.

Протипоказання: людям, які приймають антикоагулянти, протипухлинні препарати та імунодепресанти, у випадках обструкції жовчовивідних шляхів або інших порушень функції жовчовивідних шляхів; вагітність та період лактації, дитячий вік до 18 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: таблетки масою 930 мг $\pm$ 7,5 % №30 у банці полімерній, упакованій у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

9.Картка продукту

Ключове повідомлення

Шугард – 6 стражів-гармонія в поєднанні, захищають на 6 етапах порушень вуглеводного обміну.

Позиціонування

Шугард — 6 стражів гармонії в поєднанні

Який:

- нормалізує рівень цукру в крові,
- покращує чутливість до інсуліну та підтримує – функцію підшлункової залози,
- знижує ризик ускладнень діабету.

Тому що містить

Джимнему – потужний інгібітор всмоктування глюкози.

Гірку диню – покращує роботу інсулінових рецепторів.

Банабу – підвищує чутливість клітин до інсуліну та сприяє зниженню ваги.

Куркумін – антиоксидант із протизапальною дією, знижує ризик діабетичних ускладнень.

Хром – регулятор метаболізму вуглеводів, знижує тягу до солодкого.

Вітамін D3 – підтримує імунітет та зменшує інсулінорезистентність.

Механізм дії

Гімнема (<i>Gymnema</i> <i>sylvestre</i>)	Основна дія: зниження рівня глюкози в крові, зменшення апетиту до солодкого.	Механізм: - Гімнемові кислоти блокують рецептори солодкого смаку на язичці — зменшується потяг до солодощів. - Підвищення чутливості клітин до інсуліну — покращується утилізація глюкози. - Стимуляція β-клітин підшлункової залози — покращення вироблення інсуліну. - Гальмування поглинання глюкози в кишечнику — зменшується глікемічне навантаження після їжі.
Гірка диня (<i>Momordica</i> <i>charantia</i>)	Основна дія: зниження глікемії, м'який інсуліноподібний ефект.	Механізм: - Чарантин і поліпептид-Р діють подібно до інсуліну, сприяючи транспорту глюкози в клітини. - Покращення глюкозного метаболізму в печінці, м'язах та жировій тканині. - Інгібування α-глюкозидази — уповільнення розщеплення вуглеводів у кишечнику.

Банаба (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)	Основна дія: зниження рівня цукру в крові, покращення чутливості до інсуліну.	Механізм: • Коросолева кислота активує транспортери глюкози (GLUT4) — збільшується поглинання глюкози клітинами. • Зниження постпрандіальної гіперглікемії — пригнічення вуглеводного обміну на рівні травної системи. • Має антиоксидантні та протизапальні властивості.
Куркумін (<i>Curcuma longa</i>)	Основна дія: протизапальна та антиоксидантна, підтримка β-клітин, зниження інсулінорезистентності.	Механізм: • Інгібування NF-κB і TNF-α — зниження запалення, яке спричиняє інсулінорезистентність. • Захист β-клітин підшлункової залози від оксидативного стресу. • Покращення експресії генів, відповідальних за глюкозний метаболізм. • Стимуляція AMPK — підвищення чутливості до інсуліну.

Хром (у вигляді піколінату хрому)	Основна дія: покращення дії інсуліну та стабілізація рівня глюкози.	Механізм: • Формує хромодулін — кофактор інсулінового рецептора, посилює інсуліновий сигнал. • Покращує транспорт глюкози всередину клітини. • Допомогає зменшити інсулінорезистентність. • Стабілізує апетит (зокрема тягу до солодкого).
Вітамін D (у формі D3, холекальциферол)	Основна дія: підтримка β-клітин, регуляція імунітету та глюкозного обміну.	Механізм: • Вітамін D-рецептори (VDR) є на β-клітинах — забезпечує їх виживання і нормальну функцію. • Покращує чутливість до інсуліну через дію на м'язову і жирову тканину. • Модуляція імунної відповіді — зменшує запалення, пов'язане з метаболічним синдромом.

9. Конкуренти

Ключові конкуренти

Глібофїт



Склад

1 капсула містить: Екстракт листя Джимнеми звичайної (*Gymnema sylvestre*) – 100 mg (мг); Екстракт плодів Момордики (*Momordica charantia*) – 100 mg (мг); Екстракт листя Азадірахти індійської (*Azadirachta indica*) – 80 mg (мг); Камедь Коміфори (*Commiphora mukul*) – 50 mg (мг); Екстракт насіння Сизигіум ямболан (*Syzygium cumini*) – 50 mg (мг); Мумію гімалайське (*Asphaltum*) – 40 mg (мг); Кореневище Імбиру (*Zingiber officinale*) – 40 mg (мг); Насіння Гуньби сінної (*Trigonella foenum-graecum*) – 35 mg (мг); Екстракт кореневища Пікрорхізи курроа (*Picrorhiza kurroa*) – 30 mg (мг); Екстракт листя Базиліку (*Ocimum sanctum*) – 15 mg (мг).

допоміжні речовини: консервант натрію бензоат.

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендовано як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, що сприяє нормалізації рівня глюкози в крові, покращує показники вуглеводного та ліпідного

обмінів, підтримує функціональну активність β -клітин підшлункової залози.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу перед прийомом їжі, запити водою. Термін вживання: 90 днів. В подальшому термін вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

ХПВ

1. **Шугард має точне, стандартизоване дозування нутрієнтів та рослинних екстрактів**, на відміну від Глібофіта, де лише частина екстрактів стандартизована і їхня концентрація може коливатись, тому пацієнт отримує стабільний, передбачуваний метаболічний ефект у кожній таблетці.
2. **Шугард на відміну від Глібофіту має більш зручну Форму Випуску**: всього 1 таблетка на добу, тоді як Глібофіт приймається по 1т. 2р/д. Шугард більш зручний для пацієнта в плані комплаєнсу.
3. **Шугард має нутрієнти з доведеною ефективністю — хром, вітамін D3, куркумін**, на відміну від Глібофіта, у складі якого ці біологічно значущі нутрієнти відсутні, тому пацієнт отримує ширший та науково обґрунтований вплив на метаболічний контроль: кращу чутливість до інсуліну, регуляцію глікемії та зниження запального фону.



VS



- ✓ Зручна Форму Випуску: всього 1 таблетка на добу
- ✓ Склад із високими дозами активних речовин
- ✓ Комплексна формула розроблена українськими науковцями

- ✗ Приймати по 1 табл. 2 р/д.
- ✗ Низькі дози активних речовин —→ мало ймовірно досягти стабільного гіпоглікемічного ефекту
- ✗ Високий ризик взаємодій та конкуренції між компонентами 10 рослин з різними діючими речовинами можуть взаємно знижувати ефективність або ускладнювати оцінку дії —→

Глюцемедін



Склад

1 капсула містить: **активні інгредієнти**: екстракт листя джімнеми (*Gymnema Sylvestre*) - 150 мг (mg), екстракт листя банаба (*Lagerstroemia speciosa*) - 125 мг (mg), екстракт гіркої діні (*Momordica charantia*) - 100 мг (mg);

допоміжні речовини: кальцію стеарат, кремнію діоксид аморфний, мікрокристалічна целюлоза.

Показання

Глюцемедін рекомендовано як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, з метою нормалізації функціонального стану ендокринної системи.

ГЛЮЦЕМЕДІН® позитивно впливає на вуглеводний та ліпідний обмін, сприяє зниженню рівнів глюкози, холестерину та тригліцеридів в крові.

ГЛЮЦЕМЕДІН® сприяє покращенню функціонального стану підшлункової залози та загального самопочуття.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу до прийому їди, запиваючи достатньою кількістю води.

Термін вживання 2 - 3 місяці.

ХПВ

1. **Шугард** на відміну від Глюцемедіна **має більш зручну Форму** Випуску: всього 1 таблетка на добу, тоді як Глюцемедін приймається по 1к. 3р/д. Шугард зручний в плані комплаєнсу для пацієнта і він точно не забуде прийняти необхідну кількість таблеток.
2. **Шугард** має компоненти, які підтримують імунітет, мають **антиоксидантні властивості + ще один компонент(хром), який знижує тягу до солодкого**. Пацієнти отримають більше ефекту від більш комплексного препарату Шугард.
3. **Шугард дешевше по ціні і на місяць і на курс**, пацієнти зможуть собі дозволити препарат Шугард і отримати повний курс лікування.



✓ Зручна Форму Випуску: всього 1 таблетка на добу

✓ Має компоненти, які підтримують імунітет, мають антиоксидантні властивості та протизапальную дію(куркумін,хром, віт D)

✓ Вигідна ціна на місяць та на курс: місяць-**700грн**, курс-**2118грн**.

✗ Приймати по 1 кап. 3 р/д.

✗ Відсутні мікроелементи
Немає антиоксидантної дії і протизапальної та імунної підтримки

✗ №60:Ціна за місяць-**963грн**, за курс-**2889грн**.

Атримін Нео



Склад:

1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт джимнеми сілвестра – 150 mg (мг), екстракт кореня цикорія – 150 mg (мг), екстракт чорниці – 100 mg (мг), цинку бісгліцинат – 27 mg (мг), хрому піколінат – 100 µg (мкг)

допоміжні речовини: наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза,

кальцію стеарат, крохмаль картопляний, діоксид кремнію аморфний .

Рекомендації до застосування

Може бути рекомендована в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для нормалізації функціонування вуглеводного і жирового обміну і фізіологічного рівня глюкози в крові. Сприяє покращенню роботи підшлункової залози. Також сприяє зниженню тяги до солодких продуктів завдяки вмісту пиколинат хрому.

Спосіб застосування та дози

Приймати по 1 капсулі 2 рази на день до або під час їжі.

Термін застосування: 2-3 місяці.

ХПВ

1. **Шугард на відміну від Глібофіту має більш зручну Форму.**
Випуску: всього 1 таблетка на добу, тоді як Глібофіт приймається по 1к. 2р/д. Шугард більш зручний для пацієнта в плані комплаєнсу.
2. **У Шугарді відсутній інулін , тож чутливі пацієнти не отримають в результаті лікування здуття або газоутворення.** За рахунок віт. Д3 та куркуміну пацієнти отримають протизапальний ефект , зниження інсулінорезистентності та підвищення імунітету.
3. **Шугард містить гірку диню — рослина з інсуліноподібною дією, яка знижує рівень цукру активніше, ніж цикорій чи чорниця.**Приймавши Шугард пацієнти отримають більш ефективний результат зниження глюкози за рахунок комплексного складу.



VS



- ✓ Зручна Форму Випуску: всього 1 таблетка на добу
- ✓ Комплексний збалансований склад
- ✓ Вигідна ціна на місяць та на курс: місяць-**700грн**, курс-**2118грн**.
- ✓ Кращий ефект на потяг до солодкого(за рахунок джимнеми та хрому)

- ✗ Приймати по 1 кап. 2 р/д.
- ✗ Містить інулін, який викликає здуття у чутливих пацієнтів. Чорниця в малій дозі — ефект слабший, антиоксидантна дія символічна
- ✗ Ціна за місяць-**980грн**, за курс-**2940грн**.
- ✗ Не містить банаби та гіркої дині, що покращують чутливість до інсуліну та роботу інсулінових рецепторів

Сахніл



Склад

Склад на 1 таблетку: порошок яшад бхасми (Yashad Bhasma) – 37,50 мг (mg), шудхи шаладжит (мумійо) (Shilajit Shuddha) – 37,50 мг (mg), плоди момордики харанції (Momordica charantia) – 12,00 мг (mg), екстрактів: насіння касії (Cassia auriculata) – 45,00 мг (mg), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) – 37,45 мг (mg), кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) – 30,00 мг (mg), насіння джамболани (Eugenia jambolana) – 15,00 мг (mg), усієї рослини енікостемма літораль (Enicostemma littorale) – 11,00 мг (mg), листя джімнема сільвестра (Gymnema sylvestre) – 11,00 мг (mg), листя мелії азедарах (Melia azadirachta) – 11,00 мг (mg), серцевина птерокарпус сумчастий (Pterocarpus marsupium) – 8,00 мг (mg), стебел тіноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 8,00 мг (mg), усієї рослини сверції чирати (Swertia chirata) – 1,25 мг (mg). *Допоміжні речовини:* сорбат калію (E 202), сорбінова кислота (E 200), натрію бензоат (E 211), кальцію гідрофосфат, крохмаль кукурудзяний, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний, натрію крохмальгліколят, натрію кроскармелоза, кросповідон.

Показання

Рекомендації до споживання: дієтична добавка до раціону харчування – джерело біологічно активних речовин рослинного походження, сприяє покращенню вуглеводного обміну.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 2 таблетки двічі на добу (вранці та ввечері), за 30 хвилин до їди або за призначенням лікаря. Тривалість вживання 3–6 місяців або за призначенням лікаря.

ХПВ

1. **В Шугард наявність нутрієнтів із доказовою ефективністю**(Хром, віт.Д3, куркумін), на відміну від Сахніла. Сахніл містить суміші аюрведичних порошків та екстрактів, що мають ширший, але менш стандартизований профіль, пацієнти отримують ефективний курс лікування.
2. **Шугард на відміну від Сахнілу має більш зручну Форму Випуску: всього 1 таблетка на добу**, тоді як Сахніл приймається по 2т. 2р/д.
3. Шугард має комплексний склад підібраний українськими науковцями, на відміну від Сахніл, пацієнт отримає більш безпечний курс лікування без побічних дій.



✓ Наявність нутрієнтів із доказовою ефективністю(Хром, віт.Д3, куркумін)

✓ Зручна Форму Випуску: всього 1 таблетка на добу

✓ Синергічно підібраний склад з оптимальним дозуванням

✗ Містить суміш аюрведичних порошків та екстрактів, що мають нестандартизований профіль

✗ Незручно приймати: по 2 табл. 2 р/д.

✗ 14+ рослин і мінералів, більшість з яких у мінімальних дозах (1–15 мг)

9.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ШУГАРД

Ендокринолог

- Цукровий діабет 2 типу
- Предіабет
- ІР(Інсулінорезистентність)
- МС(Метаболічний синдром)
- Ожиріння
- НАЖХП(Неалкогольна жирова хвороба печінки)

Гастроентеролог/дієтолог

- МС(Метаболічний синдром)
- Ожиріння
- ІР(Інсулінорезистентність)

Сімейний лікар

- Предіабет
- ІР(Інсулінорезистентність)
- МС(Метаболічний синдром)

Гінеколог

- СПКЯ

Скрипти по SPIN: Шугард

Інсулінорезистентність

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у ваших пацієнтів з інсулінорезистентністю, попри дієту залишаються коливання глюкози, тяга до солодкого та набір ваги?»

P — Проблема

«У значної частини цих пацієнтів зберігається знижена чутливість тканин до інсуліну, оксидативний стрес та перевантаження підшлункової залози. Це уповільнює компенсацію глікемії та не дає досягти стабільного контролю.»

I — Наслідки

«Якщо інсулінорезистентність не коригувати комплексно, то навіть на тлі терапії глікемія залишається нестабільною, зростає вага. Пацієнти частіше потребують корекції терапії та додаткових візитів.»

N — Рішення

«Шугард — комбінований метаболічний комплекс, який працює на ключові механізми інсулінорезистентності.

Він:

- покращує чутливість тканин до інсуліну;
 - знижує тягу до солодкого;
 - підтримує β -клітини та зменшує оксидативний стрес;
 - стабілізує рівень вітаміну D — важливий для метаболізму
- Тому пацієнти з ІР досягають кращого контролю глікемії швидше й стабільніше, а потреба у корекції терапії зменшується. Зможете порекомендувати 3-5 пацієнтам?

ЦД 2 типу

S — Ситуація

«Лікарю, чи помічаєте ви у ваших пацієнтів із ЦД 2 типу, які вже приймають метформін у терапевтичних дозах, що глюкоза все одно знижується повільно, HbA1c стоїть на місці, а постпрандіальні піки залишаються високими?»

P — Проблема

«У частини таких пацієнтів метформіну недостатньо для стабілізації добового профілю глюкози. Зберігаються коливання цукру після їжі, надмірна тяга до солодкого, побічні реакції на фоні прийому метформін.»

I — Наслідки

«Без додаткової підтримки глюкозорегулюючих механізмів пацієнти довше не виходять на цільові показники. »

N — Рішення

«Шугард- комплекс на основі джимнеми, банаби, гіркої дині, хрому, куркуміну та вітаміну D- працює за тими механізмами, які не покриває метформін:

- підсилює ефект базової терапії;
- стабілізує добові коливання;
- знижує тягу до солодкого;

У результаті пацієнти, які вже приймають метформін, швидше виходять на стабільні цукри, легше досягають цільового HbA1c і рідше потребують посилення медикаментозної терапії. Давайте домовимось про призначення 3-5 пацієнтам з ЦД 2 типу?

Предіабет

S — Ситуація

«Лікарю, як часто у вас бувають пацієнти із предіабетом, у яких, попри рекомендації щодо харчування й фізичної активності, глюкоза натще залишається підвищеною, а показники після їжі повільно нормалізуються?»

P — Проблема

«У таких пацієнтів часто порушена здатність організму швидко реагувати на вуглеводне навантаження.»

I — Наслідки

«Якщо на цьому етапі не втрутитися ефективніше, пацієнт роками живе з підвищеним цукром, що поступово виснажує β -клітини, підвищує ризик надмірної ваги та призводить до ЦД 2 типу. »

N — Рішення

«Шугард допомагає пацієнтам із предіабетом вирівнювати показники глюкози за рахунок роботи відразу на кількох ранніх ланках порушеного метаболізму. Його компоненти:

- знижують тягу до солодкого;
- підвищують чутливість клітин до інсуліну;
- покращують роботу інсулінових рецепторів
- зменшують внутрішнє запалення, що прискорює метаболічну стабілізацію.

Завдяки цьому пацієнти з предіабетом частіше повертаються до нормальних показників і довше залишаються в безпечній зоні без переходу до ЦД 2 типу. Можете порекомендувати 3-5 пацієнтам з предіабетом?

МС та ожиріння

S — Ситуація

«Лікарю, буває у ваших пацієнтів з метаболічним синдромом та ожирінням підвищений апетит, тягу до солодкого, стомлюваність та труднощі зі схудненням навіть при дієті?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів є інсулінорезистентність та порушений метаболізм глюкози. Через це клітини не отримують достатньо енергії, печінка і підшлункова перевантажені, а зайва вага та складки жиру залишаються навіть при обмеженні калорій.»

I — Наслідки

«Якщо не нормалізувати метаболізм і чутливість до інсуліну, пацієнти не можуть стабільно знизити вагу, підвищується ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних проблем і постійно повторюються епізоди переїдання та втоми.»

N — Рішення

«Шугард підтримує нормалізацію метаболізму глюкози та інсулінчутливість:

- допомагає клітинам ефективніше використовувати глюкозу,
- знижує тягу до солодкого та перекусів,
- сприяє стабільнішому контролю ваги та енергетичного балансу,
- підтримує роботу печінки та підшлункової.

Тому пацієнти швидше починають відчувати легкість, стабільніший апетит і краще контролюють вагу. Можете порадити 3–5 пацієнтам з МС або ожирінням, у яких є ці проблеми?»

НАЖХП

S — Ситуація

«Лікарю, чи є у вас пацієнти, у яких ви бачите підвищений жир у печінці, втому, тяжкість у правому підребер'ї та порушений апетит?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнтів печінка накопичує зайвий жир, через що клітини працюють гірше, зростає запалення, порушується обмін жирів і глюкози. Це уповільнює обмін речовин і погіршує самопочуття.»

I — Наслідки

«Без підтримки метаболізму печінки стан пацієнта може прогресувати: накопичення жиру зростає, з'являється запалення, ризик розвитку фіброзу і цукрового діабету підвищується.»

N — Рішення

«Шугард допомагає підтримати нормальний метаболізм печінки та зменшити наслідки накопичення жиру:

- покращує показники АЛТ, АСТ,
- знижує запалення,
- підтримує роботу печінки і клітинний метаболізм,

Тому пацієнти відчують легкість, зменшуються симптоми. Чи порекомендуєте 3–5 пацієнтам з НАЖХП, у яких, на ваш погляд, є потреба в підтримці печінки?»

СПКЯ

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у ваших пацієнток з СПКЯ ви бачите нерегулярний цикл, підвищений ріст волосся, акне та труднощі зі схудненням?»

P — Проблема

«У більшості таких пацієнток є інсулінорезистентність і порушений обмін глюкози. Це підвищує рівень андрогенів, погіршує стан шкіри, волосся та стабільність менструального циклу, а також ускладнює зниження ваги.»

I — Наслідки

«Якщо не підтримувати чутливість до інсуліну та метаболізм глюкози, симптоми залишаються постійно, зростає ризик діабету 2 типу, серцево-судинних проблем та фертильні труднощі. Пацієнтки часто відчують втому від безрезультатних дієт.»

N — Рішення

«Шугард підтримує нормальний метаболізм глюкози та інсулінчутливість:

- знижує надлишковий рівень андрогенів,
- нормалізує гормональний баланс, підтримує репродуктивну функцію

- зменшує ІР

- сприяє контролю ваги та енергетичного балансу.

Тому симптоми СПКЯ зменшуються швидше і стабільніше. Чи можете порадити 3–5 пацієнткам, у яких є ці проблеми?»

СЕЛЕФІКС



**Дієтична добавка
Листок-вкладиш**

(Інформація для споживачів)

СЕЛЕФІКС

Вміст в 1 капсулі: дріжджі, збагачені селеном (*Saccharomyces cerevisiae*) - 50 мг (mg), що відповідає 100 мкг (mcg) селену. (181,8 % РВС*)

*РВС згідно з Законом України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”

Склад: наповнювач: целюлоза мікрокристалічна; дріжджі, збагачені селеном (*Saccharomyces cerevisiae*); антизлежувальні агенти: стеарат кальцію, кремнію діоксид колоїдний безводний; капсула: желатин, барвник: оксид цинку.

Рекомендації щодо споживання: в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело селену. Селен сприяє підтриманню нормального стану волосся, нігтів та захисту клітин від оксидативного стресу. Селен також сприяє нормальному спермогенезу, нормальній роботі імунної системи, нормальному функціонуванню щитоподібної залози.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу після споживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання узгоджується з лікарем.

Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти, вагітні та жінки в період лактації.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску: тверді желатинові капсули з масою нетто (вмісту) 350 мг (mg) $\pm$ 9 %, по 10 капсул у блістері, 3 блістери у картонній коробці з листком-вкладкою.

Умови зберігання: в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75 %.

10.Картка продукту

Ключове повідомлення

Селефікс — органічний селен із неактивних дріжджів: тривала підтримка щитоподібної залози та антиоксидантний захист

Позиціонування

Селефікс - фіксоване дозування, фіксований курс і фіксована концентрація натуральних дріжджів.

Який:

- підвищує рівень селену без ризику передозування,
- сприяє зниженню проявів оксидативного стресу,
- підтримує енергетичний баланс організму.

Тому що містить:

селен із неактивних дріжджів — натуральну органічну форму селену, яка поступово вивільняється і підтримує стабільний рівень селену в організмі.

Як саме працює Селефікс?

У Селефікс селен міститься у складі неактивних дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*. Під час росту дріжджі природно вбудовують селен у свою структуру, перетворюючи його на органічну форму, близьку до тієї, що ми отримуємо з їжі.

- **Добре засвоюється**
Організм сприймає такий селен як частину білка, тому він легко всмоктується і не викликає різких коливань рівня селену в крові.
- **Працює поступово**
Селен з дріжджів вивільняється повільно, формуючи стабільний запас в організмі та забезпечуючи тривалу підтримку.
- **Захищає клітини**
Селен бере участь у роботі антиоксидантних ферментів, які допомагають клітинам протистояти стресу та окисному навантаженню.
- **Підтримує ключові системи**
Сприяє нормальній роботі імунної системи, нервової системи та гормонального балансу.

10.Конкуренти

Ключові конкуренти

Селенорм



Склад:

L-селенометіоніну – 250 мкг (відповідає 100 мкг селену);

допоміжні речовини: наповнювач: целюлоза мікрокристалічна;

розпушувач: натрію кроскармелоза; протизлежувальні агенти:

кремнію діоксид, тальк, магнію стеарат.

Призначення:

Додаткове джерело органічного селену для усунення дефіциту селену.

Спосіб споживання:

Вживати дорослим по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи водою.

Рекомендована тривалість споживання визначається, виходячи з індивідуальних потреб.

ХПВ

1. **Селефікс** має **фіксовану формулу з дріжджовою матрицею**, яка діє не лише як джерело селену, але й сприяє кращому антиоксидантному ефекту клітин, тоді як Селенорм містить лише органічну форму селену без додаткової підтримки.
2. Селефікс містить **неактивні дріжджі**, які окрім селену забезпечують **вітаміни групи В, амінокислоти та мікроелементи**, що природно входять до складу дріжджів, на відміну від Селенорм, пацієнт отримає додаткове живлення та антиоксидантна підтримка щитоподібної залози, підвищення загального самопочуття.
3. **Селефікс у капсулі швидше розчиняється у шлунково-кишковому тракті**, на відміну від таблетки, **отже пацієнти отримають більш прогнозоване та рівномірне засвоєння селену**.



Склад (одна капсула): неактивні дріжжі - 50 мг (що відповідає 100 мкг селену); допоміжні речовини: орісіл, кальцію стеарат, мікрокристалічна целюлоза, лактоза – 170 мг.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано лікарем в якості добавки, як додаткове джерело біологічної активної речовини селену, для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, в тому числі для участі в синтезі гормонів щитоподібної залози. Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Рекомендований термін споживання: 2 місяці, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем індивідуально.

ХПВ

1. **Селефікс має селен у складі стандартизованих неактивних дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*, на відміну від Цефоселену з нестандартизованою дріжджовою масою, отже пацієнти отримують прогнозовану дозу селену в кожному прийомі.**
2. **Селефікс представлений у форматі «1 упаковка = 1 місяць», на відміну від Цефоселену, отже пацієнти отримують просту схему прийому та кращу прихильність до терапії.**
3. **Селефікс не містить лактози у складі, на відміну від Цефоселену, отже пацієнти з лактозною непереносимістю або чутливістю отримують безпечний і комфортний прийом.**



Селен Про

Склад:

діюча речовина: L-селенметіонін - 250 мкг (μg), що відповідає 100 мкг (μg) селену. доп. реч-ни: агент твердіння дикальцій фосфат безводний (DC), ізопропіловий спирт, метиленхлорид, текстуратор: целюлоза мікрокристалічна (DC), оболонка: коричневий розчин для миттєвого покриття (стабілізатор: гідроксипропілметилцелюлоза, білий пігмент титану діоксид, розчинник: пропілен гліколь, антикомкувач: тальк, пігменти: заліза оксид червоний та жовтий), стабілізатори: натрію кроскармелоза, кросповідон (XL 10), антизлежувачі: кремнію діоксид колоїдний, тальк, магнію стеарат.

Рекомендації щодо застосування

Дієтична добавка Селен Про, таблетки рекомендується як додаткове джерело селену з метою усунення його дефіциту в організмі. Селен Про сприяє стимуляції вироблення гормонів щитоподібної залози, сприяє підтриманню нормального стану волосся та нігтів, нормалізації обмінних процесів та підвищенню імунітету. Селен Про, таблетки сприяє нормальному спермогенезу у чоловіків.

Спосіб застосування

Вживати дорослим з 18 років по 1 таблетці на добу, бажано під час вживання їжі. Курс прийому визначає лікар індивідуально.

Оптимальна тривалість курсу прийому - 3 місяці (при необхідності курс можна повторити).

ХПВ

1. **Селефікс має селен у складі неактивних дріжджів *Saccharomyces cerevisiae* з мінімальною кількістю допоміжних речовин**, на відміну від СеленПро з багатокомпонентним допоміжним складом (агенти твердіння, стабілізатори, антизлежувачі, пігменти), **отже пацієнти отримують менше навантаження на ШКТ.**
2. **Селефікс містить селен у матриці неактивних дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*, які природно включають амінокислоти, пептиди та вітаміни групи В**, на відміну від СеленПро з ізольованим L-селенометіоніном, **отже пацієнти отримують не лише мікроелемент, а й додаткову нутрієнтну підтримку.**
3. **Селефікс — продукт українського виробництва з перевіреною якістю сировини та контролем місячної упаковки**, на відміну від СеленПро з імпорту(Індія), **отже пацієнти отримують надійний та зручний курс без ризику сумнівної ефективності.**



Тироксель

Склад

1 таблетка (250 мг (мг)) містить: активну речовину: селенометіонін 10 мг (мг) (відповідає 100 мкг (мкг) селену). допоміжні речовини: повідон К-25, манітол, цукрова глазур, допоміжна речовина: магнію стеарат.

Показання до застосування

Застосовується як біологічно активна добавка для дорослих як додаткове джерело селену, який відіграє важливу роль, сприяючи нормалізації функції щитовидної залози та обміну речовин в організмі.

Рекомендації щодо застосування

Приймати дорослим по 1 таблетці на день, незалежно від їди. Рекомендований період прийому – 1 місяць.

ХПВ

- 1. Селефікс має форму капсули, на відміну від Тирокселю у таблетках, отже пацієнти отримають краще вивільнення активної речовини.**
- 2. Селефікс має упаковку, розраховану на місячний курс, на відміну від Тирокселю, де пацієнтам потрібно докупати таблетки на весь місяць, отже пацієнти отримають зручний, готовий курс без ризику пропусків або неправильного дозування.**
- 3. Ціна Селефікс 350 грн на місяць, на відміну від Тирокселю – 600 грн, пацієнти отримують економію майже на половину.**



Склад

1 таблетка Цефасель 100 мкг містить 0,219 мг натрію селеніту (відповідає 100 мкг селену)

Показання

Встановлений дефіцит селену, який не може бути компенсований за допомогою їжі.

Спосіб застосування та дози

Якщо не призначено інакше, доза становить 100 мкг селену на добу.

ХПВ

1. **Селефікс містить селен у вигляді неактивних дріжджів *Saccharomyces cerevisiae* (органічна форма), на відміну від Цефаселю з неорганічним натрію селенітом, отже пацієнти отримають більш фізіологічне засвоєння селену та кращу біодоступність.**
2. **Селефікс пропонується у капсулах на повний місячний курс, на відміну від Цефаселю, де упаковка з 20 таблеток не покриває весь місяць, отже пацієнти отримають зручний та контрольований прийом без потреби докуповувати додаткові таблетки.**
3. **Селефікс коштує 350 грн на місяць, на відміну від Цефаселю – 1200 грн за місяць, отже пацієнти отримають економію понад 2/3 при повному місячному курсі.**

10.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: СЕЛЕФІКС

Ендокринолог:

1. Гіпертиреоз
2. АІТ
3. ДТЗ
4. Дефіцит селену

Сімейні лікарі:

1. Дефіцит селену

Скрипти по SPIN: СЕЛЕФІКС

AIT

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у Вашій практиці зустрічаються пацієнти з аутоімунним тиреоїдитом, у яких за результатами обстежень виявляється дефіцит селену або є підвищені антитіла до ТПО?»

P — Проблема

«Чи помічали Ви, що навіть при коректно підібраній замісній терапії у таких пацієнтів можуть зберігатися скарги на втому, зниження працездатності, випадіння волосся, лабільність настрою?

Часто це пов'язано з тим, що на фоні дефіциту селену посилюється окислювальний стрес і підтримується аутоімунне запалення в тканині щитоподібної залози.»

I — Наслідок

«Якщо не коригувати дефіцит селену, аутоімунний процес може залишатися активним, що сприяє збереженню високих титрів антитіл і підвищує ризик прогресування функціональних порушень щитоподібної залози.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б зручно мати монокомпонентний засіб з органічним селеном — **Селефікс**, який має **високу біодоступність**: організм ефективно засвоює і включає у селенозалежні ферменти; **має** відсутні різкі пікові концентрації селену, **має антиоксидантну підтримку**. Чи могли б Ви порекомендувати 3–5 пацієнтам з AIT та підтвердженим або ймовірним дефіцитом селену додаткову нутрієнтну підтримку?»

Гіпертиреоз

S — Ситуація

«Лікарю, як часто зараз зустрічаються пацієнти з гіпертиреозом або тиреотоксикозом, у яких на фоні основної терапії зберігається виражений метаболічний стрес?»

P — Проблема

«Погодьтеся, що навіть при лікуванні тиреостатичними препаратами пацієнти можуть скаржитися на серцебиття, тривожність, підвищену втомлюваність, втрату маси тіла?

Це часто пов'язано з надлишковим утворенням активних форм кисню та підвищеною потребою в антиоксидантному захисті, зокрема в селені.»

I — Наслідок

«За відсутності корекції дефіциту селену може зберігатися виражений окислювальний стрес, що потенційно ускладнює перебіг гіпертиреозу та впливає на загальний стан пацієнта.»

N — Рішення

«Чи було б вам корисно прослухати про монокомпонентний засіб з органічним селеном — **Селефікс**, який забезпечує **стабільне і рівномірне засвоєння** без пікових коливань; підтримує роботу **селенозалежних антиоксидантних ферментів** і можна використовувати як додаткову нутрієнтну підтримку у пацієнтів з гіпертиреозом для посилення антиоксидантного захисту?

Чи могли б Ви порекомендувати 3–5 пацієнтам з гіпертиреозом або тиреотоксикозом, у яких зберігається підвищене навантаження на організм, додаткову підтримку селеном?»

ДТЗ

S — Ситуація

«Лікарю, чи ви помічаєте, що ваші пацієнти з дифузним токсичним зобом навіть на фоні тиреостатичної терапії мають виражені прояви системного стресу та активного аутоімунного процесу?»

P — Проблема

«Згодні, що у пацієнтів з ДТЗ можуть зберігатися серцебиття, тривожність, м'язова слабкість, зниження маси тіла, навіть коли показники гормонів уже наближаються до цільових?

Однією з причин є надмірне утворення вільних радикалів і висока потреба щитоподібної залози в селені як ключовому компоненті антиоксидантних ферментів.»

I — Наслідок

«Якщо дефіцит селену не коригувати, окислювальний стрес може підтримувати аутоімунне запалення, впливати на загальний стан пацієнта та ускладнювати досягнення стабільної ремісії.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б зручно мати засіб із органічним селеном у складі неактивних дріжджів — Селефікс, який м'яко знижує **окислювальний стрес** і підтримує щитоподібну залозу; безпечно поєднується з основною терапією ДТЗ; зручний для **курсowego призначення** пацієнтам, яким потрібна додаткова нутрієнтна підтримка? Впевнена(ий) у вас буде 3-5 пацієнта, яким ви зможете признати Селефікс, так?»

КАЛЬБІНД



Кальбінд

Склад	активний інгредієнт: кальцію ацетат - 667 мг (в перерахунку на кальцій 169 мг).
Спосіб застосування	дорослим по 1 таблетці 3 рази на добу, якщо інше не призначено лікарем
Форми випуску	таблетки №100
Рекомендації до застосування	Вживати в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело кальцію у формі ацетату кальцію.

11. Карта продукту

Ключове повідомлення

Кальбінд — щоденний контроль фосфатів - зменшення ризиків.

Позиціонування

Кальбінд – це сучасний фосфат-біндер на основі кальцію ацетату у зручній жовтій кишково-розчинній таблетці.

Який

Ефективніший за карбонат кальцію у зв'язуванні фосфатів.

Безпечніший завдяки меншому ризику гіперкальціємії та судинної кальцифікації.

Рекомендований міжнародними гайдлайнами для пацієнтів з ХХН.

Тому що

Містить ацетат кальцію - сіль, яка працює в кишечнику, зв'язуючи фосфати з продуктів харчування.

Механізм дії

Кальбінд (Кальцію ацетат): Механізм дії Ефективний фосфат-біндер



Що це: Сіль кальцію, що діє як "пастка" для фосфору.

Локалізація дії: Працює у кишечнику, зв'язуючи фосфати з їжі.

Результат: Запобігає всмоктуванню фосфору в кров → усуває тригер гіперпаратиреозу.

Стандарт допомоги: Широко застосовується при Хронічній Хворобі Нирок (ХХН).

Insight: Кальбінд перехоплює фосфати до їх всмоктування, знижуючи системне навантаження.

NotebookLM

11. Конкуренти

Конкурентне оточення

Параметр	КАЛЬБІНД	Інші Са-вмісні біндери	Севеламер
Ефективність	✓ Висока	◇ Середня	✓ Висока
Безпека	✓ Мінімальний ризик гіперкальціємії	✗ Вищий ризик	✓ Висока
Ціна	✓ Доступний	✓ Доступний	✗ Висока
Біодоступність	✓ Висока	✗ Низька	✓ Висока
Комплаєнтність	✓ Висока (по 1 таблетці 3 рази на добу)	✗ Низька (6-12 табл)	◇ Середня (1-2 т./3 р. на день)

СЕВЕЛАМЕР ВІСТА

Що це за речовина?

Севеламер - це синтетичний полімер, який не містить кальцію або металів.

Його діюча форма - севеламер карбонат або севеламер гідрохлорид.

Механізм дії:

Севеламер зв'язує фосфати в їжі ще в ШКТ, не даючи їм всмоктуватися в кров.

Потім виводиться з фекаліями, не проникаючи в кровотік.

Кому призначається?

Пацієнтам на гемодіалізі або перитонеальному діалізі

Тим, хто має високий рівень фосфору в крові

Особам, яким не рекомендуються препарати з кальцієм

Найбільше питання - це вартість (5700 за уп), а також комплаєнс - адже пацієнту необхідно приймати 6-12 таблеток.

РІЗНИЦЯ МІЖ КАЛЬЦІЄМ: АЦЕТАТ, КАРБОНАТ

АЦЕТАТ

Ключова особливість: сильний фосфатзв'язувальний ефект.

Що робить:

- активно зв'язує фосфати в кишечнику
- зменшує їх всмоктування
- таким чином знижує рівень фосфору в крові

Особливості:

- містить менше елементарного кальцію, ніж карбонат
- краще працює навіть при низькій кислотності шлунка
- менший ризик кальцієвого перевантаження при фосфатному контролі

Коли доречний:

- порушення кальцій-фосфорного обміну
- стани з підвищеним фосфором
- ситуації, де важливий контроль фосфатів, а не просто «дати кальцій»

КАРБОНАТ

Ключова особливість: високий вміст елементарного кальцію.

Що робить:

- забезпечує надходження кальцію з їжею
- частково зв'язує фосфати у кишечнику
- може зменшувати їх всмоктування при прийомі з їжею

Особливості:

- містить найбільшу кількість елементарного кальцію
- для кращого засвоєння потребує кислого середовища шлунка
- ефективність знижується при низькій кислотності
- може спричиняти дискомфорт з боку ШКТ

Коли доречний:

- потреба у додатковому кальції
- за відсутності порушень кислотності шлунка
- у ситуаціях, де фокус саме на кількості кальцію

РІЗНИЦЯ МІЖ КАЛЬЦІЄМ: ЦИТРАТ, ГЛЮКОНАТ

ЦИТРАТ

Ключова особливість: добре засвоюється незалежно від кислотності шлунка.

Що робить:

- забезпечує надходження кальцію
- рівномірно всмоктується у травному тракті
- не залежить від прийому їжі

Особливості:

- містить менше елементарного кальцію, ніж карбонат
- добре переноситься з боку ШКТ
- підходить для тривалого застосування
- не потребує кислого середовища

Коли доречний:

- знижена кислотність шлунка
- чутливий шлунково-кишковий тракт
- потреба у стабільному засвоєнні кальцію

ГЛЮКОНАТ

Ключова особливість: низький вміст елементарного кальцію.

Що робить:

- забезпечує мінімальне надходження кальцію при пероральному прийомі
- не має вираженого фосфатзв'язувального ефекту

Особливості:

- значно нижчий вміст кальцію порівняно з іншими солями
- пероральні форми мають обмежену ефективність
- частіше використовується у формі ін'єкцій

Коли доречний:

- у клінічних ситуаціях для парентерального введення
- не підходить для корекції харчового дефіциту кальцію
- не використовується для контролю фосфатів

11. Скрипти

**СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ
ПРАЦЮЄМО:
КАЛЬБІНД**

Ендокринолог:

вторинний гіперпаратиреоз(ВГПТ)

Скрипт

S — Ситуація

У Вашій практиці є пацієнти, у яких рівень кальцію в крові тривалий час залишається в межах норми, але при цьому ПТГ підвищений? Чи погоджуєтесь Ви, що саме ПТГ визначає, яким буде рівень кальцію в крові, а не навпаки? На які показники Ви в першу чергу орієнтуєтесь при веденні таких пацієнтів — на кальцій чи на ПТГ?

P — Проблема

На практиці ми часто бачимо, що нормальний кальцій створює ілюзію контролю, тоді як ПТГ уже працює в компенсаторному режимі. Фактично, кальцій у крові підтримується за рахунок дії ПТГ, а не за рахунок адекватного кальцієвого балансу. У результаті ПТГ зростає непомітно, а ВГПТ формується ще до появи змін у кальції чи клінічних симптомів. Чи стикались Ви з ситуацією, коли ПТГ високий, а явних причин для цього не видно?

I — Наслідки

Тривало підвищений ПТГ означає, що організм постійно змушений регулювати кальцій гормонально, а не фізіологічно. Це призводить до того, що кальцій у аналізі залишається стабільним, але гормональна залежність від ПТГ зростає, і ВГПТ переходить у хронічну форму. Фактично, без контролю ПТГ ми втрачаємо реальний контроль над кальцієвим гомеостазом, навіть якщо кальцій у біохімії в межах норми.

N — Рішення

Саме тому при ВГПТ ключовим показником контролю має бути ПТГ, а не лише кальцій. Корекція має бути спрямована на зменшення постійної стимуляції секреції ПТГ, яка й підтримує кальцій у крові. Таким чином, Кальбінд працює не на симптом, а на один із головних механізмів ВГПТ. Кальбінд дозволяє впливати на механізми, що підтримують підвищений ПТГ, і знижувати його стимулюючу дію на кальцієвий обмін без надмірного кальцієвого навантаження. Чи могли б Ви розглянути ведення пацієнтів із ВГПТ з

орієнтацією на динаміку ПТГ як первинного маркера ефективності терапії та використовувати Кальбінд як частину комплексної терапії ВГПТ у пацієнтів із підвищеним ПТГ ? Пропоную почати з 3–5 пацієнтів.

ГЛІКОМІЦЕЛ



Глікоміцел

Дієтична добавка

Листок-вкладиш

Вміст в 1 капсулі:

Екстракт плодового тіла гриба рейші (*Ganoderma lucidum*) 10:1 – 500 мг (mg).

Склад: екстракт плодового тіла гриба рейші (10:1), наповнювач: целюлоза мікрокристалічна, антизлежувальні агенти: стеарат кальцію та кремнію діоксид колоїдний безводний, капсула: желатин, барвник: оксид цинку.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу після споживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Не рекомендовано вагітним і жінкам під час лактації, дітям до 18 років. Зберігати у недоступному для дітей місці.

12.Карта продукту

Ключове повідомлення

Глікоміцел — натуральний метаболічний та судинний модератор на основі рейші.

Позиціонування

Глікоміцел — перший натуральний метаболічний модератор на основі екстракту гриба рейші, спеціально створений для пацієнтів з дисліпідемією, інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями.

Який:

- підтримує нормальний рівень холестерину та здоров'я судин;
- покращує сприйнятливість організму до інсуліну, допомагаючи контролювати цукор у крові;
- додає енергії та допомагає легше переносити стрес завдяки природній силі гриба рейші.

Тому що містить: екстракт плодового тіла гриба рейші (*Ganoderma lucidum*)-підтримує здоров'я судин та мікроциркуляцію, покращує метаболізм глюкози й чутливість до інсуліну.

12.Конкуренти

Ключові конкуренти

Атеродінол



Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт бергамоту (Citrus bergamia) – 250 mg (мг), екстракт червоного ферментованого рису (Red rice extract) – 100 mg (мг) [що еквівалентно 3 mg (мг) монаколіну K], 5-метилтетрагідрофолат (5-methyltetrahydrofolate) – 0,2 mg (мг); допоміжні речовини: наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, мальтодекстрин, кальцію стеарат, кальцію карбонат, діоксид кремнію (орісіл); оболонка капсули: желатин.

Рекомендації щодо застосування

Атеродінол® рекомендований як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження та фолату. Сприяє нормалізації ліпідного обміну, кращому контролю рівнів холестерину, ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності, тригліцеридів при їх підвищених концентраціях у плазмі крові. Атеродінол® протидіє окисному стресу і мікрозапаленню, що приводить до покращення функціонального стану ендотелію судин та пригнічення утворення

атеросклеротичних бляшок у судинах. Атеродіол® є джерелом активної форми фолієвої кислоти, що сприяє зниженню рівня гомоцистеїну в крові і, як наслідок, зменшенню ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1-2 капсули на день після або під час їди, запиваючи достатньою кількістю питної води. Рекомендований курс прийому: 1-3 місяці. За необхідності курс прийому може бути скореговано лікарем.

ХПВ

1. **Глікоміцел має більш зручну Форму Випуску:** всього 1 таблетка на добу, тоді як Атеродіол приймається по 1к. 2р/д. Глікоміцел зручний в плані комплаєнсу для пацієнта.
2. **Глікоміцел працює не лише на холестерин, а впливає також на гіпоглікемічний ефект, інсулінорезистентність, хронічне запалення та імунну регуляцію, на відміну від Атеродіолу, який діє точково лише на ліпідний профіль, отже пацієнти отримують комплексне зниження кардіометаболічного ризику.**
3. Глікоміцел чинить **імуномодулюючу дію**, на відміну від конкурента, що не впливає на імунний баланс, **отже відновлюється контроль над хронічним низькорівневим запаленням.**
4. **Глікоміцел дешевше по ціні і на місяць і на курс**, пацієнти зможуть собі дозволити препарат Глікоміцел і отримати повний курс лікування.

Ксінокард



Склад: L-карнітину тартрат-500 мг, коензим Q 10-40 мг, кверцетину дегідрат-25 мг. Доп. речовини: мальтодекстрин, мікрокристалічна целюлоза, натрію кроскармелоза, гастрорезистентна оболонка (етилцелюлоза, тригліцериди середнього ланцюга, олеїнова кислота, гідрохлорид амонію, натрію альгінат, стеаринова кислота Єврофарм), силіцію діоксид, стеаринова кислота Єврофарм рослинного походження, стеарат магнію Єврофарм рослинного походження, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин Єврофарм рослинного походження.

Опис

Може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування як джерело вітамінів, біологічно активних речовин з метою загального зміцнення організму і створення оптимальних дієтологічних умов обміну речовин, зокрема прискорення метаболізму жирів, стимулювання регенерації клітин і тканин, підвищення апетиту. Продукт збільшує толерантність до стресів і підвищує адаптаційні можливості організму людини. Має потужну протизапальну та протиалергічну дію, зміцнює і відновлює сполучну тканину, сприяє зниженню рівня холестерину, підсилює дію багатьох корисних речовин. Підвищує стійкість тканин організму до шкідливого впливу надмірного вмісту цукру в крові, знижує ймовірність захворювання на діабет, а також полегшує перебіг вже існуючих форм. Позитивно впливає на нервову систему, активізує нервові процеси. Сприяє уповільненню процесів старіння організму, продовження розумової та фізичної активності, покращення якості життя.

Спосіб застосування та дози

Якщо продукт призначається лікарем, можлива зміна дозування: по 1 таблетці 2-3 рази на добу після їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Курс прийому - 1-2 місяці.

ХПВ

1. **Глікоміцел має більш зручну Форму Випуску:** всього 1 таблетка на добу, тоді як Ксінокард приймається по 1к. 2р/д. Глікоміцел зручний в плані комплаєнсу для пацієнта.
2. **Глікоміцел вигідний по ціні і на місяць і на курс,** на відміну від Ксінокард, Глікоміцел доступний для пацієнтів.

3. Глікоміцел працює на ліпідний обмін та печінковий метаболізм, на відміну від Ксінокарду, який виконує переважно антиоксидантну функцію, отже пацієнт отримує комплексну підтримку серцево-судинної та печінкової системи.

Ліпідоспад



Склад

1 капсула містить: інгредієнти: екстракт барбарису остистого (15:1) – 150 mg (mg), коензим Q10 – 60 mg (mg), риба́чий жир (омега-3-поліненасичені жирні кислоти DHA : EPA = 5-6,25:1) – 50 mg (mg), полікозанол – 20 mg (mg); допоміжні речовини: наповнювачі: крохмаль картопляний, натрію кроскармелоза, мікрокристалічна целюлоза, кальцію карбонат, кальцію стеарат, діоксид кремнію аморфний; оболонка капсули: желатин.

Показання

Ліпідоспад може бути рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування та який є джерелом екстракту барбарису остистого, коензиму Q10, полікозанолу, омега-3-поліненасичених жирних кислот, які беруть участь у нормалізації рівня ліпідів в крові, артеріального тиску, функціонального стану серцево-судинної системи.

Спосіб застосування та дози

По 1 капсулі 1 раз на день незалежно від прийому їжі.

Тривалість споживання: 2-3 місяці. В подальшому тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

ХПВ

1. **Глікоміцел знижує холестерин та покращує метаболічний профіль, на відміну від Ліпідоспаду, який діє точково на ліпіди та антиоксидантний захист, отже пацієнт отримує комплексну підтримку печінки та зменшення хронічного запалення.**
2. **Глікоміцел комплексно впливає на холестерин, печінку та запальні процеси, на відміну від Ліпідоспаду, отже пацієнт отримує ширшу метаболічну підтримку та захист серцево-судинної системи.**

Фітостатин



Склад

1 таблетка містить основну речовину - полікозанолом - 20 мг.

Показання

«ФітоСтатін» рекомендується як додаткове джерело полікозанолом - природній суміші вищих первинних аліфатичних спиртів, отриманих шляхом екстрагування з цукрової тростини (*Saccharum officinarum*) з метою нормалізації рівня загального холестерину ЛПНЩ

(ліпопротеїдів низької щільності) в сироватці крові та поліпшення функціонального стану серцево-судинної системи. «ФітоСтатін» має антиоксидантні та гіпохолестеринемічними властивостями; запобігає надлишкову агрегацію (клейкість) тромбоцитів, не впливаючи при цьому на показники згортання крові.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим 1 раз на добу під час вечері запиваючи питною водою.

ХПВ

1. **Глікоміцел у капсулах працює комплексно на метаболізм, печінку та запальні процеси, на відміну від Фітостатину у таблетках, що містить полікозанол, отже пацієнт отримує ширший спектр дії та кращу переносимість.**
2. **Глікоміцел працює завдяки комплексу біоактивних сполук рейші (тритерпени, полісахариди), на відміну від полікозанолу, що забезпечує лише точковий ефект, отже формується комплексна підтримка організму, а не дія в одному напрямку.**

Альфаполістатин



Склад

Одна капсула містить (активні речовини): Екстракт люцерни – 250 мг.
Коензим Q10 – 60 мг. Полікозанол – 10 мг.

Допоміжні речовини: ексципієнти (мікрокристалічна целюлоза, аморфний діоксид кремнію, кальцію стеарат), оболонка капсули (желатин).

Опис

Дієтична добавка на основі рослинної сировини "Альфаполістатин" може бути рекомендована як джерело біологічно активних речовин для нормалізації роботи серцево-судинної системи, рівня холестерину та артеріального тиску.

Спосіб застосування

Дорослим по одній капсулі 2 рази на день під час їжі.

Рекомендований курс прийому 3-4 місяці (надалі прийом необхідно погоджувати з лікарем).

ХПВ

1. **Глікоміцел має більш зручну Форму Випуску:** всього 1 таблетка на добу, тоді як Альфаполістатин приймається по 1к. 2р/д. Глікоміцел зручний в плані комплаєнсу для пацієнта.
2. **Глікоміцел дешевше по ціні і на місяць і на курс,** на відміну від конкурента, пацієнти зможуть собі дозволити препарат Глікоміцел і отримати повний курс лікування.
3. **Глікоміцел впливає на декілька патогенетичних ланок одночасно завдяки біоактивним компонентам рейші,** тоді як **Альфаполістатин має точкову дію окремих компонентів,** отже пацієнт отримує ширшу метаболічну підтримку.

12.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ГЛІКОМІЦЕЛ

Ендокринолог:

1. Дисліпідемія
2. Метаболічний синдром — ліпідно-судинний компонент (без акценту на глікемію)
3. Атеросклеротичний ризик у пацієнтів з ІР / предіабетом
4. Судинні порушення на тлі метаболічних розладів

Сімейний лікар:

1. Дисліпідемія
2. Кардіометаболічний ризик
3. Пацієнти з ІР / предіабетом — як судинний супровід

Дисліпідемія

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у Вашій практиці зустрічаються пацієнти з дисліпідемією — підвищеним рівнем загального холестерину, ЛПНЩ або тригліцеридів, особливо на тлі інсулінорезистентності, метаболічного синдрому чи надмірної маси тіла?»

P — Проблема

«Чи звертали Ви увагу, що навіть за умови рекомендацій щодо дієти та фізичної активності, а іноді й на фоні фармакотерапії, у частини таких пацієнтів ліпідний профіль залишається неконтрольованим? Часто це пов'язано з порушенням вуглеводного обміну, хронічним запаленням і оксидативним стресом, які підтримують дисліпідемію та знижують ефективність стандартних підходів.»

I — Наслідок

«Якщо не впливати на ці метаболічні механізми, дисліпідемія може прогресувати, підвищуючи ризик атеросклерозу, серцево-судинних ускладнень і необхідність раннього або більш інтенсивного медикаментозного втручання.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б зручно мати у практиці засіб метаболічної підтримки — Глікоміцел, який містить Екстракт плодового тіла гриба рейші, що сприяє покращенню чутливості до інсуліну, нормалізації ліпідного обміну та зменшенню оксидативного стресу?

Чи могли б Ви розглянути рекомендацію Глікоміцелу 3–5 пацієнтам з дисліпідемією, особливо при поєднанні з інсулінорезистентністю або метаболічним синдромом, як частину комплексного підходу?

Метаболічний синдром — ліпідно-судинний компонент

S — Ситуація

«Скажіть, будь ласка, чи часто Ви спостерігаєте пацієнтів із абдомінальним ожирінням і артеріальною гіпертензією, у яких вже на ранніх етапах виявляються атерогенні зміни ліпідного спектра та ознаки судинної жорсткості?»

P — Проблема

«Чи звертали Ви увагу, що у таких пацієнтів ліпідні порушення мають більш агресивний перебіг: швидше формуються атеросклеротичні бляшки, знижується еластичність судин, погіршується мікроциркуляція? Це часто пов'язано з дисбалансом ліпідного метаболізму, активацією перекисного окислення ліпідів та порушенням захисної функції ендотелію.»

I — Наслідок

«За відсутності цілеспрямованого впливу на ці механізми зростає сумарний серцево-судинний ризик: прискорюється прогресування атеросклерозу, підвищується ймовірність ішемічних подій і формується потреба в більш інтенсивній медикаментозній терапії.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б корисно мати у практиці засіб нутрієнтної підтримки — Глікоміцел, який сприяє корекції атерогенних ліпідних змін, зменшенню оксидативного ушкодження судинної стінки та підтримці ендотеліальної функції? Чи могли б Ви розглянути рекомендацію Глікоміцелу 3–5 пацієнтам із метаболічним синдромом, у яких домінує ліпідно-судинний компонент, як частину комплексної профілактики серцево-судинних ускладнень?»

Атеросклеротичний ризик у пацієнтів з ІР / предіабетом

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто Ви спостерігаєте пацієнтів із предіабетом або інсулінорезистентністю, у яких ще немає клінічних серцево-судинних подій, але вже з'являються ознаки раннього атеросклерозу?»

P — Проблема

«Чи звертали Ви увагу, що у таких пацієнтів атеросклеротичний процес стартує значно раніше і без виражених симптомів?

На фоні інсулінорезистентності зростає оксидативний стрес і формується хронічне судинне запалення, яке довго залишається недооціненим.»

I — Наслідок

«Без раннього втручання ці зміни поступово призводять до прискореного прогресування атеросклерозу, підвищення жорсткості артерій і збільшення ризику серцево-судинних подій ще до маніфестації цукрового діабету.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б доцільно доповнити стандартні профілактичні рекомендації засобом метаболічної підтримки — Глікоміцел, який сприяє зменшенню проатерогенних змін ліпідів, зниженню оксидативного стресу та підтримці судинного ендотелію?

Чи могли б Ви розглянути рекомендацію Глікоміцелу 3–5 пацієнтам з ІР або предіабетом з підвищеним атеросклеротичним ризиком як частину ранньої судинної профілактики?»

Судинні порушення на тлі метаболічних розладів

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто Ви стикаєтеся з пацієнтами, які скаржаться на холодні кінцівки, головний біль, зниження толерантності до фізичних навантажень або періодичні набряки, при цьому маючи ознаки метаболічних порушень?»

P — Проблема

«Чи помічали Ви, що ці симптоми часто не мають чіткої органічної причини на ранніх етапах, але відображають порушення судинної регуляції? Метаболічні зміни сприяють ендотеліальній дисфункції, зниженню біодоступності оксиду азоту та посиленню оксидативного стресу, що погіршує судинний тонус і мікроциркуляцію.»

I — Наслідок

«За відсутності цілеспрямованої корекції ці функціональні судинні порушення можуть прогресувати, трансформуючись у стійкі структурні зміни судинної стінки, підвищення периферичного опору та зростання серцево-судинного ризику.»

N — Рішення

«Чи цікаво б вам було послухати про новий продукт — Глікоміцел, який сприяє зменшенню метаболічно зумовленого судинного стресу, підтримує ендотеліальну функцію та покращує мікроциркуляцію? Чи могли б Ви рекомендувати Глікоміцел 3–5 пацієнтам із судинними порушеннями на тлі метаболічних розладів як частину комплексного підходу?»

Кардіометаболічний ризик

S — Ситуація

«Лікарю, чи доводиться Вам оцінювати пацієнтів, у яких поєднуються кілька помірних факторів ризику — надмірна маса тіла, дисліпідемія, підвищений артеріальний тиск — але які часто недооцінюють свій сумарний кардіометаболічний ризик?»

P — Проблема

«Чи помічали Ви, що саме поєднання цих факторів, навіть без виражених клінічних проявів, запускає каскад метаболічних і судинних змін? Формується хронічний прооксидантний стан, порушується енергетичний обмін у клітинах судинної стінки та знижується її адаптаційний резерв.»

I — Наслідок

«Якщо не втручатися на цьому етапі, кардіометаболічний ризик реалізується швидше: зростає ймовірність атеросклерозу, артеріальної гіпертензії та серцево-судинних подій у середньостроковій перспективі.»

N — Рішення

«Наскільки для Вас було б доцільно доповнити профілактичну стратегію засобом нутрієнтної підтримки — Глікоміцел, який допомагає зменшити метаболічне навантаження, підтримати судинну функцію та знизити сумарний кардіометаболічний ризик?

Чи могли б Ви розглянути рекомендацію Глікоміцелу 3–5 пацієнтам із підвищеним кардіометаболічним ризиком як частину ранньої профілактики?»

ЛІБЕРА АРГІНІН



Дієтична добавка

ЛІБЕРА® АРГІНІН

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Рекомендована щоденна порція містить:	3 капсули
екстракт стебла і листя леспедези головчастої	900 мг (mg)
L-аргінін	450 мг (mg)

Склад: 1 капсула містить: екстракт стебла і листя леспедези головчастої (*Lespedeza capitata* Michx.), порошкоподібний – 300 мг (mg) (66 %*); L-аргінін (L-Arginine) – 150 мг (mg) (33 %*); антиспікаючий агент: стеарат кальцію; оболонка капсули: желатин.

* – % від маси вмісту капсули.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована щоденна порція: вживати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу, незалежно від прийому їжі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: зазвичай становить 3 місяці. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану порцію для щоденного споживання. При додатковому вживанні L-аргініну необхідно враховувати, що

сумарна добова порція L-аргініну не повинна перевищувати 6 г. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Рекомендовано контролювати рівень натрію в крові.

Протипоказання: вагітність та період лактації, дитячий вік до 18 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 455 мг (mg) $\pm$ 7,5 % № 30 або № 90 у блістерах, упакованих у картонну коробку.

Номер партії (серії) та дата «Краще спожити до кінця» зазначені на упаковці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника (фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва): ТОВ «АКТИЛАЙФ НУТРИШН», Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

13. Карта продукту

Ключове повідомлення

Лібера Аргінін - подвійна підтримка ендотелію та нирок у концепції кардіо-рено-метаболічного континууму.

Позиціонування

ЛІБЕРА АРГІНІН — подвійна підтримка ендотелію та нирок у концепції кардіо-рено-метаболічного континууму:

- підтримує фізіологічну продукцію NO;
- сприяє покращенню мікроциркуляції;
- підтримує функцію ендотелію;
- допомагає заздалегідь підтримати органи-мішені.

Тому що містить:

L-аргінін, який є природним попередником NO;

Екстракт леспедези головчастої, який проявляє антиоксидантний потенціал, підтримує функцію ендотелію та клітинний енергетичний обмін;

Які діють синергічно, забезпечуючи підтримку всіх ланок кардіо-рено-метаболічного континууму.

13. Конкуренти

Ключові конкуренти

Дуонефрил



Склад	Екстракт леспедези головчастої - 300 мг; Силімарин - 50 мг Екстракт леспедези головчастої - 500 мг; Силімарин - 75 мг
Ціна	№30 – 430 грн, №90 – 1060 грн №30 – 550 грн, №90 – 1250 грн

**Леспенефрил,
Леспенефрон**



Склад	Екстракт стебла та листя леспедези головчастої - 300 мг; Екстракт леспедези головчастої - 350 мг
Ціна	№30 – 350 грн, №90 – 1040 грн №30 – 470 грн

Леспераза



Склад	Екстракт леспедези головчастої – 300 мг; Екстракт ортосифону тичинкового – 100 мг
Ціна	№30 – 470 грн

Леспедезин



Склад	Екстракт Леспедези головчастої – 350 мг; розторопші екстракту сухого – 62,56 мг, що еквівалентно 50 мг силімарину, екстракт листя брусниці - 30 мг
Ціна	№60 – 1050 грн

ЛІБЕРА - єдина має патент на виробництво екстракту Леспедези головчастої

ЛІБЕРА – ЄДИНА, ХТО МАЄ ПАТЕНТ

на виготовлення
**ЕКСТРАКТУ ЛЕСПЕДЕЗИ
ГОЛОВЧАСТОЇ**

-  **УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ**
власний спосіб приготування
сухого екстракту
-  **ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ**
стабільна якість
та відтворюваний склад
-  **ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД**
науково обґрунтований
та запатентований
-  **ЕКСКЛЮЗИВНА ПЕРЕВАГА ЛІБЕРИ**
турбота про здоров'я пацієнтів
на основі унікального екстракту





ПАТЕНТ № 129440
Зареєстровано в Державному
реєстрі України винаходів
23.04.2025

Екстракт леспедези
головчастої
360 мг
L-Аргінін
150 мг
30 капсул

УНІКАЛЬНИЙ ЕКСТРАКТ. ДОКАЗОВА ЯКІСТЬ. ЛІБЕРА.
Інноваційна підтримка ендотелію та нирок у концепції кардіо-рено-метаболічного континууму

13. Скрипти

СКРИПТ ВІЗИТУ ДО ЕНДОКРИНОЛОГА

ВСТУП

Добрий день, лікарю! Радий(а) Вас бачити.

Сьогодні хотів(ла) б коротко поговорити про пацієнтів з КРМС та про ще одну важливу мішень, якій останніми роками приділяють дедалі більше уваги, — ендотеліальну дисфункцію.

СИТУАЦІЯ

У Вашій практиці більшість пацієнтів із ЦД2 мають не лише підвищений рівень глюкози. У багатьох вже є АГ, ожиріння, альбумінурія або інші ранні прояви ураження органів-мішеней.

Сьогодні ми розуміємо, що розвиток цих ускладнень починається задовго до появи клінічних проявів і значною мірою пов'язаний із порушенням функції ендотелію.

Чи погоджуєтесь Ви, що сьогодні лікування пацієнта із ЦД2 — це комплексне питання, а не лише контроль глікемії?

ПРОБЛЕМАТИКА

Навіть при хорошому контролі HbA1c у багатьох пацієнтів продовжують прогресувати серцево-судинні та ниркові ускладнення. Однією з причин є ендотеліальна дисфункція, яка супроводжується зниженням біодоступності оксиду азоту (NO), порушенням мікроциркуляції, посиленням оксидативного стресу та запалення. Саме ці процеси лежать в основі кардіо-рено-метаболічного континууму.

АКТУАЛІЗАЦІЯ

Коли знижується продукція NO, першими страждають судини та органи з інтенсивним кровопостачанням.

Зростає судинна жорсткість, погіршується тканинна перфузія, швидше прогресує альбумінурія, зростає ризик артеріальної гіпертензії, серцево-судинних подій та діабетичної нефропатії.

Тому сьогодні дедалі більше уваги приділяють не лише контролю глюкози, а й підтримці ендотеліальної функції.

НАПРАВЛЕННЯ

Саме тому лікарі все частіше звертають увагу на засоби, які можуть підтримувати фізіологічний синтез NO та одночасно сприяти збереженню функції нирок.

Одним із таких рішень є Лібера Аргінін.

Вона поєднує:

- L-аргінін — природний попередник оксиду азоту (NO), який підтримує ендотеліальну функцію, вазодилатацію та мікроциркуляцію;
- екстракт леспедези головчастої, що має антиоксидантний потенціал, підтримує функцію нирок, ендотелію та мікроциркуляцію.

Таким чином Лібера Аргінін поєднує підтримку судинної та ниркової ланок кардіо-рено-метаболічного континууму.

СКРИПТ ВІЗИТУ ДО КАРДІОЛОГА/ТЕРАПЕВТА

ВСТУП

Добрий день, лікарю! Радий(а) Вас бачити.

Сьогодні хотів(ла) б поговорити про ендотеліальну дисфункцію як спільний механізм розвитку АГ, ІХС в рамках кардіо-рено-метаболічного континууму.

СИТУАЦІЯ

У Вашій практиці більшість пацієнтів мають не лише артеріальну гіпертензію.

Дуже часто це пацієнти з поєднанням кількох факторів ризику: ЦД2, ожиріння, дисліпідемія, альбумінурія.

Сьогодні саме таких пацієнтів ми розглядаємо в рамках кардіо-рено-метаболічного континууму, де ураження судин, метаболічні порушення взаємно підсилюють одне одного.

ПРОБЛЕМАТИКА

Однією з перших ланок цього континууму є ендотеліальна дисфункція.

Зниження біодоступності оксиду азоту призводить до порушення вазодилатації, підвищення судинного тонуусу, погіршення мікроциркуляції, оксидативного стресу, прогресування судинного ремоделювання.

Навіть при адекватному контролі АТ ці процеси можуть продовжувати підтримувати високий серцево-судинний ризик.

Чи звертаєте Ви увагу на пацієнтів, у яких, незважаючи на досягнення цільового АТ, зберігаються ознаки високого судинного ризику або прогресує альбумінурія?

АКТУАЛІЗАЦІЯ

Коли порушується функція ендотелію, страждають не лише великі артерії.

Погіршується мікроциркуляція, підвищується периферичний судинний опір, швидше прогресують ураження органів-мішеней — серця, нирок і мозку. Саме тому сьогодні підтримка ендотелію розглядається як один із важливих напрямків комплексного ведення пацієнтів із високим кардіо-рено-метаболічним ризиком.

НАПРАВЛЕННЯ

Саме тому лікарі все частіше звертають увагу на рішення, які дозволяють підтримувати фізіологічний синтез оксиду азоту та одночасно зберігати функцію органів-мішеней.

Лібера Аргінін поєднує два взаємодоповнюючі компоненти:

L-аргінін — природний попередник NO, який підтримує ендотеліальну функцію, вазодилатацію, мікроциркуляцію та сприяє підтримці нормального судинного тонуусу.

Екстракт леспедези головчастої — компонент із антиоксидантним потенціалом, який підтримує функцію нирок, ендотелію та мікроциркуляцію.

Завдяки цьому Лібера Аргінін забезпечує комплексну підтримку судинної та ниркової ланок кардіо-рено-метаболічного континууму.

Що це дає пацієнту з кардіо-рено-метаболічним ризиком?



Підтримка
ендотеліальної
функції



Покращення
мікроциркуляції



Підтримка
фізіологічного
контролю АТ



Підтримка
функції нирок



Антиоксидантний
захист



Комплексний
вплив на судинну
та ниркову ланки

СПІРОНА

СПІРОНА

Метаболічне запалення під контролем

Стратегічна територія: ожиріння •
інсулінорезистентність • метаболічний
синдром • ЦД2

**СПІРОНА = нутрієнтна
підтримка антиоксидантного та
протизапального контуру при
метаболічних порушеннях**

Цільова аудиторія	Ендокринологи; додатково — сімейні лікарі/терапевти та дієтологи, які ведуть пацієнтів з ожирінням і метаболічними порушеннями.
------------------------------	---

Клінічна територія	Хронічне низькоінтенсивне метаболічне запалення та оксидативний стрес як супутні механізми ожиріння, інсулінорезистентності, метаболічного синдрому та ЦД2.
Роль продукту	Дієтична добавка на основі <i>Spirulina platensis</i> як додаткове джерело біологічно активних речовин; не замінює базову терапію, харчування та фізичну активність.
Ключова ідея	Не лише контролювати глікемію та вагу — бачити метаболічний прозапальний фон, який підтримує кардіометаболічний ризик.
Кампанійний меседж	«Гасимо метаболічне запалення» — через підтримку антиоксидантного захисту та модулювання прозапальної сигналізації.

Комунікаційна формула

**ВІСЦЕРАЛЬНИЙ ЖИР → ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС → NF-κB /
ПРОЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ → IP → МЕТАБОЛІЧНИЙ РИЗИК**

14. Карта продукту

СПІРОНА — картка продукту

Категорія	Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
Форма	Таблетки №100 у полімерному контейнері.
1 таблетка	Порошок спіруліни пласкої (<i>Spirulina platensis</i>) — 1000 мг.
Добова порція	3 таблетки = 3000 мг порошку <i>Spirulina platensis</i> .
Спосіб застосування	Дорослим по 1 таблетці 3 рази на добу за 20–30 хв до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.
Термін	1 місяць; подальший прийом та повторний курс — за погодженням з лікарем.
Застереження	Вагітність і лактація, вік до 18 років, індивідуальна чутливість до компонентів.
Виробник	ТОВ «АКТИЛАЙФ НУТРИШН», Україна. Замовник — ТОВ «БІХЕЛС».

Картка продукту: позиціонування

СПІРОНА — підтримка метаболічного балансу через вплив на оксидативний стрес і прозапальну сигналізацію

ЯКА:

- підтримує антиоксидантний захист клітин;
- допомагає зменшувати прооксидантне навантаження, пов'язане з метаболічними порушеннями;
- підтримує фізіологічну регуляцію прозапальних сигнальних шляхів;
- може бути включена в комплексний підхід у пацієнтів з ожирінням та кардіометаболічними факторами ризику.

ТОМУ ЩО МІСТИТЬ:

Spirulina platensis — 3 г у рекомендованій добовій порції.

Спіруліна є природним джерелом біоактивних компонентів, серед яких найбільш дослідженим щодо антиоксидантних та протизапальних механізмів є фікоціанін/фікоціанобілін; у науковій літературі також описані каротиноїди та інші антиоксидантні компоненти.

КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СПІРОНА — коли у пацієнта з ожирінням та ІР важливо працювати не лише з цифрами глюкози, а й з метаболічним прозапальним фоном.

Важливо для польової комунікації: офіційна інструкція декларує продукт як додаткове джерело біологічно активних речовин. Механістичні формулювання нижче базуються на наукових даних щодо Spirulina/фікоціаніну, а не на зареєстрованих лікувальних показаннях Спірони.

Механізм: від вісцерального жиру до метаболічного запалення

Етап	Що відбувається	Клінічний сенс
------	-----------------	----------------

1	Гіпертрофія адипоцитів	Надлишок вісцеральної жирової тканини асоціюється з підвищеним утворенням ROS та секрецією прозапальних медіаторів.
2	Оксидативний стрес	Надлишок ROS активує чутливі до редокс-стану сигнальні шляхи та підтримує запальну відповідь.
3	NF-κB	NF-κB є одним із центральных транскрипційних регуляторів прозапальної відповіді; у доклінічних моделях фікоціанін пригнічував його активацію.
4	TNF-α / IL-6 / IL-1β	Прозапальні цитокіни порушують інсуліновий сигнал і підтримують метаболічну дисфункцію.

5	IP і кардіометаболічний ризик	Формується самопідтримуваний контур: IP ↔ ліпотоксичність ↔ оксидативний стрес ↔ запалення.
---	-------------------------------	---

Де вбудовується Спірона

АНТИОКСИДАНТНИЙ КОНТУР + МОДУЛЮВАННЯ ПРОЗАПАЛЬНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Біоактивні компоненти Spirulina: що говоримо лікарю

Фікоціанін / фікоціанобілін	У доклінічних роботах описані антиоксидантні властивості, зниження ROS/NOX-залежного оксидативного стресу та модулювання NF-κB-сигналіngu.
Прозапальні медіатори	Для фікоціаніну в експериментальних моделях описане зниження формування TNF-α та інших прозапальних медіаторів.
Каротиноїди	β-каротин та інші каротиноїди спіруліни розглядаються як частина антиоксидантного потенціалу біомаси.
Клінічні дані Spirulina	Метааналізи РКД демонструють потенційний вплив на окремі кардіометаболічні показники та CRP; результати залежать від популяції, дози й тривалості.

для МП: «Спірона не замінює базову терапію. Її місце — додаткова нутрієнтна підтримка у пацієнта, в якого поряд з ІР та ожирінням існує оксидативно-запальний метаболічний фон».

Доказова база

Що можна використовувати як науковий бекграунд

- Систематичний огляд і метааналіз 23 досліджень у 1 035 дорослих з надмірною масою тіла/ожирінням: Spirulina асоціювалася з покращенням низки ліпідних показників та маси тіла; для глікемії та інсуліну ефект був непослідовним.
- Метааналіз CRP: у 10 ефектах Spirulina статистично значуще знижувала CRP, але гетерогенність досліджень була високою.
- Огляди механізмів: фікоціанін/фікоціанобілін може модулювати NF-κB, NADPH-оксидазу та прозапальні медіатори в доклінічних моделях.
- Клінічні дані не дають підстав позиціонувати Спірону як лікування ЦД2, ожиріння чи запальних захворювань; комунікація має залишатися в межах додаткової нутрієнтної підтримки.

ДОКАЗОВИЙ МЕСЕДЖ: механістична правдоподібність + клінічний сигнал, але без підміни стандартної терапії

14. Конкуренти

Конкурентне поле

Пряме конкурентне поле — інші продукти категорії «спіруліна». На Tabletki.ua у цій категорії присутні, зокрема, OstroVit Spiruline та NOW Spirulina. Конкуренцію доцільно будувати не на непідтверджених твердженнях про «унікальність» сировини, а на чіткому медичному позиціонуванні Спірони в ендокринологічному маршруті.

Критерій	СПІРОНА	OstroVit Spiruline	NOW Spirulina
Спіруліна на таблетку	1000 мг	1000 мг у 2 таблетках у варіанті №90	1000 мг у Double Strength
Рекомендована добова порція	3000 мг	залежить від конкретного SKU	залежить від конкретного SKU
Кампанійна територія	Метаболічне запалення / ендокринологія	Загальна категорія нутрицевтиків	Загальна категорія нутрицевтиків
Ключова перевага комунікації	Чіткий пацієнтський портрет + лікарський алгоритм	Не використовуємо неперевірені припущення	Не використовуємо неперевірені припущення

ХПВ для МП

- СПІРОНА має конкретну ендокринологічну територію: пацієнт з ожирінням/IP та метаболічним прозапальним фоном.

- Добова порція за інструкцією — 3 г *Spirulina platensis*; це дозволяє говорити з лікарем конкретною дозою, а не абстрактно про «суперфуд».
- Комунікація будується навколо механізму та клінічного портрета, а не навколо wellness-обіцянок.

14. Скрипти

Спеціалісти та пацієнтські профілі

Спеціаліст	Пацієнти / ситуації	Ключовий аргумент
Ендокринолог	Ожиріння, абдомінальне ожиріння, ІР/предіабет, ЦД2, метаболічний синдром	Побачити оксидативно-запальний контур як додаткову метаболічну мішень.
Дієтолог	Пацієнти у програмі зниження ваги, вага «плато», високий кардіометаболічний ризик	Нутрієнтна підтримка на фоні модифікації харчування та фізичної активності.
Сімейний лікар / терапевт	Поєднання надмірної ваги, АГ, дисліпідемії, порушень глікемії	Комплексний погляд на кардіометаболічний ризик без конкуренції з базовою терапією.

Пріоритетний портрет

Пацієнт 35–60 років • абдомінальне ожиріння • ІР/предіабет або ЦД2 • дисліпідемічні зміни • недостатня відповідь лише на lifestyle

Скрипти візиту до ендокринолога

Скрипт 1. Ожиріння + інсулінорезистентність

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто у Вашій практиці є пацієнти з абдомінальним ожирінням та ІР, у яких навіть на фоні зміни харчування й фізичної активності метаболічні показники покращуються повільно?»

P — Проблема

«У такого пацієнта ми маємо не лише надлишок жирової тканини. Гіпертрофована вісцеральна жирова тканина підтримує оксидативний стрес і низькоінтенсивну прозапальну сигналізацію, що може поглиблювати ІР.»

I — Наслідок

«Якщо цей контур зберігається, пацієнту складніше вийти з метаболічного каскаду: ІР → гіперглікемія → дисліпідемічні зміни → зростання кардіометаболічного ризику.»

N — Рішення

«Спірона містить 3 г *Spirulina platensis* у добовій порції. Її можна розглядати як додаткову нутрієнтну підтримку антиоксидантного та протизапального контуру на фоні базової терапії. Чи готові Ви розглянути Спірону у 3–5 пацієнтів з ожирінням та ІР, де метаболічний прозапальний фон є клінічно релевантним?»

Скрипт 2. Метаболічний синдром

S — Ситуація

«Чи погоджуєтесь Ви, що у пацієнта з абдомінальним ожирінням, АГ, ІР і ранньою дисліпідемією ми вже маємо не окремі фактори, а взаємопов'язаний метаболічний каскад?»

P — Проблема

«Одна з ланок цього каскаду — хронічний оксидативно-запальний фон, який підтримує дисфункцію адипоцитів та порушення інсулінового сигналу.»

I — Наслідок

«Тому контроль лише глікемії не завжди означає, що весь кардіометаболічний ризик взято під контроль.»

N — Рішення

«Спірона може доповнити комплексний підхід як джерело

біоактивних речовин *Spirulina platensis*. Чи можемо домовитися про 3–5 пацієнтів із метаболічним синдромом, у яких Ви бачите потребу в додатковій антиоксидантній підтримці?»

Коротка версія візиту

МП: «Лікарю, у пацієнта з абдомінальним ожирінням та ІР ми сьогодні бачимо не лише порушення глікемії, а й метаболічний прозапальний фон — оксидативний стрес, активацію прозапальних шляхів і подальше поглиблення ІР. Чи достатньо, на Вашу думку, працювати лише з однією ланкою?»

Лікар відповідає.

МП: «Саме в цю додаткову ланку ми вбудовуємо Спірону — 3 г *Spirulina platensis* на добу як нутрієнтну підтримку антиоксидантного та протизапального контуру. Пропоную оцінити її місце у 3–5 пацієнтів з ожирінням/ІР у комплексі з Вашою базовою терапією».

Закриття угоди — у пацієнтах

- «У скількох пацієнтів з ожирінням та ІР цього тижня Ви могли б розглянути Спірону — у трьох чи п'яти?»
- «Домовимося почати з 5 пацієнтів із вираженим абдомінальним ожирінням та метаболічним синдромом і на наступному візиті обговорити Ваші спостереження?»
- «Який портрет для Вас логічніший для старту: ожиріння + ІР чи метаболічний синдром із кількома факторами ризику?»

Робота із запереченнями

Заперечення	Відповідь
«Це просто спіруліна»	«Так, основа Спірони — <i>Spirulina platensis</i> . Відмінність нашої комунікації не в тому, щоб називати її “ліками”, а в чіткому місці в алгоритмі: 3 г/добу як додаткова нутрієнтна підтримка пацієнта з метаболічним оксидативно-запальним фоном.»
«У пацієнта вже багато препаратів»	«Саме тому ми не пропонуємо заміну базової терапії. Спірона — дієтична добавка, яку можна розглядати лише як доповнення, якщо лікар бачить клінічну потребу.»
«Я працюю тільки з доказовими підходами»	«Це правильний підхід. Для <i>Spirulina</i> є систематичні огляди й метааналізи щодо окремих кардіометаболічних маркерів, але ефекти неоднорідні. Тому ми не перебільшуємо: говоримо про додаткову підтримку, а не лікування ожиріння чи ЦД2.»
«Чому саме при ожирінні?»	«Тому що ожиріння, особливо вісцеральне, асоційоване з хронічним низькоінтенсивним запаленням та оксидативним стресом. Це і є логічна територія для антиоксидантної нутрієнтної підтримки.»

НЕВРОЛОГІЯ

НЕЙРОМІНЕРІЙ



Дієтична добавка

Нейромінерій™ • Neurominerii

Листок-вкладиш

(Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Інгредієнти:	1 капсула	Добова кількість (2 капсули)
оксид магнію «Simag™ 55»	227 мг (mg) (у перерахунку на магній – 125 мг (mg), що відповідає 33,3 %*)	454 мг (mg) (у перерахунку на магній – 250 мг (mg), що відповідає 66,7 %*)
оротова кислота	25 мг (mg)	50 мг (mg)
піридоксину гідрохлорид (віт. B6)	2,7 мг (mg) (що відповідає 192,8 %*)	5,4 мг (mg) (що відповідає 385,6 %*)

* - відсоток від референсної величини споживання вітамінів та мінеральних речовин для дорослих (осіб старше 18 років).

Склад: наповнювач: мальтодекстрин; оксид магнію «Simag™ 55» (40,9 %); оротова кислота (4,5 %), піридоксину гідрохлорид (віт. B6) (0,5 %); оболонка капсули: желатин, барвник: оксид цинку.

Країна походження основного інгредієнта відрізняється від країни походження продукту.

Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело магнію та вітаміну В6.

Твердження про поживну цінність: магній сприяє нормальній роботі нервової системи, зменшенню втоми та втомлюваності, підтриманню електролітного балансу, нормальній функції м'язів. Також магній сприяє нормальній психічній діяльності, підтриманню нормального стану кісток, зубів та відіграє важливу роль у процесі поділу клітин. Вітамін В6 сприяє нормальній роботі нервової системи, нормальному метаболізму білків та глікогену, нормальній психічній діяльності, нормальній роботі імунної системи. Вітамін В6 сприяє нормальному енергетичному метаболізму, зниженню втоми та втомлюваності.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання: 1 місяць. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання: при одночасному споживанні препаратів заліза інтервал між прийомом НейромінерійTM та даних засобів має становити 2-3 години. Рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Застереження щодо споживання: не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, дитячий вік до 18 років, гломерулонефрит або пієлонефрит в стадії загострення.

Форма випуску: капсули з масою вмісту 555 мг (mg) $\pm$ 7,5 % №30 у блістерах, упакованих у картонну коробку.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «СВЕТАН», Україна, 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 14/33, кв. 104;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 04208, м. Київ, просп. Європейського Союзу (Правди), 80-В.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015

13.Карта продукту

Ключове повідомлення

Нейромінерій-морський магній Сімаг, підсилений віт. В6 та віт. В13-висока біодоступність та пролонгований ефект.

Позиціонування

Нейромінерій — унікальна комбінація морського магнію з оротовою кислотою при хронічному стресі та виснаженні.

Який:

- ефективно поповнює дефіцит магнію завдяки біодоступній формі Simag™ 55;
- зменшує м'язові спазми та покращує нервово-м'язову провідність;
- сприяє відновленню енергетичного потенціалу клітин і підтримує фізичну витривалість.

Тому що містить:

- **Оротову кислоту (вітамін В13)** — підтримує метаболізм глюкози, внутрішньоклітинні резерви АТФ та енергію; покращує клітинний енергетичний метаболізм.
- **Морський магній Simag™ 55** — високоякісна природна форма магнію, що легко засвоюється та сприяє стабільному поповненню запасів магнію в організмі.
- **Вітамін В6** — ключовий кофактор нервової системи, який підсилює дію магнію та зменшує прояви стресу.

13.Конкуренти

Ключові конкуренти

Магне В6 та Магнікум



Конкуренти

Магне В6 № 60/ Магнікум №50

Склад: 1 таблетка містить магнію лактату дигідрату 470 мг (що відповідає 48 мг Mg^{2+}) та піридоксину гідрохлориду (вітаміну B6) 5 мг;

Спосіб застосування : Дорослим: 6–8 таблеток на добу з розподілом загальної дози на 2 або 3 прийоми під час їжі.

Слабкі сторони:

- **Спосіб застосування:** Велика кількість таблеток на добу — незручність і зниження комплаєнтності
- **Не має пролонгованої дії**, швидко виводиться з організму (Відсутність фіксатора Mg)
- **Оболонка :** Наявність титану діоксиду (E171), який заборонено в ЄС через потенційну генотоксичність, а також сахарози й тальку — небажаних компонентів у складі оболонки.



Конкуренти

Метіда пор. по 2 г №30

Склад: цитрат магнію – 1970 мг, в перерахунку на елементарний магній – 300 мг, вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) – 30 мг.

Спосіб застосування : по 1 саше на добу

Слабкі сторони:

- **Дозування В6** – 30 мг (нудота, рекомендова доза 12 мг/добу)
- **Незручна форма** - Потрібно розводити з водою
- **Побічні ефекти:** цитрат магнію часто викликає діарею
- Відсутність фіксатора Mg
- **Велика доза піридоксину**, яка може спричиняти нудоту, печію, спазми в шлунку, особливо при одноразовому прийомі на порожній шлунок або без їжі.



Конкуренти

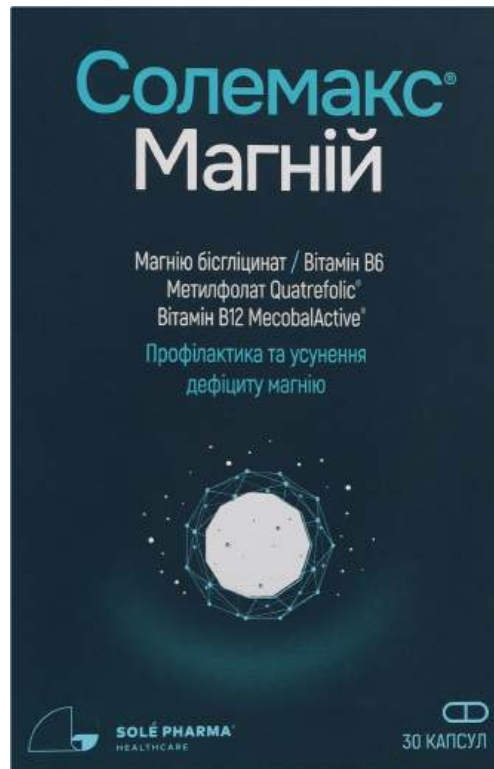
Мagneквін капсули №30

Склад: магнею бiсгліцинат — 300 mg (мг),
вітамін B₆ (Піридоксаль-5-фосфат) — 25 mg (мг)

Спосіб застосування : по 1 капсулі 1-2 рази на добу

Слабкі сторони:

- **Дозування (300 мг магнею бiсгліцинат = 45мг елементарного Mg)**
B₆ – 25мг(нудота, рекомендова доза 12 мг/добу)
- **Протипоказання :** Період лактації
- Відсутність фіксатора Mg
- **Оболонка :** Наявність титану діоксиду (E171), який заборонено в ЕС через потенційну генотоксичність



Конкуренти

Солемакс® Магній капсули №30

Склад: магнію бісгліцинат – 490 мг (елем. Mg – 100 мг),
вітамін B₆ (П-5-Ф) – 10 мг, метилфолат – 400 мкг, вітамін B₁₂ – 9 мкг

Спосіб застосування : по 1–2 капсули 1–2 рази на добу

Слабкі сторони:

- **Дозування Mg: 490 мг** бісгліцинату = лише 100 мг елементарного Mg (на відміну від 250 мг у НейромінерійТМ)
- **B6 – 10 мг** (рекомендована доза при стресі ≥ 25 –30 мг/добу; у НейромінерійТМ – 5,4 мг у формі піридоксину гідрохлориду, ефективніший для стресу)
- **Відсутність оротової кислоти** — немає «фіксатора Mg», немає підтримки синтезу АТФ та нейропротекції
- **Протипоказання:** Період лактації, дитячий вік
- **Стеарат магнію у складі** — допоміжна речовина, що може знижувати всмоктування активних компонентів



Конкуренти

Мagneфар® B6 таблетки №60

Склад: магнію гідроаспарагілату тетрагідрат – 500 мг (відп. 34 мг Mg^{2+}); піридоксину гідрохлорид – 5 мг; допоміжні: МКЦ, магнію стеарат, гіпромелоза

Спосіб застосування : 1–2 табл. 3 рази на добу після їди, запиваючи 200–250 мл води

Слабкі сторони:

- **Лише 34 мг** елементарного Mg на таблетку — щоб отримати 250 мг (як у НейромінерійТМ) потрібно ~7 таблеток на добу
- **Спосіб застосування:** до 6 таблеток на добу (3 рази) — незручність, знижує комплаєнтність пацієнтів
- **Відсутність оротової кислоти** — немає фіксатора Mg, немає підтримки синтезу АТФ та нейропротекції
- **Протипоказання:** важка ниркова недостатність, АВ-блокада, артеріальна гіпотензія, міастенія гравіс, гіпервітаміноз B6, порушення абсорбції у кишечнику, одночасне застосування з леводопою

13.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: НЕЙРМІНЕРІЙ

Ендокринолог:

1. IP
2. Метаболічний синдром
3. Гіпо-гіпертиреоз

Неврологи:

1. Хронічний стрес
2. Астенія
3. Мігрень
4. Судоми
5. Тривожність

СКРИПТ ДО ЛІКАРЯ НЕВРОЛОГА

S — Ситуація

Лікарю, погодьтеся що зараз багато пацієнтів звертаються зі скаргами на втому, слабкість, дратівливість. На фоні стресу можуть посилюватися м'язові посмикування та судоти.

P — Проблема

Стрес і перевантаження виснажують нервову систему. Організму потрібна додаткова підтримка.

I — Наслідок

Якщо цей стан триває довго, пацієнти починають гірше переносити звичне навантаження. Посилюються прояви астенії, знижується концентрація та якість сну. На фоні стресу можуть частіше виникати м'язові посмикування або судомні прояви.

N — Рішення

У таких випадках важливо підтримати нервову систему комплексно.

Нейромінерій містить магній, оротову кислоту та вітамін B6.

Магній підтримує нервово-м'язову функцію, оротова кислота - клітинний ресурс, а вітамін B6 сприяє роботі нервової системи та засвоєнню магнію.

Призначте Нейромінерій 3–5 пацієнтам на тиждень зі скаргами на астенію, стрес, м'язові посмикування або судомні прояви — для формування власного клінічного досвіду.

СКРИПТ ДО ЛІКАРЯ ЕНДОКРИНОЛОГА

S — Ситуація

Лікарю, погодьтеся що зараз багато пацієнтів з ІР та ожирінням часто скаржаться на втому, зниження активності та концентрації?

P — Проблема

Метаболічні порушення при інсулінорезистентності, ожирінні та діабеті впливають не лише на рівень глюкози, а й на роботу нервової системи. Через зміни енергетичного обміну клітини працюють менш ефективно, що може проявлятися втомою та зниженням активності.

I — Наслідок

Коли метаболічні порушення зберігаються тривалий час, пацієнти швидше виснажуються та стають менш активними та може посилюватися відчуття втоми. У результаті погіршується якість життя та складніше досягати стабільного контролю стану пацієнта.

N — Рішення

У таких випадках важливо підтримати нервову систему та енергетичний ресурс організму.

Нейромінерій містить комбінацію, яка підтримує роботу нервової системи та бере участь в енергетичному обміні. Призначте

Нейромінерій 3–5 пацієнтам на тиждень зі скаргами на втому, прояви діабетичної нейропатії, інсулінорезистентність або ожиріння для формування власного клінічного досвіду.

ГІППОМІЦЕЛ



Дієтична добавка

Гіппоміцел™

Листок-вкладиш

Вміст в 1 капсулі:

Екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого (*Hericium erinaceus*) 10:1 – 550 мг (mg).

Склад: екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого (10:1), наповнювач: целюлоза мікрокристалічна, антизлежувальні агенти: кальцію стеарат та кремнію діоксид колоїдний безводний, капсула: желатин, барвник: оксид цинку.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу після споживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря. Термін споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Не рекомендовано вагітним і жінкам під час лактації, дітям до 18 років. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску: тверді желатинові капсули з масою нетто (вмісту) 680 мг (mg) $\pm$ 9 %, по 10 капсул у блістері, 3 блістери у картонній коробці з листком-вкладкою.

Умови зберігання: в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С та відносної вологості повітря не більше 75 %.

Строк придатності «Вжити до» та номер партії виробництва: вказаний на упаковці.

Виробник, оператор ринку, відповідальний за інформацію для споживача та фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: ТОВ «АКТИЛАЙФ НУТРИШН», Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б; тел.: +38 (050) 703 10 00.

Замовник та власник торговельної марки для товарів і послуг: ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110,

м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

тел.: +38 (044) 592 68 62; www.behealth.com.ua.

Згідно з ТУ У 10.8-44611762-001:2023

14.Карта продукту

Ключове повідомлення

Гіппоміцел - сучасна підтримка когнітивних функцій на основі
їжовика гребінчастого

Позиціонування

Гіппоміцел - природна підтримка когнітивних функцій на основі екстракту гриба їжовик гребінчастий, спеціально створений для пацієнтів із когнітивною втомою та зниженням концентрації уваги

Який:

- підтримує концентрацію уваги та когнітивну працездатність;
- сприяє підтримці пам'яті та нейропластичності;
- допомагає зберігати ментальний ресурс в умовах стресу та високого навантаження

Тому що містить:

екстракт гриба їжовик гребінчастий (*Hericium erinaceus*) , який асоціюється з підтримкою нейропластичності та функціонального стану нервової системи

14.Конкуренти

Ключові конкуренти

БІФРЕН/НООБУТ



ГІППОМІЦЕЛ™

VS

Біфрен 250 мг

СЛАБКІ МІСЦЯ

- ✗ Синтетичний цитиколін — хімічне походження
- ✗ Призначається до 6 капсул
- ✗ Може викликати ряд побічних дій
- ✗ Вища вартість курсу терапії

ПЕРЕВАГИ ГІППОМІЦЕЛУ™

- 1 100% натуральний рослинний екстракт
- 2 Зручний прийом-1 капсула на добу
- 3 Унікальний NGF-механізм — діє на першопричину
На відміну від цитиколіну, стимулює синтез нейротрофічного фактора росту
- 4 Доступна ціна — економніший курс

НЕЙРОКСОН



ГІППОМІЦЕЛ™

VS

Нейроксон 500 мг

СЛАБКІ МІСЦЯ

- ✗ Синтетичний препарат — не природне походження
- ✗ Частіше використовується при гострих станах
- ✗ Ефект залежить від дози та схеми прийому: 2-3 рази на добу
- ✗ Висока вартість на місяць терапії

ПЕРЕВАГИ ГІППОМІЦЕЛУ™

- 1 Природний NGF-стимулятор замість синтезу ХФГ
Еринацини та геріценони — натуральні молекули гриба, не синтетика
- 2 Підходить для тривалої підтримки
- 3 1 капсула на добу — простіший режим
- 4 Значно доступніша ціна курсу

КВАНІЛ



ГІППОМІЦЕЛ™

VS

Кваніл 500 мг

СЛАБКІ МІСЦЯ

- ✗ Синтетичний цитиколін
— хімічне виробництво (аналог Нейроксону)
- ✗ Призначається по 3 т/д
- ✗ Частіше використовується при гострих станах
- ✗ Вища вартість
порівняно з добавкою

ПЕРЕВАГИ ГІППОМІЦЕЛУ™

- 1 Стимулює NGF — діє на причину, не симптом
Відновлення нейротрофічного фактора vs пасивна нейропротекція цитиколіном
- 2 Зручний режим 1 к/д
- 3 Підходить для тривалої підтримки
- 4 Доступна ціна

ГРИБ ІЖОВИК



ГІППОМІЦЕЛ™

VS

OstroVit ТА NOW Foods
Їжовик Lion's Mane

СЛАБКІ МІСЦЯ

×

Порошок гриба містить усю грибну масу, тоді як екстракт дозволяє концентрувати активні сполуки

×

2 капсули на добу

×

Спортивне харчування, не фармацевтичний стандарт

ПЕРЕВАГИ ГІППОМІЦЕЛУ™

1

Плодове тіло, асоціюється з більш стандартизованим вмістом біоактивних речовин

2

1 капсула на добу

3

Повна стандартизація фармацевтичного рівня
Гарантований вміст активних речовин у кожній капсулі

14.Скрипти

СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПАТОЛОГІЇ З ЯКИМИ ПРАЦЮЄМО: ГІППОМІЦЕЛ

Неврологи:

- Легкі когнітивні порушення(у молодого та похилого віку пацієнта)
- Тривалий стрес
- Зниження концентрації уваги
- Когнітивна втома

СКРИПТ ДО НЕВРОЛОГА

S — (Ситуація)

Докторе, зараз на фоні хронічного стресу та високого ментального навантаження багато пацієнтів скаржаться на когнітивну втому, зниження концентрації або погіршення пам'яті. Це відслідковується навіть у молодих пацієнтів.

P — (Проблема)

Погодьтеся, основа проблеми полягає у порушенні нейропластичності. Традиційні симптоматичні засоби не впливають на механізм відновлення.

I — (Наслідок)

Коли стрес і когнітивне перевантаження тривають довго, пацієнти починають гірше концентруватися, швидше виснажуються та скаржаться на погіршення пам'яті. У результаті знижується когнітивна продуктивність і погіршується адаптація до щоденного навантаження.

N — (Рішення)

У таких випадках важливо підтримати не лише симптоми, а й механізми когнітивного відновлення. Гіппоміцел підтримує нейропластичність через NGF, концентрацію та когнітивний ресурс у пацієнтів із когнітивною втомою.

Призначте Гіппоміцел 3–5 пацієнтам на тиждень зі скаргами на когнітивну втому, ментальне виснаження та стрес-асоційовані когнітивні порушення для формування власного досвіду.

ТАРНІТИН



**Дієтична добавка
ТАРНІТИН**

Листок-вкладиш (Інформація для споживачів)

Вміст в 1 капсулі:

Інгредієнт	1 капсула	Максимальна добова кількість (4 капсули)
L-карнітину L-тартрат	500 мг (mg), (що відповідає 340 мг (mg) чистого L-карнітину)	2000 мг (mg), (що відповідає 1360 мг (mg) чистого L-карнітину)

Рекомендації щодо споживання:

в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело L-карнітину.

Не є лікарським засобом.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

вживати дорослим по 2 капсули двічі на добу (4 капсули на добу), до їди. Капсули слід ковтати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю питної води. Особам з підвищеним фізичним навантаженням капсули можна приймати за 30–60 хвилин до тренування.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання:

8–12 тижнів. У подальшому термін споживання та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Особливості щодо споживання:

рекомендовано споживати повноцінний та збалансований раціон харчування.

Застереження щодо споживання:

не перевищувати зазначену рекомендовану добову кількість для щоденного споживання. При додатковому вживанні L-карнітину з інших джерел (харчових продуктів чи інших добавок) слід враховувати сумарну добову кількість. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання:

індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого з компонентів дієтичної добавки, дитячий вік до 18 років, період вагітності та годування груддю.

Форма випуску:

капсули №90

Умови зберігання:

зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «АКТИЛАЙФ НУТРИШН», Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, с-ще Ворзель, вул. Курортна, 4-6; тел.: +38 (050) 705 10 00.

Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт:

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41; тел.: +38 044 592 68 62; www.behealth.com.ua

15.Картка продукту

Тарнітин — реальна доза чистого карнітину для енергії



ТАРНІТИН ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Тарнітин — реальна доза чистого карнітину (1360 мг/добу) для енергії

ЯКИЙ:

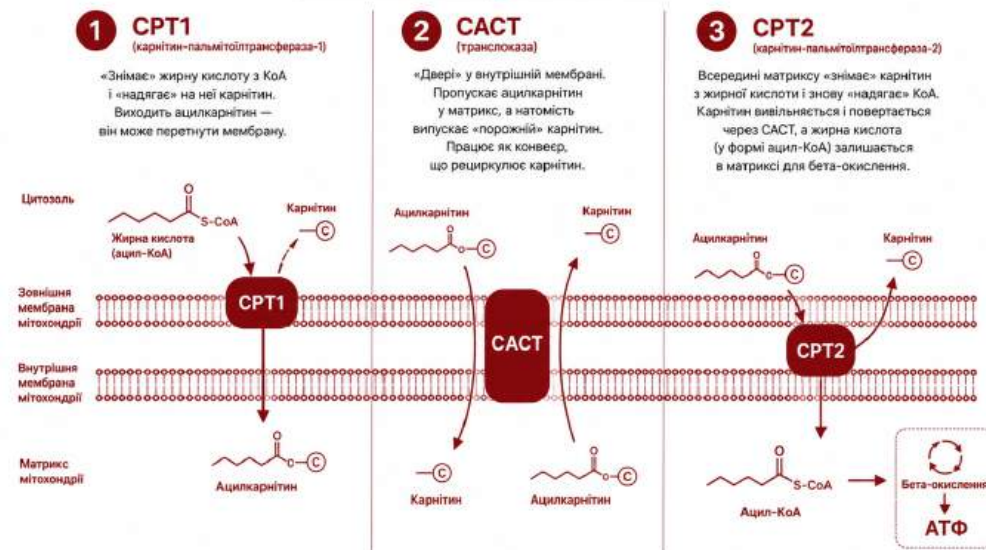
1. Забезпечує енергетичний обмін м'яза
2. Покращує обмін жирних кислот при метаболічному синдромі та ЦД2
3. Безпечний навіть при діабеті

ТОМУ ЩО МІСТИТЬ:

- L-КАРНІТИНУ L-ТАРТРАТ 500 мг/капсула (340 мг чистого карнітину) — стабільну сіль з однією з найвищих часток чистого карнітину серед капсульних форм (68% маси), без домішки лізину, вітамінів групи В чи інших компонентів, які «розмивають» дозу.
- Покращує роботу карнітинового човника - забезпечуючі безперервну роботу транспорту жирних кислот в мітохондріях
- Не містить цукру — безпечний варіант для пацієнта з діабетом чи метаболічним синдромом;

МЕХАНІЗМ ДІЇ ТАРНІТИН

Три кроки човника



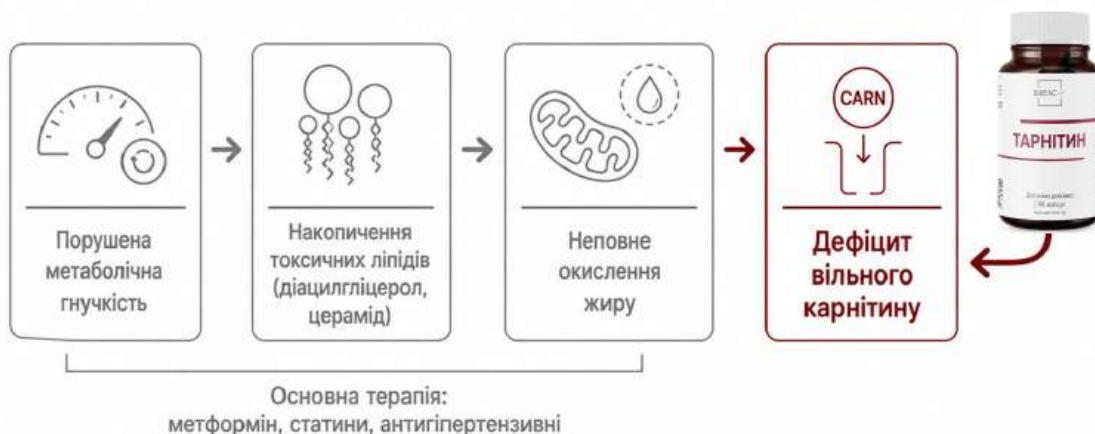
1. Транспорт жирних кислот у мітохондрії («карнітиновий човник»)

- L-карнітин переносить довголанцюгові жирні кислоти через мітохондріальну мембрану, де вони проходять бета-окислення з утворенням енергії (АТФ).

2. Підтримка енергетичного обміну при підвищеній потребі

- Потреба в карнітині зростає при підвищеному фізичному навантаженні, обмеженому раціоні (вегетаріанство/веганство), хронічній втомі та в період відновлення після хвороби.
- Тарнітин заповнює цей дефіцит готовою, високою дозою чистого карнітину незалежно від якості надходження з їжі.

Одна конкретна ланка для Тарнітину



Тарнітин заповнює пул вільного карнітину

Одна конкретна ланка для Тарнітину



15.Конкуренти

КЛЮЧОВІ КОНКУРЕНТИ

КАРДОНАТ (Сперко Україна) — лідер ринку, 64,9% частки (2025), 65,5% (1П 2026)

Тарнітин VS Кардонат

Доза вирішує все

ТАРНІТИН	VS	КАРДОНАТ
		
 1360 мг чистого карнітину		 ~100 мг карнітину, розмито вітамінами
 Моно-препарат		 Комбінований засіб (5 компонентів)
 Без барвників		 Містить азо-барвники E110/E124 
 №90, чиста капсула		 №20, потрібно більше упаковок на курс

Склад:

карнітину хлорид, лізину гідрохлорид, кобамамід, вітаміни B1, B6, B12, кокарбоксилаза; оболонка капсул містить азобарвники E110/E124.

Спосіб застосування:

капсули, курс за схемою лікаря, зазвичай кілька капсул на добу протягом 3-4 тижнів.

Мінус:

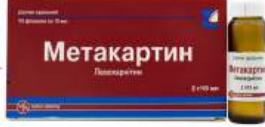
субтерапевтична доза карнітину (орієнтовно 300–600 мг/добу залежно від схеми прийому) — фактично вітамінний комплекс, де карнітин є допоміжним, а не основним компонентом; містить синтетичні азобарвники E110/E124, щодо яких існує регуляторне застереження ЄС (дослідження Саутгемптона щодо впливу на активність і увагу дітей).

ХПВ:

1. Тарнітин дає 1360 мг чистого карнітину на добу — це вище за субтерапевтичну дозу Кардонату (300–600 мг), тому лікар може розраховувати на клінічно значущу дозу, а не на слідову кількість у складі вітамінного комплексу.
2. Тарнітин — моно-склад без домішок лізину й вітамінів групи В, тому лікар точно контролює, яку речовину і в якій дозі отримує пацієнт, на відміну від Кардонату, де внесок карнітину неможливо відділити від вітамінного компонента.
3. Тарнітин не містить цукру, тому його можна впевнено рекомендувати пацієнту з діабетом чи метаболічним синдромом.
4. Тарнітин не містить азобарвників E110/E124 (на відміну від Кардонату), тож пацієнт отримує склад без компонента з регуляторним застереженням ЄС.

МЕТАКАРТИН (World Medicine) — стабільний №2, 14,7% ринку (1П 2026)

Тарнітин VS Метакартину

ТАРНІТИН	VS	МЕТАКАРТИН
		
 Готова капсула		 Розведення розчину
 Присутній в ендокринології		 0% — відсутній повністю
 Без консервантів		 Містить натрію бензоат
 Для енергії та втоми		 Для хірургії й загоєння ран

 **Різні пацієнти, різні кабінети — Тарнітин заходить туди, де Метакартину практично немає.**

Склад:

L-карнітин, оральний розчин; консервант натрію бензоат (E211), сахарин натрію, ароматизатор.

Показання за інструкцією:

підтверджений первинний/вторинний дефіцит карнітину (генетичні порушення обміну, пацієнти на гемодіалізі) — вузька рецептурна ніша. За реальним профілем призначень топ-діагноз — хронічна виразка шкіри: препарат хірургії й загоєння ран, присутність в ендокринологічному кабінеті — практично відсутня (0%).

Спосіб застосування:

розчин, потребує розведення дозуючим шприцом перед кожним прийомом.

Мінус:

рецептурний ЛЗ вузької ніші, не позиціонований під загальну втому чи енергетичну підтримку; незручна форма (розведення розчину); консервант E211 у складі; вища ціна за грам чистого карнітину (≈33 грн/г проти ≈27–28 грн/г у Тарнітину).

ХПВ:

1. Тарнітин — готова капсула для щоденного прийому, тоді як Метакартин потребує розведення розчину дозуючим шприцом перед кожним прийомом — це менш зручно для щоденного амбулаторного курсу.
2. Тарнітин не містить консерванту натрію бензоату (E211), на відміну від Метакартину.
3. Тарнітин заходить у нішу (ендокринологія, загальна втома, метаболічні стани), де Метакартин практично не присутній (0% призначень в ендокринології) — це різні території, а не пряма боротьба за одного пацієнта.

ЛЕКАРНІТА (Perrery Farmaceutici) — зростаючий конкурент №3, 11,7% ринку (1П 2026)

Тарнітин VS ЛеКарніта

ТАРНІТИН	ЛЕКАРНІТА
	
 Готова капсула	 Розведення розчину
 Без цукру	 Фруктоза + сорбіт у складі
 Моно-склад	 Карнітин + аргінін

 **Тарнітин - безпечний прийом при діабеті й метаболічному синдромі — там, де конкурент вимагає застережень.**

Склад:

L-карнітин (левокарнітин)+аргінін.

Мінус:

розчин, потребує розведення дозуючим шприцом перед кожним прийомом

ХПВ:

1. Тарнітин - безпечний прийом при діабеті й метаболічному синдромі - там де конкурент вимагає застережень.

15.Скрипти

Спеціальність	Основні патології	Ключовий аргумент для візиту
Кардіолог	Ішемічна хвороба серця	готова висока доза карнітину для роботи міркарда
Ендокринолог	ЦД 1 та 2 типу, метаболічний синдром, гіпотиреоз	справжня доза карнітину, яку можна дати навіть діабетику (без цукру)
Невролог	Астенічний синдром, хронічна втома, поствірусна астения (Long COVID)	загальноенергетичний механізм — покращення енергетичної функції в неврологічних пацієнтів
Колопроктолог	Хронічні крововтрати, післяопераційний період (геморой, тріщини)	непрямий місток: підтримка енергообміну в період відновлення
Сімейний лікар / терапевт	Загальна втома, обмежений раціон, підвищене фізичне навантаження	проста, безпечна щоденна підтримка без цукру й барвників

1. Астенічний синдром / хронічна втома (невролог, сімейний лікар)

S — Ситуація

«Лікарю, чи часто до Вас звертаються пацієнти зі скаргами на хронічну втому, слабкість, знижену працездатність, коли аналізи в межах норми?»

P — Проблема

«У частини таких пацієнтів є недооцінений дефіцит карнітину — ключового переносника жирних кислот у мітохондрії, через що клітини недоотримують енергію».

I — Наслідки

«Без корекції дефіциту втома зберігається місяцями, пацієнт повторно звертається, а причина залишається невирішеною».

N — Рішення (Тарнітин)

«Тарнітин дає 1360 мг чистого L-карнітину на добу — реальну дозу для підтримки енергетичного обміну, без цукру й барвників. Порекомендуєте 3–5 пацієнтам зі скаргами на хронічну втому?»

2. Метаболічний синдром / цукровий діабет (ендокринолог)

S — Ситуація

«Чи є серед ваших пацієнтів з діабетом чи метаболічним синдромом ті, хто скаржиться на постійну втому й слабкість?»

P — Проблема

«Стандартні карнітинові препарати часто містять фруктозу чи сорбіт в складі — і це проблема саме для цієї групи пацієнтів».

I — Наслідки

«Лікар змушений або відмовитись від підтримки карнітином, або призначити засіб, що суперечить дієтичним рекомендаціям пацієнта».

N — Рішення (Тарнітин)

«Тарнітин — єдиний вибір без цукру серед капсульних форм — справжня доза карнітину, яку можна дати навіть діабетику. Спробуємо на кількох пацієнтах?»

ЗАГАЛЬНИЙ СКРИПТ ВІЗИТУ

Вступна частина:

Доброго дня! Як завжди, радий/а бачити Вас. Хотів/ла б обговорити сучасний підхід до енергетичної підтримки пацієнтів і представити препарат, який може бути корисним у Вашій практиці.

Опис ситуації:

Як Ви оцінюєте частку пацієнтів, які скаржаться на хронічну втому чи знижену працездатність без чіткої органічної причини? Я впевнений/а, що щодня до Вас звертаються такі пацієнти.

Проблематика:

Як правило, у частини таких пацієнтів є недооцінений дефіцит карнітину — ключового переносника жирних кислот у мітохондрії. Які препарати Ви обираєте найчастіше для такої підтримки?

Актуалізація:

Як Ви вважаєте, якщо не коригувати цей дефіцит, чи може це призводити до хронізації астенії, повторних візитів і зниження якості життя пацієнта? Чи згодні Ви, що препарат з реальною терапевтичною дозою чистого карнітину здатний вирішити це питання ефективніше, ніж вітамінний комплекс із слідовою кількістю карнітину?

Направлення:

Що для Вас є ключовим при виборі карнітинового препарату для пацієнта? Я впевнений/а, що Вам важлива реальна доза, чистий склад і зручність прийому — саме це пропонує Тарнітин.

- Астенічний синдром, хронічна втома, поствірусна астенія
- Метаболічний синдром, ЦД 1 та 2 типу — потреба у без цукровому варіанті
- Ішемічна хвороба серця - потреба карнітину для серцевого м'яза (міокарда)
- Хронічні крововтрати та післяопераційний період — додаткова підтримка відновлення
- Вегетаріанці/вегани, підвищене фізичне навантаження — профілактичне поповнення карнітину